Guide de l’utilisateur

Enquête sur la santé mentale et l’accès aux soins (ESMAS)

Août 2024

Statistics Canada Statistique Canada

Canada

Pour obtenir plus d'information
Toute demande de renseignements concernant le présent produit et les statistiques ou services connexes doit être adressée à :

Statistique Canada
Services à la clientèle
Centre de données sur la santé de la population
Courriel : hd-ds@statcan.gc.ca

Accéder aux renseignements et passer une commande
L'Enquête sur la santé mentale et l'accès aux soins (ESMAS) produit trois types de fichiers de microdonnées : le fichier maître, le fichier de partage et le fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD). Le fichier maître et le fichier de partage ont été diffusés en septembre 2023.

Pour plus de renseignements, consultez la page web suivante :
http://www.statcan.gc.ca/fr/microdonnees/centres-donnees

Fichiers maîtres
Les fichiers maîtres contiennent toutes les variables et tous les enregistrements recueillis lors de l'enquête et de sources administratives. Ces fichiers sont accessibles, moyennant un coût, à Statistique Canada pour un usage interne et dans les centres de données de recherche (CDR) de Statistique Canada, par l'intermédiaire de l'accès à distance en temps réel (ADTR) et dans le laboratoire virtuel de données (LVD). Les fichiers maîtres peuvent aussi faire l'objet de demandes de totalisations personnalisées.

Centre de données de recherche
Le Programme des CDR permet aux chercheurs d'utiliser les données d'enquête contenues dans les fichiers maîtres dans un environnement sécuritaire situé dans plusieurs universités à travers le Canada. Les chercheurs doivent soumettre des propositions de recherche qui, une fois acceptées, leur donneront accès aux CDR.

Accès à distance en temps réel
Le système d'ADTR est une installation d'accès à distance en ligne permettant aux utilisateurs d'exécuter des programmes SAS en temps réel sur des ensembles de microdonnées situés dans un endroit central et sécurisé. Les chercheurs se servent des programmes SAS pour extraire les résultats sous forme de tableaux de fréquences. La confidentialité des microdonnées est automatisée dans le système ADTR. Les chercheurs doivent remplir un formulaire de demande d'accès au système ADTR.

Laboratoire virtuel de données
Le LVD est un centre d'accès infonuagique aux microdonnées qui permet aux chercheurs autorisés d'accéder à distance aux données hébergées par Statistique Canada au moyen d'une connexion informatique sécurisée et d'un environnement infonuagique protégé.

Totalisations personnalisées
Une autre méthode d'accès aux fichiers maîtres consiste à offrir à tous les utilisateurs de faire appel au personnel du service à la clientèle du Centre de données sur la santé de la population pour produire des totalisations personnalisées. Ce service est offert moyennant le recouvrement des coûts. Il permet aux utilisateurs qui ne savent pas se servir de logiciels de totalisation d'obtenir des résultats personnalisés. Les résultats sont filtrés pour s'assurer qu'ils sont conformes aux normes de confidentialité et de fiabilité avant d'être diffusés. Pour plus de renseignements, communiquez avec le service à la clientèle au hd-ds@statcan.gc.ca.

Fichiers de partage
Les fichiers de partage contiennent tous les enregistrements des répondants de l'SEMAS qui ont accepté de partager leurs données avec les partenaires de partage de Statistique Canada. Le fichier de partage n'est fourni qu'à ces organisations. Les identificateurs personnels sont retirés

des fichiers de partage pour préserver la confidentialité des répondants. Un contrat de licence pour l'utilisation des microdonnées doit être signé avant la diffusion du ou des fichiers. La personne responsable du fichier de données doit fournir son nom et ses coordonnées. Les utilisateurs de ces fichiers doivent au préalable avoir porté serment qu'ils ne divulgueront en aucun temps toute information susceptible d'identifier un répondant à l'enquête.

Fichiers de microdonnées à grande diffusion
Les fichiers de microdonnées à grande diffusion sont élaborés à partir des fichiers maîtres suivant une technique qui vise à concilier l'impératif d'assurer la confidentialité des répondants et la nécessité de produire des données d'utilité maximale. Les FMGD doivent répondre à des normes sévères de sécurité et de confidentialité, conformément à la Loi sur la statistique avant qu'ils ne soient diffusés pour l'accès public. Pour s'assurer du respect de ces normes, chaque FMGD est soumis à un processus officiel d'examen et d'approbation par un comité formé de haut gestionnaire de Statistique Canada. Les variables les plus susceptibles de permettre l'identification d'une personne sont supprimées du fichier ou agrégées en catégories moins détaillées.

Une correction mineure a été apportée à la version de ce guide de l'utilisateur publiée en juin 2024. Le nom de la variable pour les poids a été changé de "WTMP" à "WTS_M" dans les exemples fournis à la page 30.

Table des matières

1.0 Introduction 7

2.0 Contenu de l'enquête 8

2.1 Sélection des modules 8
2.2 Essai qualitatif 11

3.0 Méthodologie d'enquête 11

3.1 Population cible et population observée 11
3.2 Base de sondage 11
3.3 Taille et répartition de l'échantillon 11
3.4 Sélection des personnes interviewées 12

4.0 Collecte des données 12

5.0 Traitement des données 13

5.1 Vérification 13
5.2 Codage des questions ouvertes 13
5.3 Création de variables dérivées 13
5.4 Variables couplées sur le revenu 14
5.5 Pondération 14
5.6 Imputation 14
5.6.1 Revenu 14
5.6.2 Code postal 15
5.6.3 Genre 15
5.7 Contrôle de la divulgation 15

6.0 Poids d'enquête et poids bootstrap 15

6.0 16
6.1 Aperçu 16
6.2 Poids initial (wgtT0) 16
6.3 Poids ajustés selon la portée (wgtT5) 16
6.4 Poids ajusté en fonction de la non-réponse (wgtT6) 17
6.5 Méthode d'estimation de Winsor (wgtT7) 17
6.6 Poststratification (wgtT8) 17
6.7 Poids du fichier partagé 18
6.8 Poids bootstrap 18

7.0 Qualité des données 19

7.1 Erreurs dans l'enquête 19
7.2 Erreurs non dues à l'échantillonnage 19
7.2.1 Non-réponse 19
7.2.2 Erreurs de couverture 20
7.2.3 Erreurs de mesure 21
7.2.4 Erreurs de traitement 21
7.3 Erreur d'échantillonnage 22
7.4 Évaluation des biais 23

8.0 Lignes directrices pour la totalisation, l'analyse et la diffusion de données 23

8.1 Lignes directrices pour l'arrondissement d'estimations 24
8.2 Lignes directrices pour la pondération de l'échantillon en prévision de la totalisation 24
8.3 Lignes directrices pour l'analyse statistique 25
8.4 Lignes directrices relatives à la qualité pour la diffusion 25
8.5 Lignes directrices pour l'analyse statistique, l'estimation de la variance et la construction des intervalles de confiance 29

Annexe A : Comparaison de variables, 2012 ESCC - Santé mentale et 2002 ESCC - Santé mentale et Bien-être et Enquête sur la santé mentale et l'accès aux soins 2022 32

Annexe B : WHO-CIDI Troubles mentaux et troubles liés à une substance - Variables primaires pour l'analyse et variables comparables pour 2022, 2012 et 2002 144

1.0 Introduction

L'objectif de l'enquête sur la santé mentale et l'accès aux soins (ESMAS) était de recueillir des renseignements concernant l'état de la santé mentale des Canadiens, de même que l'accès et les besoins en matière de services et de soutien, qu'ils soient formels ou informels. Cette enquête visait à évaluer les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la santé de la population et à déterminer s'il y a des changements dans les tendances en matière de santé mentale, d'utilisation des services et de fonctionnement au cours des 10 dernières années.

L'Enquête sur la santé mentale et l'accès aux soins (ESMAS) est une enquête volontaire qui couvre la population de 15 ans et plus vivant dans les 10 provinces canadiennes au 1er mars 2022. Sont exclues du champ de l'enquête : les personnes vivant dans les réserves et autres établissements autochtones, les membres à temps plein des Forces canadiennes et les personnes vivant dans des logements collectifs, comme les établissements institutionnels. L'échantillonnage était sélectionné à partir de la base de sondage du long questionnaire du Recensement de 2021.

L'ESMAS 2022 était réalisée au moyen d'interviews téléphoniques assistées par ordinateur (ITAO) en raison de la pandémie de la COVID-19. Les données ont été recueillies du 17 mars au 31 juillet 2022.

Une enquête comportant bon nombre des mêmes questions, appelée Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Santé mentale (ESCC-SM), a été menée en 2012. Cela signifie que bon nombre des mêmes indicateurs peuvent être dérivés pour l'ESMAS et l'ESCC-SM afin d'évaluer les changements dans la santé de la population au cours de la décennie écoulée. Certains des mêmes indicateurs sont également disponibles dans l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes : santé mentale et bien-être, menée en 2002.

Il existe des différences importantes dans les méthodologies utilisées pour l'ESMAS et l'ESCC-MH qui doivent être prises en considération afin de comparer adéquatement les résultats de ces deux enquêtes. Ce guide de l'utilisateur décrit la méthodologie utilisée pour l'ESMAS et vise à fournir les informations nécessaires pour faciliter l'analyse à l'aide des fichiers de microdonnées.

Toutes les questions concernant l'ensemble de données ou son utilisation devraient être adressées à :

Statistique Canada
Services à la clientèle
Centre de données sur la santé de la population
Courriel : hd-ds@statcan.gc.ca

2.0 Contenu de l'enquête

La présente section renferme une discussion générale sur l'élaboration du contenu de l'enquête et résume le contenu final qui sera inclus dans l'ESMAS.

Une copie du questionnaire final et des spécifications connexes utilisées pour la collecte de données est accessible par l'intermédiaire du CDR.

Le contenu a été choisi en vue d'atteindre les objectifs d'enquête suivants :

- Évaluer l'état de la santé mentale des Canadiens en ce qui a trait aux continuums de la maladie mentale et d'une bonne santé mentale, en examinant divers troubles de santé mentale et de consommation, certains problèmes de santé mentale ainsi que certains aspects liés au bien-être;
- Évaluer l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur la santé de la population en examinant l'évolution des tendances en matière de santé mentale, d'utilisation des services et de fonctionnement depuis l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2012;
- Déterminer si l'on dispose d'un accès rapide, adéquat et approprié aux services et au soutien formels et informels en santé mentale, et évaluer le recours à ces services et à ce soutien, de même que les besoins perçus;
- Évaluer le niveau de fonctionnement, les capacités et les incapacités relativement à la santé mentale et à la maladie mentale;
- Examiner les liens entre la santé mentale et les variables ou caractéristiques sociales, démographiques, géographiques et économiques (covariables), y compris les comportements ayant une incidence sur la santé, les problèmes de santé et les expériences vécues pendant l'enfance.

2.1 Sélection des modules

Le contenu de l'ESMAS repose sur celui de l'ESCC – Santé mentale de 2012. Des questions ont été ajoutées ou modifiées afin de remédier à certaines lacunes statistiques relevées, ainsi que de satisfaire aux normes actuelles de Statistique Canada à l'égard du contenu harmonisé à utiliser dans les enquêtes.

Au total, 31 modules sur 39 recoupent ceux de l'ESCC – Santé mentale.

- De plus, 24 modules de l'enquête de 2012 sont repris tels quels ou avec certains changements mineurs seulement.
- Sept modules de l'enquête de 2012 sont repris avec des changements modérés ou majeurs.
- Huit modules sont nouveaux en 2022.

Des renseignements plus détaillés sur la comparaison des enquêtes de 2002, de 2012 et de 2022 sont fournis à l'*Annexe A – Comparaison de variables, 2012 ESCC - Santé mentale et 2002 ESCC - Santé mentale et Bien-être et Enquête sur la santé mentale et l'accès aux soins 2022* et *l'Annexe B – WHO-CIDI Troubles mentaux et troubles liés à une substance - Variables primaires pour l'analyse et variables comparables pour 2022, 2012 et 2002*.

Le tableau 1 donne un aperçu des concepts abordés dans l'ESMAS.

Tableau 1. Aperçu de l'Enquête sur la santé mentale et l'accès aux soins.

Utilisation principale	Module(s)	Description	Source / référence(s)
Déterminer la prévalence de certains troubles mentaux en fonction des critères du DSM-IV	Section dépistage (SCR) Contrôle de soi (DEP) Manie (MIA) Trouble d'anxiété généralisée (GAD) Phobie sociale (SOP) Consommation, abus, et dépendance à l'alcool (AUD) Drogues – consommation, abus et dépendance (SUD)	Pour obtenir de plus amples renseignements sur les algorithmes de notation, veuillez consulter la documentation qui porte sur les variables dérivées.	Composite International Diagnostic Interview (CIDI) de l'Organisation mondiale de la Santé
Évaluer le diagnostic de problèmes de santé chroniques (y compris certains problèmes de santé mentale)	Problèmes de santé chroniques (CCC)	Ce groupe de questions porte sur les problèmes de santé chroniques diagnostiqués par un professionnel de la santé qui ont duré ou qui devraient durer au moins six (6) mois.	Données recueillies précédemment pour certaines années de l'ESCC
Évaluer les indicateurs d'état de santé général (y compris la santé mentale)	État de santé général (GEN)	Parmi les indicateurs de l'état de santé général, mentionnons l'état de santé perçu, l'état de santé mentale perçu, la satisfaction à l'égard de la vie, le stress perçu et le sentiment d'appartenance à la communauté locale.	Ces indicateurs font partie intégrante du Cadre de qualité de vie de Statistique Canada. Ils ont été recueillis à partir de plusieurs enquêtes, dont l'ESCC sur une base annuelle.
Évaluer les indicateurs liés au suicide	Sous-bloc Suicide (SUI)	Les concepts évalués comprennent les idées suicidaires, la planification et les tentatives.	Données recueillies précédemment pour certaines années de l'ESCC
Évaluer le fonctionnement, les capacités et les incapacités en relation avec la santé mentale et la maladie mentale	Détresse (DIS) Douleurs et malaises (HUP) Plan d'évaluation des invalidités de l'OMS (DAS)	Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la documentation qui porte sur les variables dérivées.	DIS : « Kessler Psychological Distress Scale » HUP : Attribut de la douleur à partir du Heath Utility Index – 3. DAS : Plan d'évaluation des invalidités de l'OMS
Recueillir des données sur les besoins en matière de soins de santé mentale, ainsi	Services de santé mentale (SR1) Consommation de médicaments (MED)	Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la documentation qui porte	Outre celles de l'ESCC-SM de 2012, des questions tirées de ces modules ont été recueillies

que les services utilisés	Besoins perçus de soins (PNC)	sur les variables dérivées.	précédemment pour certaines années de l'ESCC.
Recueillir des données sur des facteurs associés à la santé mentale et à l'accès aux soins (y compris les comportements liés à la santé, les expériences vécues dans l'enfance et les mesures de bien-être social)	Sources de stress (STS) Échelle de provisions sociales (SPS) Interactions sociales négatives (NSI) Spiritualité (SPI) Expériences vécues dans l'enfance (CEX) Stress au travail (WST) Expériences de santé mentale (MHE) Effets de la santé mentale de la famille (FMI) Usage du tabac (SMK) Répercussions de la COVID-19 (IM) sur l'activité physique (PHS)	Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la documentation qui porte sur les variables dérivées.	Bon nombre de ces modules ont servi lors de certaines années d'enquête de l'ESCC.
Évaluer les caractéristiques démographiques	Âge (AN3) Sexe et genre (GDR) Renseignements sociodémographiques (SDC) Bloc minimal sur l'immigration (IMM) Identité autochtone (ABM) Module (PG) sur les groupes de population (PGM) Éducation (EDU) Bloc minimal des activités sur le marché du travail (LMAM)	Ces modules respectent les normes actuelles de Statistique Canada à l'égard du contenu harmonisé à utiliser dans les enquêtes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la documentation qui porte sur les variables dérivées.	
Ils ont été inclus pour recueillir des renseignements d'ordre administratif et demander notamment la permission de coupler et partager des données.	Renseignements administratifs (ADM) Validation des numéros d'assurance-maladie (HN) Coordonnées (CON)		

2.2 Essai qualitatif

L'examen des nouvelles sections du questionnaire a été effectué en anglais et en français par l'intermédiaire du Centre de ressources pour la conception de questionnaires (CRCQ) de Statistique Canada. Étant donné que la grande majorité du contenu a été copié de l'ESCC sur la santé mentale de 2012 avec des changements minimes, l'enquête n'a pas nécessité de tests qualitatifs approfondis. Veuillez consulter le Guide de l'utilisateur de l'ESCC sur la santé mentale de 2012 pour une description du processus de test qualitatif mené en 2010.

3.0 Méthodologie d'enquête

3.1 Population cible et population observée

LESMAS couvre la population de 15 ans et plus vivant dans les 10 provinces canadiennes au 1er mars 2022. Sont exclues du champ de l'enquête les personnes vivant dans les réserves et d'autres établissements autochtones, les membres à plein temps des Forces canadiennes et les personnes vivant dans des logements collectifs, comme les établissements institutionnels. En tout, ces exclusions représentent moins de 2,5 % de la population cible.

3.2 Base de sondage

La base de l'ESMAS représente l'ensemble des répondants du questionnaire détaillé du Recensement de 2021 qui a été mené auprès de la population de 15 ans et plus vivant hors réserve dans les 10 provinces canadiennes au 1er mars 2022. La population observée ne comprend pas les personnes qui ont immigré au Canada après la date de référence du recensement, soit le 11 mai 2021.

3.3 Taille et répartition de l'échantillon

L'ESMAS comporte un échantillon aléatoire simple stratifié et un plan transversal.

L'échantillon de 40 000 unités de l'ESMAS est réparti afin d'obtenir des estimations d'une précision sensiblement égale au sein de chacune des huit strates qui combinent le sexe binaire[1] et le groupe d'âge (15 à 24 ans, 25 à 44 ans, 45 à 64 ans et 65 ans et plus). L'enquête a été conçue pour procéder à un suréchantillonnage des gens qui considèrent appartenir à l'un des quatre grands groupes de population désignés au Canada comme étant des minorités visibles (Sud-Asiatique, Noir, Chinois, Philippin) afin de soutenir la publication des estimations correspondantes à l'échelle nationale. Au sein de chaque groupe d'âge et de genre, l'échantillon est réparti dans les strates des cinq groupes de population (« Sud-Asiatique », « Noir », « Chinois », « Philippin » et une strate « fourre-tout » « Autre » incluant le reste de la population cible) à l'aide d'une répartition de puissance de 0,5 en fonction de la taille relative de chacun d'entre eux.

La répartition de l'échantillon selon les strates est résumée au tableau 2.

[1] Une variable binaire de genre a été dérivée des réponses au recensement pour classer chaque personne comme un homme ou une femme uniquement à des fins d'allocation pour l'ESMAS.

Tableau 2. Taille de l'échantillon selon le groupe d'âge, le genre et le groupe de population.

Groupe d'âge	Genre	Philippin	Noir	Chinois	Sud-Asiatique	Autre	Total
15 à 24 ans	Homme	579	735	691	968	2 729	
	Femme	536	705	661	855	2 539	
	Total						**10 998**
25 à 44 ans	Homme	502	648	665	947	2 678	
	Femme	516	621	649	839	2 442	
	Total						**10 507**
45 à 64 ans	Homme	429	512	615	671	2 652	
	Femme	467	473	616	594	2 429	
	Total						**9 456**
65 ans et plus	Homme	276	363	584	571	2 725	
	Femme	343	382	580	536	2 678	
	Total						**9 039**
CANADA		**3 649**	**4 438**	**5 060**	**5 981**	**20 872**	**40 000**

3.4 Sélection des personnes interviewées

Le plan d'échantillonnage de l'ESMAS est à un degré[2]. Un échantillon aléatoire simple de personnes est sélectionné indépendamment dans chaque strate d'échantillonnage selon la répartition illustrée au tableau 2.

4.0 Collecte des données

L'ESMAS a été réalisée au moyen de questionnaires électroniques (QE) sur Internet, qui ont été testés dans les deux langues officielles tout au long de leur élaboration. Au cours de la période de collecte des données, 9 861 interviews valides ont été menées au total à l'aide d'une méthode d'enquête téléphonique administrée par un intervieweur (QE-i). Dans le cadre de l'ESCC – Santé mentale de 2012, nous avons utilisé une sorte d'interview assistée par ordinateur (IAO), appelée « interview sur place assistée par ordinateur » (IPAO). Par souci d'uniformité avec l'enquête menée en 2012, les intervieweurs ont suivi une formation poussée sur le contenu de l'enquête. De plus, les répondants de l'ESMAS n'étaient pas autorisés à remplir eux-mêmes le questionnaire de l'interview.

Les intervieweurs saisissaient directement les réponses aux questions de l'enquête au moment de l'interview téléphonique à l'aide d'un questionnaire automatisé qui reproduit l'application du questionnaire électronique. Le recours à un questionnaire informatisé réduit les délais et les coûts de traitement associés à la saisie des données, aux erreurs de transcription et à la transmission des données. Les réponses ont été sécurisées par le biais de protocoles de chiffrage selon les normes industrielles, des pares-feux et des couches de chiffrage.

Les données ont été recueillies du 17 mars au 31 juillet 2022. Il s'agit d'une enquête à participation volontaire.

[2] Aux fins de pondération et d'estimation de la variance, le plan d'échantillonnage global de l'ESMAS est considéré avoir deux phases, la première étant l'échantillon des Canadiens sélectionnés pour recevoir le questionnaire détaillé du Recensement de la population de 2021 et la seconde correspondant à l'échantillon de l'ESMAS.

5.0 Traitement des données

Le traitement transforme les réponses du questionnaire obtenues pendant la collecte pour qu'elles conviennent à la totalisation et à l'analyse des données. Il comprend toutes les activités de traitement des données, automatisées et manuelles, après la collecte et avant l'estimation.

5.1 Vérification

Des vérifications peuvent être faites à plusieurs étapes pendant le processus de l'enquête et elles passent des simples vérifications préliminaires dans l'application de collecte électronique aux vérifications automatisées plus complexes exécutées pendant le traitement après la saisie des données. Les règles de la vérification sont généralement formulées selon ce qui peut être logique ou valide, compte tenu :

- des connaissances de l'expert en la matière,
- d'autres enquêtes ou données connexes,
- de la structure du questionnaire et de ses questions,
- d'une théorie statistique.

Il existe trois grandes catégories de vérification : vérification de validité, de cohérence et de distribution. Les vérifications de validité ciblent la syntaxe des réponses et peuvent notamment permettre de déterminer que les données s'inscrivent dans l'étendue permise des valeurs. Une vérification de l'étendue peut être faite, par exemple, pour l'âge déclaré d'un répondant, afin de vérifier s'il se situe entre 0 et 121 ans.

Les vérifications de cohérence déterminent si les liens entre les questions sont respectés. Les vérifications de cohérence peuvent utiliser des liens logiques, juridiques, comptables ou structurels entre les questions ou entre les volets d'une question. Le lien entre la date de naissance et l'état matrimonial est un exemple auquel la vérification de cohérence peut être appliquée : « l'état matrimonial d'une personne de moins de 15 ans peut seulement être jamais marié ».

Les vérifications de distribution sont faites en observant les données entre les questionnaires. Elles tentent de déterminer les enregistrements qui sont des valeurs aberrantes du point de vue de la distribution des données. Les vérifications de distribution sont parfois considérées comme des vérifications statistiques ou des détections de valeurs aberrantes.

5.2 Codage des questions ouvertes

Quelques données élémentaires ont été saisies en format de réponse ouvert. La méthode standard de codage des questions ouvertes consiste à examiner les réponses pour déterminer si la réponse correspond à une catégorie existante. Dans ce cas-ci, si la réponse fournie ne correspondait pas à une catégorie existante, elle se retrouvait dans la catégorie générale « Autre ».

5.3 Création de variables dérivées

Pour faciliter l'analyse des données, un certain nombre de données élémentaires incluses dans le fichier de microdonnées ont été dérivées en combinant des éléments du questionnaire. Ainsi, les catégories de réponses d'une, de deux ou de plusieurs variables peuvent être combinées pour créer une nouvelle variable. Le dictionnaire de données précise les variables qui ont été dérivées et la façon dont elles l'ont été.

5.4 Variables couplées sur le revenu

L'ESMAS ne contient pas de questions sur le revenu qui sont directement posées aux répondants. Les variables sur le revenu sont obtenues plutôt à partir de sources de données administratives afin de réduire le fardeau de réponse et d'améliorer la qualité des données.

L'échantillon de l'ESMAS est tiré des répondants du questionnaire détaillé du Recensement de la population de 2021. De plus, la base de données du recensement contient déjà des variables d'intérêt portant sur le revenu. Ces variables sur le revenu ont été ajoutées à la base de données du recensement en les couplant aux données fiscales. Elles ont de plus déjà fait l'objet de processus de vérification et d'imputation.

Les données sur le revenu de l'ESMAS sont obtenues grâce au couplage du Recensement de 2021 et sont ajoutées au fichier principal de l'ESMAS pour chaque répondant qui a consenti au couplage de ses réponses.

En ce qui concerne le fichier de partage, comme nous n'avions pas demandé à tous les membres des ménages leur consentement pour procéder au couplage de données, le revenu total des ménages en 2020 est modélisé à l'aide d'un ensemble de variables qui sont corrélées avec le revenu des ménages.

5.5 Pondération

Le principe de base qui sous-tend l'estimation dans un échantillon probabiliste comme celui de l'ESMAS repose sur le fait que chaque personne de l'échantillon représente, en plus d'elle-même, plusieurs autres personnes qui ne font pas partie de l'échantillon. Par exemple, dans un échantillon aléatoire simple de 2 % de la population, chaque personne dans l'échantillon représente 50 personnes dans la population. Dans la terminologie utilisée ici, on peut dire que chaque personne a un coefficient de pondération (ou poids) de 50.

L'étape de détermination des facteurs de pondération permet de calculer le poids d'échantillonnage de chaque personne échantillonnée. Ce poids figure dans les fichiers de microdonnées et doit servir à extraire des estimations utiles de l'enquête. Par exemple, si l'on doit évaluer le nombre de personnes qui sont atteintes d'asthme, on le fait en choisissant dans l'échantillon les enregistrements des personnes qui présentent cette caractéristique et en additionnant les facteurs de pondération que représentent ces enregistrements.

Vous trouverez des renseignements détaillés de la méthode utilisée pour calculer les poids de sondage au chapitre 6 « Poids d'enquête et poids bootstrap ».

5.6 Imputation

L'imputation est un processus utilisé pour déterminer et attribuer des valeurs de remplacement, afin de résoudre les problèmes que suscitent les données manquantes, invalides ou incohérentes. Il faut à cette fin changer certaines des réponses et toutes les valeurs manquantes de l'enregistrement vérifié pour créer un enregistrement plausible et cohérent en soi.

5.6.1 Revenu

Des variables sur le revenu ont été imputées au fichier de partage, car nous n'avions pas demandé à tous les membres des ménages leur consentement pour procéder au couplage de données. Le revenu total des ménages en 2020 est

modélisé à l'aide d'un ensemble de variables qui sont corrélées avec le revenu des ménages.

5.6.2 Code postal

Le code postal du répondant est utilisé, de même que le Fichier de conversion des codes postaux, pour obtenir le reste des variables géographiques qui figurent dans les fichiers de données de l'ESMAS. Il est donc important que tous les répondants aient un code postal valide.

Si le code postal du répondant est manquant ou invalide, il est généralement imputé dans le cadre d'un processus d'imputation par enregistrement donneur, mais d'autres méthodes d'imputation sont aussi parfois utilisées. L'enregistrement donneur est choisi à partir de la même région géographique, que l'unité dont le code postal est manquant ou invalide et ce, avec le plus de précision possible.

En ce qui concerne l'ESMAS, les codes postaux de 4,5 % des répondants ont été imputés.

5.6.3 Genre

Une variable sur le genre classée en deux catégories a été créée pour réduire le risque de divulgation par recoupements.

Le genre se rapporte à l'identité personnelle et sociale d'un individu en tant qu'homme, femme ou personne non binaire (une personne qui n'est pas exclusivement homme ni femme). Étant donné que la taille de la population non binaire est petite, il est parfois nécessaire d'agréger les données dans une variable sur le genre à deux catégories pour protéger la confidentialité des réponses. Dans ces cas, les individus de la catégorie « personnes non binaires » sont répartis dans les deux autres catégories de genre et sont désignés par le symbole « + ». « Hommes+ » comprend les hommes (ou les garçons) ainsi que certaines personnes non binaires. « Femmes+ » comprend les femmes (ou les filles) ainsi que certaines personnes non binaires.

5.7 Contrôle de la divulgation

La Loi interdit à Statistique Canada de divulguer toute information que l'organisme recueille qui pourrait permettre d'identifier une personne, une entreprise ou une organisation, sauf si le répondant a donné son consentement ou si la Loi sur la statistique le lui permet. Diverses règles de confidentialité s'appliquent à toutes les données diffusées ou publiées afin d'empêcher la publication ou la divulgation de toute information jugée confidentielle. Au besoin, des données sont supprimées pour empêcher la divulgation directe ou par recoupement de données reconnaissables.

6.0 Poids d'enquête et poids bootstrap

Pour que les estimations produites à partir de données d'enquête soient représentatives de la population couverte, et non seulement de l'échantillon comme tel, les utilisateurs doivent incorporer les poids de sondage dans leurs calculs. Un poids de sondage est attribué à chaque répondant inclus dans l'échantillon final. Ce poids correspond au nombre de personnes représentées par le répondant dans l'ensemble de la population de l'enquête.

Tel qu'il est indiqué à la section 3.2, l'ESMAS est une enquête en base simple qui s'appuie sur les réponses des répondants du questionnaire détaillé du Recensement de la population de 2021. Les poids des unités sélectionnées pour l'enquête sont soumis à plusieurs étapes de correction de la pondération avant d'en arriver aux poids finaux des fichiers principal et partagé.

6.1 Aperçu

Bon nombre des ajustements appliqués aux poids des unités ont été faits au moyen du processus de pondération. Ces ajustements sont énumérés aux tâches T0 à T8 et décrits dans le diagramme A. Les sections suivantes présentent un aperçu de l'initialisation des poids (T0), ainsi que des ajustements T5 à T8, soit ceux qui sont les plus importants dans le cadre de la stratégie de pondération.

Diagramme A – Aperçu de la stratégie de pondération

Survey Frame
T0 – Initial weight (wgtT0) T1 – Linkage-scope-adjusted weight (wgtT1) T2 – Collection-adjusted weight (wgtT2) T3 – Overlap-adjusted weight (wgtT3) T4 – Stabilized weight (wgtT4) T5 – Scope-adjusted weight (wgtT5) T6 – Nonresponse adjusted weight (wgtT6) T7 – Winsorization (wgtT7) T8 – Calibration (wgtT8)
Final Survey Weight

6.2 Poids initial (wgtT0)

Le poids initial correspond à l'inverse de la probabilité de sélection. L'échantillon a été sélectionné à partir de la base de sondage en fonction des répondants du Recensement de 2021. Puisque le questionnaire détaillé du Recensement de 2021 lui-même est un échantillon[3], les personnes de la base de sondage de l'ESMAS sont déjà accompagnées de leur propre poids.

Le poids initial d'une unité de l'ESMAS (wgtT0) est par conséquent un produit des deux quantités suivantes : Les poids du Recensement de 2021 (wgtCensus2021), et l'ajustement de la sélection des personnes de l'ESMAS (adjMHACS = inverse de la probabilité de la sélection des personnes ou le nombre de personnes dans la base au sein de la strate de l'unité divisée par le nombre de personnes échantillonnées dans celle-ci). Le poids unitaire initial, wgtT0, est obtenu à partir de la formule suivante :

$$wgtT0=wgtCensus2021* adjMHACS$$

6.3 Poids ajustés selon la portée (wgtT5)

Parmi toutes les personnes échantillonnées, une certaine proportion d'entre elles sont identifiées pendant la collecte comme étant hors du champ de l'enquête ou inadmissibles à celle-ci. Parmi

[3] Pour le Recensement de 2021, un échantillon (environ ¼) a été prélevé dans les zones d'envoi postal, de listage/livraison et saisonnières, mais dans les zones d'interviews dans les réserves, la fraction d'échantillonnage était égale à 1 et tous les logements ont reçu le questionnaire détaillé.

les cas « hors du champ de l'enquête » de l'ESMAS, mentionnons les gens qui sont des membres à temps plein des Forces armées canadiennes, les personnes qui habitent sur une réserve, les enfants âgés de moins de 15 ans, ainsi que les personnes qui ont déménagé à l'extérieur des 10 provinces ou qui sont décédées. Ces cas et leurs poids connexes sont simplement retirés de l'échantillon, car on suppose que chacun d'entre eux représente un certain nombre de personnes hors champ dans la population, comme leurs poids le reflètent.

Le poids des personnes dans le champ d'enquête demeure le même qu'à l'étape précédente, maintenant appelée wgtT5.

Compte tenu de la qualité supérieure et de l'actualité de la base, les personnes dont l'admissibilité est inconnue (les renseignements fournis ne suffisaient pas pour déterminer l'admissibilité) sont considérées comme se trouvant dans le champ de l'enquête et conservent le même poids.

Ensuite, le poids obtenu, wgtT5, est représentatif des personnes dans le champ d'enquête de la population observée.

6.4 Poids ajusté en fonction de la non-réponse (wgtT6)

Pendant la collecte, certaines unités entraînent une non-réponse. C'est habituellement le cas lorsqu'une personne refuse de participer à l'enquête, fournit des données inutilisables, ou encore, ne peut être jointe pour réaliser l'interview. Les poids des personnes non-répondantes ont été redistribués aux personnes répondantes au sein de groupes de réponses homogènes (GRH), qui se sont formés dans chaque groupe d'âge, de sexe et de population. Pour créer des GRH, on utilise une méthode de notation basée sur une régression logistique permettant de déterminer la probabilité de réponse de chaque unité. Ces probabilités sont ensuite utilisées pour diviser l'échantillon en groupes aux propriétés de réponse similaires. Le modèle de régression comprenait les caractéristiques « personne » et « ménage » du Recensement de 2021 de la personne choisie (p. ex. le revenu, le niveau de scolarité, la composition du ménage, les limitations d'activités quotidiennes, telles que les problèmes émotionnels, psychologiques ou de santé mentale). Un facteur de correction a été calculé à l'intérieur de chaque GRH de la façon suivante :

$$\frac{Somme\ des\ poids\ wgtT5\ pour\ toutes\ les\ personnes}{Somme\ des\ poids\ wgtT5\ pour\ toutes\ les\ personnes\ répondantes}$$

Le poids wgtT5 était multiplié par ce facteur de correction pour produire le poids wgtT6 pour les répondants. Les personnes non-répondantes sont éliminées à partir de ce point.

6.5 Méthode d'estimation de Winsor (wgtT7)

À la suite de la série d'ajustements appliquée aux répondants, certaines unités peuvent présenter un poids extrême par rapport à d'autres dans le même domaine d'intérêt. Ces unités peuvent influer fortement sur la variance. Pour prévenir une telle situation, on ajuste à la baisse le poids des unités aberrantes au moyen de l'approche de réduction par estimation de Winsor.

6.6 Poststratification (wgtT8)

La dernière étape nécessaire pour obtenir les poids finaux de l'ESMAS est la poststratification. Cette étape vise à s'assurer que la somme des poids finaux correspond aux estimations de la population des domaines des groupes d'âge, de sexe et de population.

Les estimations des populations sont des projections dans les 10 provinces selon l'âge en fonction des chiffres du Recensement de 2016 et des dénombrements de naissance, de décès, d'immigration et d'émigration depuis ce temps. La moyenne des estimations mensuelles de mars à juillet pour chaque poststrate de groupe d'âge, de sexe et de population a servi dans la poststratification. Le poids wgtT7 est ajusté pour obtenir le poids final wgtT8. Le poids wgtT8 correspond au poids-personne final de l'ESMAS que l'on retrouve dans le fichier principal portant le nom de variable WTS_M.

6.7 Poids du fichier partagé

En plus du fichier principal qui contient tous les répondants de l'ESMAS, on crée un fichier partagé qui ne contient qu'une partie (86 %) des répondants initiaux de l'enquête. Les personnes dans le fichier partagé ont consenti à la transmission de leurs données à certains partenaires. Pour compenser la perte de certains répondants du fichier, le poids des répondants qui ont consenti au partage de leurs données doit être rajusté à l'aide du facteur :

$$\frac{\textit{Somme des poids T6 pour tous les répondants de l'ESMAS}}{\textit{Somme des poids T6 pour tous les répondants de l'ESMAS consentant au partage de leurs données}}$$

À l'instar des ajustements des non-réponses, ce facteur a été calculé au sein des GRH où, dans ce cas-ci, les répondants à la propension estimée similaire à partager[4] ont été regroupés. Le poids T6 des répondants qui ont consenti au partage de leurs données est multiplié par le facteur de correction ci-dessus pour l'obtention d'un poids de fichier partagé. En ce qui concerne le processus de pondération principal, la méthode d'estimation de Winsor et la poststratification (similaires aux ajustements T7 et T8) ont été appliquées aux unités communes. Le poids final après ces ajustements est appelé WTS_S.

6.8 Poids bootstrap

En ce qui concerne une enquête comportant un plan complexe, les poids bootstrap sont utilisés pour simplifier le processus d'estimation de la variance. Pour ce qui est de l'ESMAS, 1 000 ensembles de poids bootstrap ont été générés, dont chacun d'entre eux contenait un poids bootstrap pour chaque répondant. Chaque ensemble de poids bootstrap a été généré en fonction des poids initiaux de sondage de l'ESMAS, puis ajusté de la même façon que ceux utilisés pour les poids d'enquête, telle que décrit ci-dessus.

Les deux phases d'échantillonnage intégrées dans le plan de l'ESMAS (le choix de l'échantillon du Recensement de la population de 2021 a permis d'assigner des questionnaires détaillés à environ un quart de la population canadienne, suivi par le choix d'échantillon de l'ESMAS elle-même) ont été prises en compte dans la méthode bootstrap généralisée utilisée pour l'ESMAS.

La méthode peut entraîner des poids bootstrap négatifs. Cet enjeu est atténué en effectuant une transformation pour réduire leur variabilité. Les utilisateurs qui souhaitent calculer les mesures de variabilité à l'aide des poids bootstrap transformés doivent multiplier les mesures de variabilité par un facteur de rééchelonnage. **Pour obtenir des estimations appropriées de l'erreur d'échantillonnage, les variances doivent être multipliées par 9. De plus, les coefficients de variation (c.v.) obtenus (racine carrée de la variance divisée par l'estimation proprement dite) et les erreurs types doivent être multipliés par 3.** La plupart des progiciels qui produisent

[4] Pour modéliser la propension à partager des données, nous utilisons certaines des caractéristiques « personne » et « ménage » du Recensement de 2021 prises en compte pour l'ajustement pour la non-réponse et certaines variables clés extraites du questionnaire (puisque les partageurs sont un sous-ensemble de répondants, nous avons les réponses au questionnaire pour les deux groupes : partageurs et non-partageurs).

des estimations de l'erreur d'échantillonnage à partir de poids bootstrap comportent une option permettant de préciser ce facteur de correction[5], afin que la bonne estimation de la variance soit obtenue sans l'aide d'une étape additionnelle de multiplication. Ce facteur est souvent précisé comme étant « l'ajustement de Fay » dans les logiciels produisant des estimations de l'erreur d'échantillonnage à partir de poids bootstrap. Veuillez consulter la section 8.5 pour obtenir un exemple de la façon dont vous pouvez appliquer cette méthode lorsque vous utilisez la version 9.4 du SAS.

Il est extrêmement important d'utiliser le facteur multiplicatif approprié pour n'importe quelle mesure de l'erreur d'échantillonnage, telle que la variance, l'erreur type et le c.v. L'omission de ce facteur multiplicatif produira des conclusions et des résultats erronés.

L'ESCC-SM de 2012 ne comporte pas de facteur de rééchelonnage, puisque la méthodologie d'échantillonnage et de pondération qui a été utilisée dans le cadre de l'enquête était différente. Les utilisateurs de données devraient tenir compte de cette différence au moment de calculer et de comparer les estimations de l'ESMAS, ainsi que des enquêtes précédentes en 2012 et 2002 dont le contenu est similaire. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la comparaison des estimations de l'ESMAS avec celles d'autres enquêtes de Statistique Canada à la section 8.5.

7.0 Qualité des données

7.1 Erreurs dans l'enquête

Diverses sources expliquent les erreurs d'enquête. Elles peuvent être classées en deux principales catégories : erreur d'échantillonnage et erreurs non dues à l'échantillonnage.

7.2 Erreurs non dues à l'échantillonnage

Les erreurs non dues à l'échantillonnage peuvent être définies comme des erreurs possibles pendant à peu près toutes les activités d'enquête, mis à part l'échantillonnage. Ces erreurs se retrouvent dans l'enquête-échantillon et le recensement (contrairement à l'erreur d'échantillonnage qui est présente seulement dans l'enquête-échantillon). Les principales sources d'erreurs non dues à l'échantillonnage sont les suivantes : non-réponse, couverture, mesure et traitement.

7.2.1 Non-réponse

La non-réponse est une source d'erreur non due à l'échantillonnage et d'erreur due à l'échantillonnage. La non-réponse résulte de l'inhabilité de recueillir l'information nécessaire pour toutes les unités sélectionnées dans l'échantillon. La non-réponse est une source d'erreur non due à l'échantillonnage puisque les non-répondants ont souvent des caractéristiques différentes de celles des répondants, et les estimations de l'enquête seront biaisées si le biais de non-réponses n'est pas complètement éliminé par l'entremise des ajustements de pondération. Plus le taux

[5] Notez que si C est le facteur multiplicatif de variance, certains logiciels utilisent plutôt le paramètre k, où $k = 1-1/\sqrt{C}$. Dans notre cas, puisque C=9, alors k=0,67.

de réponse est bas, plus le risque de biais est élevé. La non-réponse est aussi une source d'erreur due à l'échantillonnage, ceci est présenté à la section 7.3.

Au total, 39 485 des personnes choisies dans l'ESMAS étaient admissibles à celle-ci,[6] dont 9 861 d'entre elles ont fourni une réponse, ce qui donne un taux de réponse de 25 %. Le tableau 3 ci-dessous fournit les taux de réponse obtenus par âge et par sexe, ainsi que par groupe de population.

Tableau 3. Taux de réponse par groupe d'âge, par genre et par groupe de population

Groupe d'âge	Taux de réponse		
	Homme	Femme	Tous
15 à 24 ans	18,9 %	20,2 %	19,5 %
25 à 44 ans	24,4 %	25,0 %	24,7 %
45 à 64 ans	25,0 %	28,2 %	26,6 %
65 ans et plus	31,0 %	29,7 %	30,4 %
Tous	24,4 %	25,5 %	25,0 %

Groupe de population	Taux de réponse
Philippin	22,9 %
Noir	25,8 %
Chinois	21,8 %
Sud-Asiatique	20,0 %
Autre	27,4 %
Tous	25,0 %

7.2.2 Erreurs de couverture

Les erreurs de couverture sont des omissions, des ajouts erronés, des répétitions et des erreurs de classification d'unités dans la base de sondage. Les erreurs de couverture peuvent susciter des estimations biaisées et les répercussions peuvent varier pour différents sous-groupes de la population.

L'ESMAS couvre la population âgée de 15 ans et plus au 1er mars 2022, résidant dans les dix provinces du Canada. Sont exclus de la couverture de l'enquête les

[6] Parmi les personnes sélectionnées, certaines ne rentrent pas dans le champ de l'enquête. Il s'agit par exemple de personnes qui ont déménagé hors des dix provinces ou qui sont décédées. Ces unités sont identifiées lors de la collecte des données, sinon elles auraient été exclues avant la sélection de l'échantillon. Ces unités ne sont pas prises en compte dans le calcul des taux de réponse. Les personnes dont le statut est inconnu sont considérées comme faisant partie du champ d'application.

personnes vivant dans des réserves et autres établissements autochtones, les membres à temps plein des Forces canadiennes et les personnes vivant dans des logements collectifs, comme les résidences institutionnelles. Au total, ces exclusions représentent moins de 3 % de la population canadienne âgée de 12 ans et plus.

7.2.3 Erreurs de mesure

Les erreurs de mesure (ou parfois appelées erreurs de réponse) sont la différence entre la réponse inscrite à une question et la « vraie » valeur. Le répondant, l'intervieweur, le questionnaire, la méthode de collecte ou le système de conservation des dossiers du répondant peuvent susciter ce genre d'erreur. De telles erreurs peuvent être aléatoires ou peuvent entraîner un biais systématique si elles ne sont pas aléatoires.

Il est très onéreux de mesurer avec précision le niveau de l'erreur de réponse et très peu d'enquêtes mènent ce genre d'étude. Cependant, la rétroaction des intervieweurs et les rapports d'observation fournissent souvent des pistes pouvant mener aux questions plus problématiques (mauvais libellé, instructions aux intervieweurs insuffisantes, mauvaise traduction, jargon technique, pas de texte d'aide disponible, etc.).

Statistique Canada a mis en place plusieurs mesures pour réduire le niveau d'erreur de réponse. Ces mesures comprennent une revue du questionnaire et des tests employant des méthodes cognitives, l'emploi d'intervieweurs très qualifiés, une formation complète des intervieweurs portant sur les procédures ainsi que le contenu et la mise en place d'un programme de surveillance en continu permettant de détecter des problèmes de conception du questionnaire ou une mauvaise compréhension des instructions.

7.2.4 Erreurs de traitement

L'erreur de traitements est associée aux activités suivant la réception des réponses d'enquête. Elles incluent toutes les activités de manipulation de données après la collecte et avant l'estimation. Elles peuvent être aléatoires comme toutes les autres erreurs et accroître ainsi la variance des estimations de l'enquête, ou elles peuvent être systématiques et ajouter un biais. Il est souvent difficile d'obtenir des mesures directes des erreurs de traitement ainsi que leur impact sur la qualité des données puisqu'elles sont souvent confondues avec d'autres types d'erreurs (non-réponse, mesure et couverture).

Le traitement des données de l'ESMAS a comporté un certain nombre d'étapes, notamment la saisie des données, la vérification, le codage, le contrôle et l'imputation. Après chaque étape, deux réviseurs différents examinaient et approuvaient les données. Comme les réponses écrites des questions ouvertes sont codées manuellement, des erreurs pouvaient se glisser à ce stade du traitement. Bien que le processus de codage des réponses écrites soit quelque peu subjectif et qu'il comporte un risque d'erreur de programmation, de tels risques ont été atténués grâce à des évaluations de l'assurance de la qualité et à l'utilisation des fichiers de référence fournis par les experts en la matière à Statistique Canada afin d'assurer une uniformité entre les enquêtes.

7.3 Erreur d'échantillonnage

L'erreur d'échantillonnage est définie comme étant l'erreur résultant de l'estimation d'une caractéristique de la population en mesurant une partie au lieu de toute la population. Des méthodes de calcul de l'erreur d'échantillonnage s'appliquent à l'enquête-échantillon probabiliste. Ces méthodes découlent directement du plan d'échantillonnage et de la méthode d'estimation de l'enquête.

La mesure appliquée le plus souvent pour quantifier l'erreur d'échantillonnage est la variance échantillonnale. La variance échantillonnale détermine à quel point l'estimation d'une caractéristique de divers échantillons possibles de même taille et de même conception est différente l'une de l'autre. Dans le cas des plans d'échantillonnage qui utilisent l'échantillonnage probabiliste, l'ampleur de la variance échantillonnale d'une estimation peut être estimée.

Les éléments qui ont des répercussions sur l'ampleur de la variance échantillonnale comprennent :

1. La variabilité de la caractéristique d'intérêt dans la population : plus la caractéristique dans la population est variable, plus la variance échantillonnale est grande.
2. La taille de la population : en général, la taille de la population a des répercussions sur la variance d'échantillonnage seulement pour les populations de petite taille ou de taille moyenne.
3. Le taux de réponse : la variance échantillonnale augmente dans la mesure où la taille de l'échantillon diminue. Étant donné que les non-répondants diminuent la taille de l'échantillon, la non-réponse augmente la variance échantillonnale. C'est un enjeu lorsque le taux de réponse est inférieur au taux de réponse prévu servant à augmenter la taille d'échantillon initiale.
4. Le plan d'échantillonnage et la méthode d'estimation : certains plans d'échantillonnage sont plus efficaces que d'autres parce que, pour la même taille d'échantillon et la même méthode d'estimation, un plan peut donner une variance échantillonnale moindre que l'autre.

Le plan d'échantillonnage de l'ESMAS comporte un suréchantillonnage des groupes de population, ce qui permet d'effectuer des analyses désagrégées et intersectionnelles plus poussées au sein de ces groupes en particulier. Toutefois, cela rend le plan d'échantillonnage moins efficace pour les estimations qui portent sur l'ensemble de la population.

L'erreur-type d'un estimateur est la racine carrée de sa variance échantillonnale. Cette mesure est plus facile à interpréter parce qu'elle donne une indication de l'erreur d'échantillonnage à l'aide de la même échelle que l'estimation, tandis que la variance est basée sur les différences quadratiques.

Le coefficient de variation (CV) d'une estimation est une mesure relative de l'erreur d'échantillonnage. Il est calculé comme l'estimation de l'erreur-type de l'estimation de l'enquête par rapport à l'estimation elle-même et est habituellement exprimé en pourcentage (10 % au lieu de 0,1). Elle est très utile pour mesurer et comparer l'erreur d'échantillonnage de variables quantitatives avec de grandes valeurs positives. Cependant, il n'est pas recommandé pour des estimations telles que les proportions, les estimations de changements ou de différences, et les variables qui peuvent avoir des valeurs négatives.

Il est considéré comme une pratique exemplaire à Statistique Canada de faire état de l'erreur d'échantillonnage d'une estimation par l'entremise de son intervalle de confiance de 95 %. L'intervalle de confiance de 95 % d'une estimation signifie que si l'enquête était répétée à maintes reprises, 95 % du temps (ou 19 fois sur 20), l'intervalle de confiance couvrirait la véritable valeur dans la population. La section 8.5 fournit des informations sur la construction d'intervalles de confiance.

7.4 Évaluation des biais

Afin d'évaluer l'incidence potentielle des faibles taux de réponse de l'ESMAS, une évaluation de la possibilité de biais a été menée à l'échelle nationale. Les estimations démographiques du Recensement de la population de 2021 ont servi de référence au moment d'évaluer la mesure des biais potentiels dans cette enquête. C'est-à-dire, les estimations des proportions du Recensement de 2021, utilisant les réponses et les poids des personnes se trouvant dans la base de l'ESMAS (« les références »), ont été comparées avec les mêmes estimations à différents stades du processus de rajustement des poids de l'ESMAS et ce, à l'aide des poids énumérés dans le diagramme A.
Au total, 31 variables catégoriques au niveau des personnes ont été utilisées dans le cadre de l'évaluation, dont le niveau de scolarité le plus élevé, l'âge, l'état matrimonial, l'autoévaluation des difficultés éprouvées dans la vie quotidienne et la situation d'emploi. Plus de 100 valeurs et regroupements de valeurs distincts ont servi à comparer les estimations des proportions.

La possibilité des biais lors du choix de l'échantillon était minime compte tenu de la nature aléatoire de la sélection. Après avoir rajusté les poids unitaires à tenir compte dans la sélection, il a été confirmé qu'il y avait peu de différence entre les données repères et les estimations en utilisant seulement les unités échantillonnées.

La probabilité de biais liés à une non-réponse est beaucoup plus élevée. Cette probabilité est toutefois grandement réduite par l'ajustement de poids pour la non-réponse. Les variables choisies pour le modèle décrit à la section 6.4 n'étaient pas seulement corrélées à la probabilité de réponse, mais également à la valeur de la variable MHPFY de l'enquête (Tout trouble sélectionné – Dans les 12 mois suivant le diagnostic). Par conséquent, les membres d'un groupe de réponses homogènes en particulier étaient non seulement susceptibles de présenter des similitudes dans leur tendance à répondre, mais également au niveau de leur valeur de MHPFY. En veillant à ce que les non-répondants dans ces groupes transfèrent leurs poids aux répondants qui se ressemblent sur ce plan, les données sur les réponses pondérées sont plus susceptibles de demeurer représentatives de la plus grande population selon cette mesure.

Près des trois quarts des intervalles de confiance de 95 % liés aux estimations qui ont été calculées à partir des poids finaux de l'ESMAS et des poids bootstrap correspondants contiennent la donnée repère correspondante à leur plage. En ce qui concerne les estimations restantes, elles diffèrent toutes de leurs données repères du recensement selon une valeur absolue inférieure à 2 %. Le tableau 4 illustre la proportion des estimations calculées à l'aide des poids finaux de l'ESMAS dans des intervalles de points de pourcentage de 0,5, de 1 ou de 2 par rapport aux données repères du recensement.

Tableau 4. Comparaison entre les estimations de l'ESMAS et les données repères du recensement

Différence entre les estimations de l'ESMAS et les données repères du recensement	Proportion
Dans un intervalle de 0,5 %	64,3 %
Dans un intervalle de 1 %	85,4 %
Dans un intervalle de 2 %	100 %

8.0 Lignes directrices pour la totalisation, l'analyse et la diffusion de données

Ce chapitre renferme les lignes directrices que doivent respecter les utilisateurs qui totalisent, analysent, publient ou diffusent de toute autre manière des données calculées à partir des fichiers de microdonnées de l'enquête. Ces lignes directrices devraient permettre aux utilisateurs de microdonnées de produire les mêmes chiffres que ceux produits par Statistique Canada, tout en étant en mesure d'obtenir des chiffres actuellement inédits de façon conforme à ces lignes directrices établies. Des méthodes permettant de mesurer la précision et la qualité des estimations sont également décrites, ainsi que des lignes directrices pour aider les utilisateurs à décider quand une estimation doit être incluse dans une publication.

8.1 Lignes directrices pour l'arrondissement d'estimations

Afin de garantir que les estimations destinées à la publication ou à toute autre utilisation dérivées des fichiers de données (maîtres ou partagés) correspondent à celles produites par Statistique Canada, les utilisateurs sont priés de respecter les lignes directrices suivantes concernant l'arrondi de ces estimations:

a) Les estimations dans le corps principal d'un tableau statistique doivent être arrondies à l'aide de la technique d'arrondissement normale. Selon cette technique, si le premier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 0 et 4, le dernier chiffre à conserver ne change pas. Si le premier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 5 et 9, le dernier chiffre à conserver est augmenté de 1.

b) Les totaux partiels marginaux et les totaux marginaux des tableaux statistiques doivent être calculés à partir de leurs composantes non arrondies correspondantes, puis être arrondis à leur tour à l'aide de la technique d'arrondissement normale.

c) Les moyennes, les taux, les pourcentages, les proportions et les rapports doivent être calculés à partir de composantes non arrondies (c'est-à-dire numérateurs et/ou dénominateurs), puis être arrondis à leur tour à l'aide de la technique d'arrondissement normale.

d) Les sommes et les différences doivent être calculées à partir de leurs composantes non arrondies correspondantes, puis être arrondies à leur tour à l'aide de la technique d'arrondissement normale.

e) Dans les cas, où, en raison de limitations d'ordre technique ou de toute autre limite, une technique d'arrondissement autre que la technique normale est utilisée pour produire des estimations à être publiées ou autrement diffusées différentes des estimations correspondantes publiées par Statistique Canada, nous recommandons fortement aux utilisateurs d'indiquer la raison de ces différences dans le ou les documents à publier ou à diffuser.

f) En aucun cas, les utilisateurs ne doivent publier ou autrement diffuser des estimations non arrondies. Des estimations non arrondies laissent entendre qu'elles sont plus précises qu'elles le sont en réalité.

8.2 Lignes directrices pour la pondération de l'échantillon en prévision de la totalisation

Le plan d'échantillonnage utilisé pour cette enquête n'est pas autopondéré. Autrement dit, le poids d'échantillonnage n'est pas le même pour toutes les personnes faisant partie de l'échantillon. Même pour produire des estimations simples, y compris des tableaux statistiques ordinaires, les utilisateurs **doivent** employer le poids d'échantillonnage approprié. Si les poids utilisés ne sont pas appropriés, les estimations calculées à partir des fichiers de microdonnées ne peuvent être considérées comme étant représentatives de la population observée et ne correspondront pas à celles produites par Statistique Canada.

Les utilisateurs ne doivent pas non plus perdre de vue qu'en raison du traitement du champ du poids, certains progiciels ne permettent pas d'obtenir des estimations qui coïncident exactement avec celles de Statistique Canada. Si des options sont disponibles, les utilisateurs devraient veiller à préciser que le poids est un poids d'échantillon plutôt qu'un poids de fréquence.

8.3 Lignes directrices pour l'analyse statistique

L'ESMAS se fonde sur un échantillon stratifié et un plan de sondage transversal. L'utilisation des données provenant d'une enquête aussi complexe pose des difficultés aux analystes, car le choix des méthodes d'estimation et de calcul de la variance dépend du plan de sondage et des probabilités de sélection. L'utilisation des poids de sondage représente une première étape en vue de l'obtention de résultats appropriés.

De nombreuses méthodes d'analyse intégrées aux progiciels statistiques permettent d'utiliser des poids, mais la signification et la définition de ces poids peuvent différer de celles applicables dans le contexte d'une enquête par échantillon. Le résultat final est que, même si dans de nombreux cas les estimations calculées au moyen des progiciels sont exactes, les variances et les statistiques fondées sur ces variances n'ont pratiquement aucune signification.

Afin de veiller à obtenir des résultats significatifs à partir d'un plan complexe, les progiciels doivent bien interpréter les poids. Il faut également recourir à des techniques d'estimation de la variance appropriées. Dans SAS, par exemple, PROC SURVEYMEANS fournit des résultats plus pertinents que les résultats produits à partir de PROC MEANS, car les poids bootstrap sont utilisés pour les estimations de la variance. PROC MEANS peut utiliser les poids de sondage pour correctement ajuster les estimations, en tenant compte du plan de pondération inégal, mais tend à sous-estimer les variances en n'utilisant pas les poids bootstrap et en supposant que le plan est un échantillonnage aléatoire simple.

Il est recommandé aux utilisateurs de données d'utiliser des progiciels et des fonctions pouvant incorporer à la fois des poids d'échantillonnage et des poids bootstrap durant la réalisation de leurs analyses. Les lignes directrices relatives à l'estimation de la variance, à l'établissement des intervalles de confiance et à la comparaison entre les estimations de l'ESMAS et celles d'une enquête comportant un plan différent sont fournies à la section 8.5.

8.4 Lignes directrices relatives à la qualité pour la diffusion

Avant de diffuser et/ou de publier toute estimation, les analystes doivent prendre en considération le niveau de qualité de l'estimation. Tandis que les erreurs d'échantillonnage et non dues à l'échantillonnage influencent la qualité des données, la présente section porte sur la qualité en ce qui a trait aux erreurs d'échantillonnage. À Statistique Canada, il est considéré comme une pratique exemplaire de faire état de l'erreur d'échantillonnage d'une estimation par l'intermédiaire de son intervalle de confiance (IC) de 95 %. L'intervalle de confiance doit être publié avec l'estimation, dans le même tableau que celle-ci. En plus des intervalles de confiance, les estimations sont classées dans l'une des trois catégories de diffusion suivantes :

Catégorie A
Les estimations et intervalles de confiance peuvent être publiés sans mise en garde. Les utilisateurs des données devraient utiliser l'intervalle de confiance de 95 % pour déterminer si la qualité de l'estimation est suffisante. Notez que le « A » n'est pas un indicateur de qualité; il ne devrait pas être diffusé.

Catégorie E

Les estimations et les intervalles de confiance doivent être signalés par la lettre E (ou un quelconque identificateur similaire) et accompagnés d'un avertissement à propos de la qualité d'utiliser les estimations avec prudence. Les utilisateurs de données devraient utiliser l'intervalle de confiance de 95 % afin de déterminer si la qualité de l'estimation est suffisante.

Catégorie F
Les estimations et les intervalles de confiance ne sont pas recommandés pour la diffusion. Ils sont jugés de si piètre qualité, qu'ils ne se portent à aucune utilisation; ils sont très instables, ce qui les rend peu fiables et potentiellement trompeurs. Si les analystes insistent pour publier des estimations de piètre qualité, même après avoir été informés de leur exactitude, ces estimations doivent être accompagnées d'un avis de non-responsabilité. Les analystes doivent tenir compte des mises en garde reçues et s'engager à ne pas diffuser, présenter, ni rapporter les estimations, directement ou indirectement, sans cet avis de non-responsabilité. Ces estimations doivent être signalées par la lettre F (ou un quelconque identificateur semblable) et la mise en garde suivante doit accompagner les estimations et intervalles de confiance :
« Nous informons l'utilisateur que ces estimations et intervalles de confiance (désignés par la lettre F) ne respectent pas les normes de qualité de Statistique Canada. Les conclusions basées sur ces données ne seront pas fiables et peuvent être invalides. »

Les règles afin d'assigner une estimation à une catégorie de diffusion dépendent du type d'estimation.

Règles de diffusion pour les estimations de proportions et de comptes

Les estimations de proportions et de comptes sont dérivées à partir de variables binaires. Les estimations de comptes sont des estimations du nombre total de personnes/ménages avec une caractéristique d'intérêt; en d'autres termes, elles représentent une somme pondérée d'une variable binaire (p. ex. nombre estimé d'immigrants). Les estimations de proportions sont des estimations de proportions de personnes /ménages avec une caractéristique d'intérêt (p. ex. proportion estimée d'immigrants dans la population générale). Les estimations de comptes et de proportions peuvent aussi être dérivées à partir de variables catégorielles : c'est-à-dire l'estimation du nombre ou de la proportion des personnes/ménages qui appartiennent à une catégorie.

Les règles de diffusion pour les estimations de proportions et de comptes sont fondées sur la taille de l'échantillon. Le tableau 5 présente les règles de diffusion pour l'ESMAS, lesquelles sont applicables à toutes les estimations de proportions et de chiffres.

La taille du domaine des personnes qui contribuent à l'estimation est indiquée par n. Pour le tableau 5, n indique l'une des caractéristiques suivantes :

A) le nombre non pondéré de répondants dans le dénominateur (et non le numérateur) de l'estimation de la proportion;

B) le nombre non pondéré de répondants ayant des valeurs non nulles qui contribuent à l'estimation de compte.

Le plan de l'ESMAS visait à soutenir les estimations de la qualité au sein des quatre groupes de population les plus importants. Il en a résulté un plan d'échantillonnage stratifié avec une répartition non proportionnelle de l'échantillon à ces groupes de populations au regard de leur prévalence dans la population, ce qui est moins efficace qu'un simple échantillon aléatoire destiné à produire des estimations des domaines qui combinent ces groupes de population. Pour cette raison, la combinaison des différents groupes de population nécessite un compte non pondéré plus élevé de la diffusion comparativement aux groupes individuels afin d'assurer que les estimations soient suffisamment de qualité pour les diffuser.

Exemple 1 : Il faudrait diffuser des données avec un avertissement à 50 répondants pour combiner toutes les catégories de groupe de population, y compris le groupe fourre-tout « Autre », afin de diffuser notamment des estimations nationales ou des estimations par groupe d'âge ou par genre. C'est davantage que le compte nécessaire pour les groupes de population individuels.

Il est important de comprendre le concept des numérateurs et des dénominateurs lorsqu'on interprète les règles de diffusion ci-dessous en lien avec les proportions.

Exemple 2 : Pour estimer la **proportion** des Chinoises et des Chinois qui considèrent que leur santé mentale est excellente, le dénominateur dans cette proportion correspond à la somme des poids des répondants chinois. On appliquerait alors la règle 1.1 du tableau 5 au nombre d'enregistrements contribuant au **dénominateur**. Ainsi, il faudrait au moins 40 répondants chinois pour diffuser une estimation de la proportion des Chinoises et des Chinois qui considèrent que leur santé mentale est excellente.

Pour obtenir une estimation du **nombre** de Chinoises et de Chinois qui considèrent que leur santé mentale est excellente, la règle 1.1 serait appliquée (c.-à-d. s'assurer qu'au moins 40 répondants chinois considèrent que leur santé mentale est excellente).

En ce qui concerne les utilisateurs des fichiers maître et partagé, il est requis d'avoir au moins 10 observations comportant les caractéristiques d'intérêt. S'il y a moins de 10 observations dans le numérateur, l'estimation pondérée ne devrait pas être diffusée, peu importe la taille (n) du domaine.

Tableau 5. Règles de diffusion de qualité pour les proportions et les comptes

Règle	Domaine	Diffuser sans avertissement	Avertissement d'utilisation avec prudence (E)	Ne pas diffuser (F)
1.1	Groupe de population et moins (Les personnes n qui contribuent à l'estimation font partie d'un seul des groupes de population)	n ≥ 80	40 ≤ n < 80	n < 40
1.2	Autrement (c.-à-d. ce domaine contient un mélange de groupes de population, par exemple les « hommes âgés de 65 ans et plus »)	n ≥ 100	50 ≤ n <100	n < 50

Règles de diffusion pour les moyennes et les totaux de variables quantitatives

Les règles de diffusion des estimations de moyennes et des totaux de variables quantitatives sont fondées sur la taille d'échantillon et sur le coefficient de variation (c.v.) de l'estimation. Le tableau 6 présente les règles de diffusion de l'ESMAS selon différents scénarios.

La taille du domaine des personnes qui contribuent à l'estimation est indiquée par n. Pour le tableau 6, n indique l'une des caractéristiques suivantes :

A) le nombre non pondéré de répondants qui contribuent à la moyenne ou à la médiane estimée, y compris les valeurs nulles;

B) le nombre non pondéré de répondants ayant des valeurs non nulles qui contribuent à l'estimation du total.

Comme il a été mentionné à la sous-section précédente, le plan de l'ESMAS visait à soutenir les estimations de la qualité au sein des quatre plus grands groupes de population. Pour cette raison, la combinaison des différents groupes de population nécessite un compte non pondéré plus élevé de la diffusion comparativement aux groupes individuels afin d'assurer que les estimations soient suffisamment de qualité pour les diffuser.

Exemple 3 : Dans le cas d'une diffusion d'une estimation des personnes faisant partie du groupe de population sud-asiatique, la règle 1.1 s'applique comme à la sous-section précédente. S'il y avait 80 personnes dans le groupe de population sud-asiatique et que le c.v. était de 20 %, l'estimation pourrait être diffusée sans avertissement. Par contre, si le c.v.se situe à 40 %, il faudrait diffuser l'estimation avec un avertissement d'utilisation avec prudence.

En ce qui concerne les utilisateurs des fichiers maître et partagé, il faut au moins 10 observations comportant des caractéristiques d'intérêt. S'il y a moins de 10 observations dans le numérateur, l'estimation pondérée ne devrait pas être diffusée, peu importe la taille (n) du domaine et la valeur du coefficient de variation de cette estimation.

Tableau 6. Règles de diffusion de qualité pour les moyennes et les totaux

Règle	Domaine	Diffuser sans avertissement	Avertissement d'utilisation avec prudence (E)	Ne pas diffuser (F)
2.1	Groupe de population et moins (Les personnes n qui contribuent à l'estimation font partie d'un seul des groupes de population)	n ≥ 80 et c.v. ≤ 25 %	Autrement	n < 40 ou c.v. > 50 %
2.2	Autrement (c.-à-d. ce domaine contient un mélange de groupes de population, par exemple les « hommes âgés de 65 ans et plus »)	n ≥ 100 et c.v. ≤ 25 %	Autrement	n < 50 ou c.v. > 50 %

Règles de diffusion pour les différences

Pour attribuer l'une des deux catégories de diffusion définies à la section 8.4 à une différence estimée entre les deux estimations, l'analyste doit d'abord déterminer la catégorie de diffusion de chacune des deux estimations en utilisant les règles décrites précédemment. Ensuite, la catégorie de diffusion de l'estimation de la différence ou de l'estimation du changement est assignée à la catégorie de diffusion la plus basse des deux estimations; ceci peut être spécifié ainsi :

- Si une estimation ou les deux sont de catégorie F, l'estimation de la différence est assignée à la catégorie F et doit être supprimée.
- Sinon, si une estimation ou les deux sont de catégorie E, l'estimation de la différence est assignée à la catégorie E.
- Si les deux estimations sont de catégorie A, alors l'estimation de la différence est assignée à la catégorie A

Règles additionnelles au sujet des intervalles de confiance

Les règles de diffusion précédentes devraient supprimer la plupart des estimations et intervalles de confiance de piètre qualité. Il y a également deux conditions qui indiquent si un intervalle de confiance est de piètre qualité. Une estimation et son intervalle de confiance devraient être assignés à la catégorie de diffusion F si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est satisfaite :

- La borne inférieure de l'intervalle de confiance de 95 % est égale à la borne supérieure de l'intervalle; en d'autres termes, l'intervalle de confiance est de longueur nulle. (Une exception survient si l'estimation correspond à un total de contrôle de calage.)
- La borne inférieure ou supérieure de l'intervalle de confiance de 95 % n'est pas une valeur plausible pour l'estimation. Par exemple, la borne inférieure d'une estimation de proportion est négative.

8.5 Lignes directrices pour l'analyse statistique, l'estimation de la variance et la construction des intervalles de confiance

Afin de mesurer l'erreur d'échantillonnage des estimations, il faut calculer les estimations de la variance et construire les intervalles de confiance. L'ESMAS utilise un plan d'échantillonnage et une méthode d'estimation complexes, de sorte qu'il n'y a pas de formule simple pour calculer les estimations de la variance. Par conséquent, l'enquête utilise une méthode de rééchantillonnage appelée la méthode bootstrap. Un millier d'ensembles de poids bootstrap a été généré, dont le nom est BSW1-BSW1000. Essentiellement, la variance est estimée en calculant la valeur de l'estimation d'intérêt au moyen de chacun des ensembles de poids bootstrap, puis la variabilité entre ces 1 000 estimations bootstrap est ensuite mesurée.

Progiciels statistiques pour l'analyse statistique et l'estimation de la variance

Pour l'ESMAS, il est nécessaire d'utiliser des poids bootstrap pour calculer des estimations de la variance exactes pour cette enquête. Un certain nombre de programmes ou de progiciels statistiques ont été conçus expressément pour analyser des données fondées sur des plans de sondage complexes et permettre d'estimer la variance au moyen de poids de rééchantillonnage, comme les poids bootstrap. SUDAAN, WesVar, STATA ainsi que les versions plus récentes de SAS en sont des exemples.

D'autres progiciels d'analyse statistique standards et/ou plus vieux, dont SPSS et les versions de SAS antérieures à la version 9.2, n'ont pas de procédure intégrée pour calculer des estimations de la variance à partir de poids bootstrap lorsque des données fondées sur un plan d'échantillonnage complexe sont utilisées. Ces logiciels ne doivent pas être utilisés pour calculer les estimations de la variance, construire des intervalles de confiance ou procéder à des tests statistiques (tests d'hypothèses, analyse de la régression, et ainsi de suite).

Les versions 9.2 et plus récentes de SAS peuvent calculer la variance au moyen de poids bootstrap ainsi que d'autres types de poids de rééchantillonnage comme des poids jackknife et des poids de réplique répétée équilibrée (RRE). Il existe également un certain nombre de procédures, telles que la régression et la régression logistique, qui acceptent les poids de rééchantillonnage. Les intervalles de confiance pour les médianes utilisant des poids de rééchantillonnage ne sont possibles dans SAS qu'à partir de la version 9.3.

Il est à noter que les progiciels qui ne soutiennent pas explicitement les poids bootstrap, mais qui soutiennent la méthode RRE peuvent être utilisés avec des poids bootstrap. Même si les méthodes bootstrap et RRE diffèrent quant à la manière dont les poids de rééchantillonnage sont construits, une fois ces poids produits, les deux méthodes utilisent une formule similaire pour calculer les estimations de la variance. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la relation entre la méthode bootstrap et la méthode RRE, veuillez vous reporter à Phillips (2004).

Intervalles de confiance

La méthode la plus couramment utilisée pour construire des intervalles de confiance de 95 % est l'intervalle de Wald, qui est de la forme $\hat{y} \pm 1.96\sqrt{\text{v}\hat{\text{a}}\text{r}(\hat{y})}$ pour une estimation $\hat{y}$ avec l'estimation de variance $\text{v}\hat{\text{a}}\text{r}(\hat{y})$. Les intervalles de Wald sont fondés sur l'hypothèse selon laquelle la répartition d'échantillonnage de $\hat{y}$ est à peu près normale. En ce qui concerne les proportions, on sait que l'hypothèse de normalité ne tient plus dans le cas des échantillons de petite taille et des proportions situées près de 0 ou de 1. Trois autres méthodes pour construire des intervalles de confiance sont par conséquent recommandées pour les proportions : l'intervalle de Wilson modifié, l'intervalle de Clopper-Pearson modifié et l'intervalle logit (voir Korn et Graubard, 1998 et Liu et Kott, 2009). Il existe des options dans SAS et SUDAAN pour produire des intervalles de confiance à l'aide de ces autres méthodes.

Les exemples ci-dessous montrent comment ces méthodes recommandées pour construire des intervalles de confiance sont précisées pour des proportions dans SAS et SUDAAN.

1. SAS, intervalles de confiance de Wilson modifiés :
```
PROC SURVEYFREQ
DATA=…. VARMETHOD=BRR (FAY=0.67);
WEIGHT WTS_M;
REPWEIGHTS BSW1-BSW1000;
TABLES …. / CL (TYPE=WILSON ADJUST=NO TRUNCATE=YES)
```

2. SUDAAN, intervalles de confiance de Clopper-Pearson modifiés :
```
PROC CROSSTAB
DATA=…. DESIGN=BRR SMCONF=50;
WEIGHT WTS_M;
REPWGT BSW1-BSW1000 / ADJFAY=9;
TABLES ...;
```

En ce qui concerne les exemples 1 et 2, les estimations de la variance peuvent être obtenues en ajoutant les options OUTPUT ou PRINT après l'énoncé TABLES.

Comparaison des estimations <u>entre</u> les enquêtes

Au moment de comparer les estimations, les intervalles de confiance et les tests d'hypothèses sont souvent pris en compte pour effectuer une inférence s'il existe suffisamment d'éléments pour prouver que la différence dans les estimations est statistiquement significative. En ce qui concerne l'ESMAS, il est important de se rappeler que, comme les poids bootstrap de cette enquête ont été créés à l'aide d'une autre méthodologie que celle des autres enquêtes sur la santé qui sont menées au sein de Statistique Canada, le facteur de correction de la variance **<u>doit</u>** être appliqué au moment d'estimer la variance des estimations de l'ESMAS, alors que ce n'est **<u>pas</u>** le cas pour d'autres enquêtes sur la santé.

Il n'existe pas de progiciel statistique, p. ex. SUDAAN, qui sera en mesure, en une étape, de créer un intervalle de confiance ou d'effectuer un test d'hypothèse pour une estimation d'une différence. Il est par conséquent recommandé de suivre les étapes suivantes au moment d'estimer les différences des proportions (ou les agrégats) entre les enquêtes :

1) Estimer une proportion de l'ESMAS et sa variance à l'aide de l'une des méthodes mentionnées ci-dessous :
   $\hat{X}_{MHACS}$ et $\widehat{var}(\hat{X}_{MHACS})$
2) Estimer une proportion à partir d'un autre enquête et de sa variance :
   $\hat{X}_2$ et $\widehat{var}(\hat{X}_2)$

3) Estimer la différence entre les proportions comme $\hat{d} = \hat{X}_{MHACS}$ - $\hat{X}_2$
4) Estimer la variance de l'estimation de la différence. Lorsque deux plans d'échantillonnage sont indépendants, la variance d'une différence entre deux estimations est environ égale à la somme des variances de chaque estimation. C'est-à-dire, la variance de la différence peut être estimée de la façon suivante : $\widehat{var}(\hat{d}) = \widehat{var}(\hat{X}_{MHACS}) + \widehat{var}(\hat{X}_2)$.
5) Établir un intervalle de confiance de 95 % pour la différence : $(\hat{d} - 1.96\sqrt{\widehat{var}(\hat{d})},\ \hat{d} + 1.96\sqrt{\widehat{var}(\hat{d})})$
6) Un test d'hypothèse pour réaliser si les proportions de la population (ou d'autres caractéristiques) à partir de deux enquêtes sont les mêmes peut être effectué en effectuant un test Z. Le score z du test Z peut être calculé à l'aide de la formule suivante :
   $z = \frac{\hat{d}}{\sqrt{\widehat{var}(\hat{d})}}$

Références

Korn, E.L., and Graubard, B.I. (1998). « Confidence Intervals for Proportions With Small Expected Number of Positive Counts Estimated From Survey Data ». *Survey Methodology*, 24, 193-201.

Liu, Y.K. and Kott, P.S. (2009). "Evaluating Alternative One-Sided Coverage Intervals for a Proportion". *Journal of Official Statistics*, Vol. 25, No. 4, 569-588.

Phillips, O. (2004). "Using bootstrap weights with WesVar and SUDAAN" (Catalogue no. 12-002-X20040027032) in The Research Data Centres Information and Technical Bulletin, Chronological index, Fall 2004, vol.1 no. 2 Statistics Canada, Catalogue no. 12-002-XIE.

Annexe A :

Comparaison de variables, 2012 ESCC - Santé mentale et 2002 ESCC - Santé mentale et Bien-être et Enquête sur la santé mentale et l'accès aux soins 2022

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
SAMPLEID	SAMPLEID	MASTERID	Numéro de séquence généré de manière aléatoire pour le fichier principal	Même	Même		
VERDATE	VERDATE	VERDATE	Date de création du fichier	Même	Même		
REFPER	REFPER	REFPER	Période de référence	Même	Même		
	ADM_N12	ADM_LAN	Langue de l'interview	Même			
GEOBDCMA	GEODCMA1	GEODVCMA	Région métropolitaine du recensement de 2021 - (D)	Modifiée	Modifiée	On a mis à jour cette variable pour représenter les éléments géographiques du Recensement de 2021.	On a mis à jour cette variable pour représenter les éléments géographiques du Recensement de 2011.
GEOB_PRV	GEO_PRV	GEO_PRV	Province de résidence du répondant	Même	Même		
GEOB_PC	GEODPC	GEODVPC	Code postal - (D)	Même			
	GEODUR	GEODVUR	Centres de population et régions rurales - (D)	Modifiée	Ajoutée	Les conditions de la variable dérivée ont changé, le concept est resté inchangé. Voir spécifications de la VD.	
GEOBDUR2	GEODUR2	GEODVUR2	Centres de population et régions rurales - 2 niveaux - (D)	Même	Modifiée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
		GEODVPSZ	Classification des centres de population ou des zones rurales - (D)	Ajoutée			
		CAF_01	Membre à temps plein des FAC régulières	Ajoutée			
DHHB_MS	DHH_MS	MS_01	État matrimonial	Même	Même		
DHHB_AGE	DHH_AGE	DV_AGE	Âge	Même	Même		
DHHB_SEX	DHH_SEX	GDR_005	Sexe	Même	Même		
		GENDER	Genre (2)	Ajoutée			
		GDRDCTNB	Cisgenre, transgenre et non-binaire	Ajoutée			
GENB_01	GEN_01	GEN_01	Évaluation personnelle de la santé	Même	Même		
GENB_02	GEN_02	GEN_02A	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	Même	Même		
SCRB_082	SCR_082	GEN_08B	Évaluation personnelle de la santé mentale	Même	Même		
		GEN_08C	Évaluation personnelle de la santé mentale par comp. à l'an dernier	Ajoutée			
GENB_04	GEN_04	GEN_02A1	Fréquence - problèmes à s'endormir	Même	Même		
	GEN_02A2	GEN_02B	Satisfaction de vie en général - échelle de 11 points	Même	Ajoutée		
GENB_07	GEN_07	GEN_07	Stress ressenti dans la vie	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
GENB_08	GEN_08	GEN_08	A occupé un emploi ou travaillé pour une entreprise	Même	Même		
GENB_09	GEN_09	GEN_09	Évaluation personnelle du stress au travail	Même	Même		
GENB_10	GEN_10	GEN_10	Sentiment d'appartenance à une commun. locale	Même	Même		
GENBDHDI	GENDHDI	GENDHDI	Santé perçue - (D)	Même	Même		
	GENGSWL	GENGSWL	Satisfaction de vie en général - (G)	Même	Ajoutée		
SCRB_21	SCR_21	SCR_21	Filtre : senti triste/vide/déprimé plusieurs jours - vie	Même	Même		
SCRB_22	SCR_22	SCR_22	Filtre : a été très découragé plusieurs jours ou plus - vie	Même	Même		
SCRB_23	SCR_23	SCR_23	Filtre: perdu intérêt envers les choses plusieurs jours -vie	Même	Même		
SCRB_24	SCR_24	SCR_24	Filtre : a eu période semblable à manie plusieurs jours -vie	Même	Même		
SCRB_25	SCR_25	SCR_25A	Filtre : très irritable/humeur grincheuse/ plus. jours - vie	Même	Même		
SCRB_25A	SCR_25A	SCR_25B	Filtre : si irritable à l'origine de disputes/crié/... - vie	Même	Même		
SCRB_26	SCR_26	SCR_26A	Filtre : s'est inquiété plus que les autres personnes - vie	Même	Même		
SCRB_26A	SCR_26A	SCR_26B	Filtre : plus nerveux/anxieux que	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			les autres personnes - vie				
SCRB_26B	SCR_26B	SCR_26C	Filtre : 6 mois anxieux/inquiet presque tous les jours - vie	Même	Même		
SCRB_29		SCR_29A	Filtre : peur intense ou de gêne avec des gens - vie	Ajoutée			
SCRB_29A		SCR_29B	Filtre : peur intense ou de gêne devant un groupe - vie	Ajoutée			
SCRB_291		SCR_29C	Filtre : bouleversement ou nervosité devant un groupe - vie	Ajoutée			
SCRB_292		SCR_29D	Filtre : s'est tenu à l'écart par peur devant un groupe - vie	Ajoutée			
SCRB_293		SCR_29E	Filtre : pense que la peur était bcp plus grande qu'elle n'aurait dû	Ajoutée			
SCRBDMEN	SCRDMEN	SCRDMEN	Auto-évaluation la santé mentale - (D)	Même	Même		
SCRBDDEP	SCRDDEP	SCRDDEP	Filtré dans Dépression - (D)	Même	Même		
SCRBDMIA	SCRDMIA	SCRDMIA	Filtré dans Manie - (D)	Même	Même		
	SCRDGAD	SCRDGAD	Filtré dans Trouble d'anxiété généralisée - (D)	Même	Ajoutée		
SCRBDSOP		SCRDSOP	Le répondant a fait l'objet d'un dépistage dans le cadre du	Ajoutée			

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			module sur la phobie sociale - (F)				
CCCB_031	CCC_031	CCC_031	Fait de l'asthme	Même	Même		
CCCB_051	CCC_051	CCC_051	Souffre d'arthrite	Même	Modifiée		On a changé le libellé de la question
CCCB_061	CCC_061	CCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	Même	Même		
		CCC_062	Est atteint de fibromyalgie	Ajoutée			
CCCB_071	CCC_071	CCC_071	Fait de l'hypertension	Même	Même		
	CCC_072	CCC_072	A déjà reçu un diagnostic d'hypertension	Même	Ajoutée		
CCCB_081	CCC_081	CCC_081	A des migraines	Même	Même		
CCCB_091	CCC_091	CCC_091	Atteint de bronchite chronique/ emphysème/ MPOC	Même	Modifiée		Combinaison de deux questions dans l'enquête de 2002.
CCCB_101	CCC_101	CCC_101	Est atteint du diabète	Même	Même		
CCCB_121	CCC_121	CCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	Même	Même		
CCCB_131	CCC_131	CCC_131	Souffre d'un cancer	Même	Même		
	CCC_132	CCC_132	A déjà souffert d'un cancer	Même	Ajoutée		
CCCB_171	CCC_171	CCC_171A	Est atteint de troubles intestinaux/Crohn/colite ulcéreuse	Même	Même		
	CCC_17A	CCC_171B	Genre de maladie intestinale	Même	Ajoutée		
CCCB_251	CCC_251	CCC_251	Souffre du syndrome de fatigue chronique	Même	Même		
CCCB_261	CCC_261	CCC_261	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
CCCB_271	CCC_271	CCC_271A	Est atteint de schizophrénie	Même	Même		
	CCC_271B	CCC_271B	A déjà reçu un diagnostic de schizophrénie	Même	Ajoutée		
CCCB_281	CCC_281	CCC_272A	Est atteint de toute autre forme de psychose	Même	Même		
	CCC_281B	CCC_272B	A déjà reçu un diagnostic pour toute autre forme de psychose	Même	Ajoutée		
	CCC_280	CCC_280A	Est atteint d'un trouble de l'humeur	Même	Ajoutée		
	CCC_28AA	CCC280BA	Est atteint d'un trouble de l'humeur - dépression	Même	Ajoutée		
	CCC_28AB	CCC280BB	Est atteint d'un trouble de l'humeur - trouble bipolaire	Même	Ajoutée		
	CCC_28AC	CCC280BC	Est atteint d'un trouble de l'humeur - manie	Même	Ajoutée		
	CCC_28AD	CCC280BD	Est atteint d'un trouble de l'humeur - dysthymique	Même	Ajoutée		
	CCC_28AE	CCC280BE	Est atteint d'un trouble de l'humeur - autre	Même	Ajoutée		
	CCC_290	CCC_290A	Est atteint d'un trouble d'anxiété	Même	Ajoutée		
	CCC_29AA	CCC290BA	Est atteint d'un trouble d'anxiété - phobie	Même	Ajoutée		
	CCC_29AB	CCC290BB	Est atteint d'un trouble d'anxiété -	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			obsessionnel-compulsif				
	CCC_29AC	CCC290BC	Est atteint d'un trouble d'anxiété - trouble panique	Même	Ajoutée		
	CCC_29AD	CCC290BD	Est atteint d'un trouble d'anxiété - autre	Même	Ajoutée		
CCCB_311	CCC_311	CCC_311	Est atteint du syndrome de stress post-traumatique	Même	Même		
CCCB_331	CCC_331	CCC_331	A des troubles d'apprentissage	Même	Même		
CCCB_332	CCC_332	CCC_332	A un trouble déficitaire de l'attention	Même	Modifiée		On a changé le libellé de la question
CCCB_341	CCC_341	CCC_341	A des troubles alimentaires tel que l'anorexie ou boulimie	Même	Même		
CCCB_901	CCC_901	CCC_901	A un autre problème de santé phys./mentale de longue durée	Même	Même		
CCCBF1	CCCF1	CCCF1	A une maladie chronique - (F)	Même	Modifiée		On a changé les conditions dans les spécifications de variables dérivées.
	CCCDHBP	CCCDHBP	Fait de ou déjà été diagnostiqué pour l'hypertension (D)	Même	Ajoutée		
	CCCDCNCR	CCCDCNCR	Souffre ou à déjà été diagnostiqué pour d'un cancer (D)	Même	Ajoutée		
	CCCDSCZO	CCCDSCZO	Fait de ou déjà été diagnostiqué pour la schizophrénie (D)	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	CCCDPSYC	CCCDPSYC	Fait de ou déjà été diagnostiqué pour la psychose (D)	Même	Ajoutée		
	HUP_01	HUP_28	Habituellement sans douleurs/malaises	Même	Ajoutée		
	HUP_02	HUP_29	Douleurs et malaises - intensité habituelle	Même	Ajoutée		
	HUP_03	HUP_30	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées	Même	Ajoutée		
	HUPDPAD	HUPDPAD	Douleur (code fonctionnel) - (D)	Même	Ajoutée		
	PHS_01	PHS_01	Fait de l'activité physique - fréq 7 j	Même	Ajoutée		
	PHS_02	PHS_02	Temps consacré - chaque fois (exercice)	Même	Ajoutée		
	PHSFPPA	PHSFPPA	Indicateur : activité physique modérée/élevée - 7 jours (I)	Même	Ajoutée		
	PHSDAPA	PHSDAPA	Activité physique modérée/élevée - moyenne/heures - 7 J (D)	Même	Ajoutée		
		IM_10A	Impacts COVID-19 - Perte d'emploi ou de revenu	Ajoutée			
		IM_10B	Impacts COVID-19 - Difficultés financières	Ajoutée			
		IM_10C	Impacts COVID-19 - Accès service de garde difficile	Ajoutée			
		IM_10D	Impacts COVID-19 - Accès médicaments difficile	Ajoutée			

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
		IM_10E	Impacts COVID-19 - Accès services de santé difficile	Ajoutée			
		IM_10F	Impacts COVID-19 - Diagnostiqué avec la COVID-19	Ajoutée			
		IM_10G	Impacts COVID-19 - Hospitalisé à cause du COVID-19	Ajoutée			
		IM_10H	Impacts COVID-19 - Maladie grave d'un proche	Ajoutée			
		IM_10I	Impacts COVID-19 - Perte d'un proche	Ajoutée			
		IM_10J	Impacts COVID-19 - Sentiments de solitude ou d'isolement	Ajoutée			
		IM_10K	Impacts COVID-19 - Détresse émotionnelle	Ajoutée			
		IM_10L	Impacts COVID-19 - Problèmes de santé physique	Ajoutée			
		IM_10M	Impacts COVID-19 - Difficultés relationnelles avec membres du ménage	Ajoutée			
		IM_10N	Impacts COVID-19 - Autre	Ajoutée			
		IM_10O	Impacts COVID-19 - Aucun des éléments ci-dessus	Ajoutée			
	PMH_01	PMH_01	Santé ment pos - se sentait heureux - fréq 1 m	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	PMH_02	PMH_02	Santé ment pos - intéressé par la vie - fréq 1 m	Même	Ajoutée		
	PMH_03	PMH_03	Santé ment pos - satisfait de sa vie - fréq 1 m	Même	Ajoutée		
	PMH_04	PMH_04	Santé ment pos - quelque chose à apporter à la soc - fréq 1 m	Même	Ajoutée		
	PMH_05	PMH_05	Santé ment pos - appartenance à une collectivité - fréq 1 m	Même	Ajoutée		
	PMH_06	PMH_06	Santé ment pos- société devient un meilleur endroit -fréq 1 m	Même	Ajoutée		
	PMH_07	PMH_07	Santé ment pos - gens sont fondamentalement bons - fréq 1 m	Même	Ajoutée		
	PMH_08	PMH_08	Santé ment pos - société a un sens - fréq 1 m	Même	Ajoutée		
	PMH_09	PMH_09	Santé ment pos - aimait la plupart de personnalit - fréq 1 m	Même	Ajoutée		
	PMH_10	PMH_10	Santé ment pos - bon pour gérer le quotidien - fréq 1 m	Même	Ajoutée		
	PMH_11	PMH_11	Santé ment pos-a relations fondées sur la confiance-fréq 1 m	Même	Ajoutée		
	PMH_12	PMH_12	Santé mentale pos - poussent à devenir meilleur - fréq 1 m	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	PMH_13	PMH_13	Santé ment pos - capable d'exprimer ses opinions - fréq 1 m	Même	Ajoutée		
	PMH_14	PMH_14	Santé ment pos - vie a une signification - fréq 1 m	Même	Ajoutée		
	PMHDHEM	PMHDHEM	Bien-être émotionnel élevé - (D)	Même	Ajoutée		
	PMHDLEM	PMHDLEM	Bien-être émotionnel faible - (D)	Même	Ajoutée		
	PMHDHFU	PMHDHFU	Fonctionnement positif élevé - (D)	Même	Ajoutée		
	PMHDLFU	PMHDLFU	Fonctionnement positif faible - (D)	Même	Ajoutée		
	PMHDCLA	PMHDCLA	Santé mentale positive - classification - (D)	Même	Ajoutée		
	PMHDSCR	PMHDSCR	Santé mentale positive - score continu - (D)	Même	Ajoutée		
STSB_1	STS_1	STS_1	Auto-évaluation capacité faire face à situation imprévue	Même	Même		
STSB_2	STS_2	STS_2	Auto-évaluation capacité faire face à demandes quotidiennes	Même	Même		
STSB_3	STS_3	STS_3	Plus importante source des sentiments de stress	Même	Même		
	STS_4	STS_4	Peut compter sur des personnes / faire face au stress	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	STS_5	STS_5	Perçu-capacités personnelles / faire face au stress	Même	Ajoutée		
DISB_10A	DIS_10A	DIS_01A	Fréq/détresse : senti épuisé - mois passé	Même	Même		
DISB_10B	DIS_10B	DIS_01B	Fréq/détresse : senti nerveux - mois passé	Même	Même		
DISB_10C	DIS_10C	DIS_01C	Fréq/détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé	Même	Même		
DISB_10D	DIS_10D	DIS_01D	Fréq/détresse : senti désespéré - mois passé	Même	Même		
DISB_10E	DIS_10E	DIS_01E	Fréq/détresse : senti agité / pas en place - mois passé	Même	Même		
DISB_10F	DIS_10F	DIS_01F	Fréq/détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé	Même	Même		
DISB_10G	DIS_10G	DIS_01G	Freq/détresse : senti triste / déprimé - mois passé	Même	Même		
DISB_10H	DIS_10H	DIS_01H	Fréq/détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé	Même	Même		
DISB_10I	DIS_10I	DIS_01I	Fréq/détresse : senti tout était effort - mois passé	Même	Même		
DISB_10J	DIS_10J	DIS_01J	Fréq/détresse : senti bon à rien - mois passé	Même	Même		
DISB_10K	DIS_10K	DIS_01K	Fréq/détresse : survenance des sentiments - mois passé	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
DISB_10L	DIS_10L	DIS_01L	Degré de survenance élevé des sentiments - mois passé	Même	Même		
DISB_10M	DIS_10M	DIS_01M	Degré de faible survenance des sentiments - mois passé	Même	Même		
DISB_10N	DIS_10N	DIS_01N	Interférence - sentiments dans la vie/activités - mois passé	Même	Même		
DISBDK6	DISDK6	DISDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	Même	Même		
DISBDDSX	DISDDSX	DISDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	Même	Même		
DISBDCHR	DISDCHR	DISDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité- mois passé (D)	Même	Même		
DEPB_01	DEP_01	DEP_01A	Période - découragé par les événements - vie	Même	Même		
DEPB_01A	DEP_01A	DEP_01A1	Période - perdu intérêt pour la plupart des choses - vie	Même	Même		
DEPB_01B	DEP_01B	DEP_01B	Période - perdu intérêt pour la plupart des choses - vie	Même	Même		
DEPB_02	DEP_02	DEP_02	Période - perdu intérêt pour la plupart des choses - vie	Même	Même		
DEPB_09	DEP_09	DEP_09	Période 2 sem. - perdu intérêt pour plupart des choses - vie	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
DEPB_12	DEP_12	DEP_12	Période 2 sem -triste et/ou découragé et/ou manque d'intérêt	Même	Même		
DEPB_16	DEP_16	DEP_16	Durée quotidienne - triste/découragé/manque d'intérêt - vie	Même	Même		
DEPB_17	DEP_17	DEP_17	Détresse émotionnelle - intensité - vie	Même	Même		
DEPB_18	DEP_18	DEP_18	Détresse très sévère rien ne réjouissait - fréquence - vie	Même	Même		
DEPB_19	DEP_19	DEP_19	Détresse sévère/pas accomplir quotidien - fréquence - vie	Même	Même		
DEPB_21	DEP_21	DEP_21	Eu symptômes épisodiques semblables à la dépression - vie	Même	Même		
DEPB_22	DEP_22	DEP_22A	Vécu un épisode particulier très grave - vie	Même	Même		
DEPB_22A	DEP_22A	DEP_22A1	Début d'un épisode très grave - âge	Même	Même		
DEPB_22B1	DEP_22B1	DEP_22B	Pire épisode - durée	Même	Même		
DEPB_22C1	DEP_22C1	DEP_22C	Pire épisode - unité: jours/semaines/mois/ années	Même	Modifiée		On a consolidé les questions de suivi pour faciliter la programmation.
DEPB_23A	DEP_23A	DEP_23A	Dernier mauvais épisode - âge	Même	Même		
DEPB_23B1	DEP_23B1	DEP_23B	Dernier mauvais épisode - durée	Même	Même		
DEPB_23C1	DEP_23C1	DEP_23C	Dernier mauvais épisode - unité :	Même	Modifiée		On a consolidé les questions de suivi

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			jours/semaines/mois/ années				pour faciliter la programmation.
DEPB_24A	DEP_24A	DEP_24A	Symptôme - se sentait triste / sans émotion / déprimé	Même	Même		
DEPB_24B	DEP_24B	DEP_24B	Symptôme - se sentait si triste que rien ne pouvait réjouir	Même	Même		
DEPB_24C	DEP_24C	DEP_24C	Symptôme - était découragé à propos de ce qui se passait	Même	Même		
DEPB_24D	DEP_24D	DEP_24D	Symptôme - était désespéré face à l'avenir	Même	Même		
DEPB_24E	DEP_24E	DEP_24E	Symptôme - avait perdu de l'intérêt pour plupart des choses	Même	Même		
DEPB_24F	DEP_24F	DEP_24F	Symptôme - avait impression que rien ne procurait du plaisir	Même	Même		
DEPB_26A	DEP_26A	DEP_26A	Symptôme - avait beaucoup moins d'appétit que d'habitude	Même	Même		
DEPB_26B	DEP_26B	DEP_26B	Symptôme - avait beaucoup plus d'appétit que d'habitude	Même	Même		
DEPB_26C	DEP_26C	DEP_26C	Symptôme - avait pris du poids sans en avoir l'intention	Même	Même		
DEPB_261	DEP_261	DEP_26C1	Gain de poids pour cause de la croissance physique/grossesse	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
DEPB_26D	DEP_26D	DEP_26D	Gain de poids - quantité	Même	Même		
DEPB_262	DEP_262	DEP_N26D	Gains de poids - unité : livres ou kilogrammes	Même	Même		
DEPB_26E	DEP_26E	DEP_26E	Symptôme - perte de poids sans en avoir l'intention	Même	Même		
DEPB_263	DEP_263	DEP_26E1	Perte de poids pour cause de régime/maladie physique	Même	Même		
DEPB_26F	DEP_26F	DEP_26F	Poids perdu - quantité	Même	Même		
DEPB_264	DEP_264	DEP_N26F	Perte de poids - unité: livres ou kilogrammes	Même	Même		
DEPB_26G	DEP_26G	DEP_26G	Symptôme - avait difficulté à s'endormir/rester endormi	Même	Même		
DEPB_26H	DEP_26H	DEP_26H	Symptôme - dormait plus qu'à l'habitude	Même	Même		
DEPB_26I	DEP_26I	DEP_26I	Symptôme - dormait moins qu'à l'habitude/pas fatigue	Même	Même		
DEPB_26J	DEP_26J	DEP_26J	Symptôme - se sentait fatigué/manque d'énergie	Même	Même		
DEPB_26K	DEP_26K	DEP_26K	Symptôme - avait plus d'énergie qu'à l'habitude	Même	Même		
DEPB_26L	DEP_26L	DEP_26L	Symptôme - parlait/déplaçait plus	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			lentement qu'à l'habitude				
DEPB_26M	DEP_26M	DEP_26M	Symp - autres remarqué répondant parlait/déplaçait lentement	Même	Même		
DEPB_26N	DEP_26N	DEP_26N	Symptôme - agité/tendu/ne pouvait tenir en place	Même	Même		
DEPB_26O	DEP_26O	DEP_26O	Symptôme - autres ont remarqué répondant était agité	Même	Même		
DEPB_26P	DEP_26P	DEP_26P	Symp - les idées lui venaient plus lentement que d'habitude	Même	Même		
DEPB_26Q	DEP_26Q	DEP_26Q	Symptôme - les idées changeaient/défilaient rapidement	Même	Même		
DEPB_26R	DEP_26R	DEP_26R	Symptôme - avait plus de difficulté à se concentrer	Même	Même		
DEPB_26S	DEP_26S	DEP_26S	Symptôme - incapable de prendre une décision	Même	Même		
DEPB_26T	DEP_26T	DEP_26T	Symptôme - perdu confiance en soi	Même	Même		
DEPB_26U	DEP_26U	DEP_26U	Symptôme - se sentait moins bon que les autres	Même	Même		
DEPB_26V	DEP_26V	DEP_26V	Symptôme - se sentait totalement inutile	Même	Même		
DEPB_26W	DEP_26W	DEP_26W	Symptôme - se sentait coupable	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			presque tous les jours				
DEPB_26X	DEP_26X	DEP_26X	Symp - se sentait irritable/grincheux ou de mauvaise humeur	Même	Même		
DEPB_26Y	DEP_26Y	DEP_26Y	Symptôme - se sentait nerveux/anxieux presque tous les jours	Même	Même		
DEPB_26Z	DEP_26Z	DEP_26Z	Symptôme - avait des attaques intenses de peur ou de panique	Même	Même		
DEPB_265	DEP_265	DEP26ZFF	Symptôme - incapable faire face responsabilités quotidiennes	Ajoutée	Même		
DEPB_266	DEP_266	DEP26ZGG	Symptôme - voulait être seul plutôt que d'être avec des amis	Ajoutée	Même		
DEPB_267	DEP_267	DEP26ZHH	Symptôme - avait moins envie de parler que d'habitude	Ajoutée	Même		
DEPB_268	DEP_268	DEP26ZII	Symptôme - pleurait souvent	Ajoutée	Même		
DEPB_6A	DEP_6A	DEP_26AA	Symptôme - pensait souvent à sa propre mort/mort en général	Même	Même		
DEPB_6B	DEP_6B	DEP_26BB	Symptôme - pensait qu'il vaudrait mieux être mort	Même	Même		
DEPB_A	SUI_01	SUI_01	Suicide - idéation durant pire/mauvais épisode	Même	Même		
DEPB_A1	SUI_02	SUI_02	Suicide - idéation - vie	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
DEPB_A1A,DEPB_A1B	SUI_03	SUI_03	Suicide - idéation - 12 m.	Même	Même		
DEPB_A2	SUI_03_1	SUI_03_1	Suicide - âge de la dernière idéation	Même	Même		
DEPB_B	SUI_04A	SUI_04A	Suicide - planifié durant pire/mauvais épisode	Même	Même		
	SUI_04B	SUI_04B	Suicide - planifié - vie	Même	Ajoutée		
DEPB_B1C	SUI_05	SUI_05	Suicide - planifié - 12 m.	Même	Même		
	SUI_05_1	SUI_05_1	Suicide - âge de la dernière idéation	Même	Ajoutée		
DEPB_C	SUI_06A	SUI_06A	Suicide - tentative - pire/mauvais épisode	Même	Même		
DEPB_CB,DEPB_C1	SUI_06B	SUI_06B	Suicide - tentative - vie	Même	Même		
	SUI_06C	SUI_06C	Suicide - nombre de tentatives - vie	Même	Ajoutée		
DEPB_C1A	SUI_10	SUI_10	Suicide - tentative - 12 m.	Même	Même		
DEPB_C1D	SUI_10_1	SUI_10_1	Suicide - âge - dernière tentative	Même	Même		
DEPB_C3	SUI_11	SUI_11	Suicide - tentative a causé blessure ou intoxication	Même	Même		
DEPB_C4	SUI_12	SUI_12	Suicide - reçu soins médicaux pour tentative plus récente	Même	Même		
DEPB_C5	SUI_13	SUI_13	Suicide - hospitalisé pour nuit suite tentative plus récente	Même	Même		
DEPB_A7	SUI_16	SUI_16	Suicide - idéation - consulté professionnel - 12 m.	Même	Même		
DEPB_D8	SUI_19	SUI_19	Suicide - idéation/tentative -	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			consulté professionnel - 12 m				
DEPB_28	DEP_28	DEP_28A	Interférence-travail/vie sociale/relations personnelles -vie	Même	Même		
DEPB_281	DEP_281	DEP_28B	Interférence - 2 sem+ /travail/vie soc/relations person.-vie	Ajoutée	Même		
DEPB_28A	DEP_28A	DEP_28C	Interférence - incapable d'accomplir les activités quot- vie	Même	Même		
DEPB_29A	DEP_29A	DEP_29A	Dépression - tout épisode -causes phys/méd/drogue/alc	Même	Même		
DEPB_29B	DEP_29B	DEP_29B	Dépression - tous les épisodes - causes phys/méd/drogue/alc	Même	Même		
DEPB_29CA	DEP_29CA	DEP_29CA	Exclusion physique - épuisement	Même	Même		
DEPB_29CB	DEP_29CB	DEP_29CB	Exclusion physique - hyperventilation	Même	Même		
DEPB_29CC	DEP_29CC	DEP_29CC	Exclusion physique - hypocondrie	Même	Même		
DEPB_29CD	DEP_29CD	DEP_29CD	Exclusion physique - cycle menstruel	Même	Même		
DEPB_29CE	DEP_29CE	DEP_29CE	Exclusion physique - grossesse/post-partum	Même	Même		
DEPB_29CF	DEP_29CF	DEP_29CF	Exclusion physique - maladie de la glande thyroïde	Même	Même		
DEPB_29CG	DEP_29CG	DEP_29CG	Exclusion physique - cancer	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
DEPB_29CH	DEP_29CH	DEP_29CH	Exclusion physique - obésité	Même	Même		
DEPB_29CI	DEP_29CI	DEP_29CI	Exclusion physiques - médicaments (excl drogues illicites)	Même	Même		
DEPB_29CJ	DEP_29CJ	DEP_29CJ	Exclusion physique - drogues illicites	Même	Même		
DEPB_29CK	DEP_29CK	DEP_29CK	Exclusion physique - alcool	Même	Même		
DEPB_29CL	DEP_29CL	DEP_29CL	Exclusion physique - déséquilibre chimique/sérotonine	Même	Même		
DEPB_29CM	DEP_29CM	DEP_29CM	Exclusion physique - douleur chronique	Même	Même		
DEPB_29CN	DEP_29CN	DEP_29CN	Exclusion physique - caféine	Même	Même		
DEPB_29CO	DEP_29CO	DEP_29CO	Exclusion physique - aucun diagnostic spécifique	Même	Même		
DEPB_29CP	DEP_29CP	DEP_29CP	Exclusion physique - accident/blessures	Même	Même		
DEPB_29CQ	DEP_29CQ	DEP_29CQ	Exclusion physique - raison émotive - sociale - économique	Même	Même		
DEPB_29CR	DEP_29CR	DEP_29CR	Exclusion physique - autre - blessure physique	Même	Même		
DEPB_30	DEP_30	DEP_30A	Épisode déjà survenu suite à la mort d'un proche	Même	Même		
DEPB_30A	DEP_30A	DEP_30B	Épisodes toujours survenus suite à la mort d'un proche	Même	Même		
DEPB_31	DEP_31	DEP_31	Nombre d'épisodes de 2 semaines ou plus - vie	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
DEPB_372	DEP_372	DEP_37	Dép - 1 épisode vie >= 2 s/survenu : stress/à l'improviste	Même	Même		
DEPB_38	DEP_38	DEP_38A	Dépression - épisode - 12 derniers mois	Même	Même		
DEPB_8A	DEP_8A	DEP_38A1	Dépression - plus récent épisode durant les 12 derniers mois	Même	Même		
DEPB_38B	DEP_38B	DEP_38B	Dépression - nombre de jours sur 365 dans un épisode - 12 m	Même	Même		
DEPB_38C	DEP_38C	DEP_38C	Dépression - plus récent épisode - âge	Même	Même		
DEPB_39A1	DEP_39A1	DEP_39	Dépression - plus long épisode - durée	Même	Même		
DEPB_39B1	DEP_39B1	DEP_39_1	Dép- plus long épisode - unité: jours/semaines/mois/ années	Même	Modifiée		On a consolidé les questions de suivi pour faciliter la programmation.
DEPB_531	DEP_531	DEP_53	Dép - épisodes >= 2 sem/nombre en raison du stress	Même	Même		
DEPB_64A	DEP_64A	DEP_64A	Symptôme - se sentait joyeux - fréquence - 12 m	Même	Même		
DEPB_64B	DEP_64B	DEP_64B	Symptôme - se sentait au ralenti - fréquence -12 m	Même	Même		
DEPB_64C	DEP_64C	DEP_64C	Symptôme - plaisir à lire bon livre/ radio/TV - fréq. - 12 m	Même	Même		
DEPB_65A	DEP_65A	DEP_65A	Symptôme-a pris plaisir aux choses qui plaisaient/fréq -12 m	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
DEPB_65B	DEP_65B	DEP_65B	Symptôme - pouvait rire/voir bon côté des choses - fréq 12 m	Même	Même		
DEPB_65C	DEP_65C	DEP_65C	Symptôme - intéret pour l'apparence physique - fréq -12 m	Même	Même		
DEPB_65D	DEP_65D	DEP_65D	Symptôme - prévoyait apprécier les choses/fréq 12 m	Même	Même		
DEPB_66A	DEP_66A	DEP_66A	Dép - niveau de trouble -capacité d'aller à l'école - 12 m	Même	Même		
DEPB_661	DEP_661	DEP_66B1	Dép - niveau de trouble - capacité de travailler - 12 m	Même	Même		
DEPB_662	DEP_662	DEP_66B2	Dép - niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m	Même	Même		
DEPB_66C	DEP_66C	DEP_66C	Dép - niveau de trouble - relations intimes - 12 m	Même	Même		
DEPB_66D	DEP_66D	DEP_66D	Dép - niveau de trouble - vie sociale - 12 m	Même	Même		
DEPB_68	DEP_68	DEP_68	Dépression - nbre de jours/365 totalement incapable - 12 m	Même	Même		
DEPB_72	DEP_72	DEP_72	Dépression - a consulté un médecin/autre professionnel - vie	Même	Même		
DEPB_86	DEP_86	DEP_86	Dépression - traitement professionnel - 12 m	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
DEPB_87	DEP_87	DEP_87	Dépression - hospitalisé pour une nuit ou plus - vie	Même	Même		
DEPBDA1	DEPDA1	DEPDA1	Dépression - Critère A partie 1 - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDA21	DEPDA21	DEPDA21	Dépression - Critère A partie 2 - Symptôme 1 - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDA22	DEPDA22	DEPDA22	Dépression - Critère A partie 2 - Symptôme 2 - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDA23	DEPDA23	DEPDA23	Dépression - Critère A partie 2 - Symptôme 3 - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDA24	DEPDA24	DEPDA24	Dépression - Critère A partie 2 - Symptôme 4 - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDA25	DEPDA25	DEPDA25	Dépression - Critère A partie 2 - Symptôme 5 - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDA26	DEPDA26	DEPDA26	Dépression - Critère A partie 2 - Symptôme 6 - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDA27	DEPDA27	DEPDA27	Dépression - Critère A partie 2 - Symptôme 7 - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDA28	DEPDA28	DEPDA28	Dépression - Critère A partie 2 -	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			Symptôme 8 - vie - (D)				
DEPBDA29	DEPDA29	DEPDA29	Dépression - Critère A partie 2 - Symptôme 9 - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDA2	DEPDA2	DEPDA2	Dépression - au cours de la vie - Critère A partie 2 - (D)	Même	Même		
DEPBDA	DEPDA	DEPDA	Dépression - Critère A partie 1 et 2 - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDC1	DEPDC1	DEPDC1	Dépression - au cours de la vie - Critère C partie 1 - (D)	Même	Même		
DEPBD664	DEPD664	DEPD664	Dépression - Niveau de trouble (clôture à 4) - 12 m - (D)	Même	Même		
DEPBDC2	DEPDC2	DEPDC2	Dépression - Critère C partie 2 - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDC	DEPDC	DEPDC	Dépression - Critère C partie 1 et 2 - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDE1	DEPDE1	DEPDE1	Dépression - Critère E partie 1 - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDE21	DEPDE21	DEPDE21	Dépression - Critère E partie 2.1 - vie - (D)	Même	Modifiée		Petit changement technique, on n'a pas changé le concept. Voir les spécifications de variables dérivées.
DEPBDE22	DEPDE22	DEPDE22	Dépression - Critère E partie 2.2 - vie - (D)	Même	Modifiée		Petit changement technique, on n'a pas changé le concept.

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
							Voir les spécifications de variables dérivées.
DEPBDE26	DEPDE26	DEPDE26	Dépression - Critère E partie 2.6 - vie - (D)	Même	Modifiée		Petit changement technique, on n'a pas changé le concept. Voir les spécifications de variables dérivées.
DEPBDE2	DEPDE2	DEPDE2	Dépression - Critère E partie 2 - vie - (D)	Même	Modifiée		On a enlevé la durée du premier épisode et de l'épisode au cours de 12 derniers mois comme des variables d'entrée.
DEPBD667	DEPD667	DEPD667	Dépression - Critère E partie 3A1 - Trouble élevé -12 m (D)	Même	Même		
DEPBDE3A	DEPDE3A	DEPDE3A	Dépression - Critère E partie 3A - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDE3B	DEPDE3B	DEPDE3B	Dépression - Critère E partie 3B - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDE3C	DEPDE3C	DEPDE3C	Dépression - Critère E partie 3C - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDE3E	DEPDE3E	DEPDE3E	Dépression - Critère E partie 3E - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDE3	DEPDE3	DEPDE3	Dépression - Critère E partie 3 - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDE	DEPDE	DEPDE	Dépression - Critère E partie 1 & 2 & 3 - vie - (D)	Même	Même		
DEPBDDPS	DEPDDPS	DEPDDPS	Épisode dépressif majeur - Algorithme - vie - (D)	Même	Même		
DEPBD22Y	DEPD22Y	DEPD22Y	Dépression - Pire épisode - durée (D)	Même	Modifiée		Petit changement technique, on n'a pas changé le concept.

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
							Voir les spécifications de variables dérivées.
DEPBD23Y	DEPD23Y	DEPD23Y	Dépression - Plus récent épisode - durée (D)	Même	Modifiée		Petit changement technique, on n'a pas changé le concept. Voir les spécifications de variables dérivées.
DEPBD39Y	DEPD39Y	DEPD39Y	Dépression - Plus long épisode - durée (D)	Même	Modifiée		Petit changement technique, on n'a pas changé le concept. Voir les spécifications de variables dérivées.
DEPBDREC	DEPDREC	DEPDREC	Épisode dépressif majeur - Plus récent épisode - âge - (D)	Même	Modifiée		On a enlevé l'âge à l'apparation comme une variable d'entrée.
DEPBDPER	DEPDPER	DEPDPER	Épisode dépressif majeur - persistance - années - (D)	Même	Modifiée		On a enlevé la durée du premier épisode et de l'épisode au cours de 12 derniers mois comme des variables d'entrée.
DEPBDYA	DEPDYA	DEPDYA	Dépression - Critère A - 12 m - (D)	Même	Même		
DEPBDYB	DEPDYB	DEPDYB	Dépression - Critère B - 12 m - (D)	Même	Modifiée		On a enlevé l'âge à l'apparation comme une variable d'entrée.
DEPBDYC	DEPDYC	DEPDYC	Dépression - Critère C - 12 m - (D)	Même	Même		
DEPBDDY	DEPDDY	DEPDDY	Épisode dépressif majeur - Algorithme - 12 m - (D)	Même	Même		
DEPBFSLT	DEPFSLT	DEPFSLT	Indicateur : suicide - pensée - vie - (I)	Même	Modifiée		On a changé les conditions de variables dérivées, mais on n'a pas changé le concept.

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
							Voir les spécifications de variables dérivées.
DEPBFSYT	DEPFSYT	DEPFSYT	Indicateur : suicide - pensée - 12 m - (I)	Même	Modifiée		On a changé les conditions de variables dérivées, et on a corrigé l'erreur dans le questionnaire. Voir les spécifications de variables dérivées.
	DEPFSLP	DEPFSLP	Indicateur : suicide - projet - vie - (I)	Même	Ajoutée		
	DEPFSYP	DEPFSYP	Indicateur : suicide - projet - 12 m - (I)	Même	Ajoutée		
DEPBFSLA	DEPFSLA	DEPFSLA	Indicateur : suicide - tentative - vie - (I)	Même	Modifiée		On a changé les conditions de variables dérivées, mais on n'a pas changé le concept. Voir les spécifications de variables dérivées.
DEPBFSYA	DEPFSYA	DEPFSYA	Indicateur : suicide - tentative - 12 m - (I)	Même	Modifiée		On a changé les conditions de variables dérivées, et on a corrigé l'erreur dans le questionnaire. Voir les spécifications de variables dérivées.
DEPBFINT	DEPFINT	DEPFINT	Indicateur : dépression - Interférence - 12 m - (I)	Même	Même		
DEPBDINT	DEPDINT	DEPDINT	Dépression - Interférence - Moyenne - 12 m - (D)	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
MIAB_01	MIA_01	MIA_01	Excité/énergique - changements dans pensée/comportement	Même	Même		
MIAB_03	MIA_03	MIA_02	Excité/énergique - pire épisode	Même	Même		
MIAB_03A	MIA_03A	MIA_03A	Excité/énergique - pire épisode - âge	Même	Même		
MIAB_03B1	MIA_03B1	MIA_03B	Excité/énergique - pire épisode - durée	Même	Même		
MIAB_03B2	MIA_03B2	MIA_N03B	Excité/énergique - pire épisode - unité : J/S/M/A	Même	Modifiée		On a consolidé les questions de suivi pour faciliter la programmation.
MIAB_03C	MIA_03C	MIA_03C	Excité/énergique - plus récent épisode - âge	Même	Même		
MIAB_03D1	MIA_03D1	MIA_03D	Excité/énergique - plus récent épisode - durée	Même	Même		
MIAB_03D2	MIA_03D2	MIA_N03D	Excité/énergique - plus récent épisode - unité : J/S/M/A	Même	Modifiée		On a consolidé les questions de suivi pour faciliter la programmation.
MIAB_04	MIA_04	MIA_04	Symptôme - excité/énergique - irritable/grincheux	Même	Même		
MIAB_05	MIA_05	MIA_05A	Irritable/grincheux - changements dans pensée/comportement	Même	Même		
MIAB_06	MIA_06	MIA_05B	Irritable/grincheux - pire épisode - vie	Même	Même		
MIAB_06A	MIA_06A	MIA_06A	Irritable/grincheux - pire épisode - âge	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
MIAB_06B1	MIA_06B1	MIA_06B	Irritable/grincheux - pire épisode - durée	Même	Même		
MIAB_06B2	MIA_06B2	MIA_N06B	Irritable/grincheux - pire épisode - unité: J/S/M/A	Même	Modifiée		On a consolidé les questions de suivi pour faciliter la programmation.
MIAB_06C	MIA_06C	MIA_06C	Irritable/grincheux - plus récent épisode - âge	Même	Même		
MIAB_06D1	MIA_06D1	MIA_06D	Irritable/grincheux - plus récent épisode - durée	Même	Même		
MIAB_06D2	MIA_06D2	MIA_N06D	Irritable/grincheux - plus récent épisode - unité: J/S/M/A	Même	Modifiée		On a consolidé les questions de suivi pour faciliter la programmation.
MIAB_07A	MIA_07A	MIA_07A	Symptôme - devenu nerveux ou agité	Même	Même		
MIAB_07B	MIA_07B	MIA_07B	Symptôme - devenu trop amical / trop familier avec les gens	Même	Même		
MIAB_07C	MIA_07C	MIA_07C	Symptôme - agissait de manière inappropriée	Même	Même		
MIAB_07D	MIA_07D	MIA_07D	Symptôme - avait plus d'intérêt pour le sexe que d'habitude	Même	Même		
MIAB_07E	MIA_07E	MIA_07E	Symptôme - essayait des choses impossibles à réaliser	Même	Même		
MIAB_07F	MIA_07F	MIA_07F	Symptôme - parlait beaucoup plus que d'habitude	Même	Même		
MIAB_07G	MIA_07G	MIA_07G	Symptôme - changeait	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			constamment de projets / activités				
MIAB_07H	MIA_07H	MIA_07H	Symptôme - était facilement distrait	Même	Même		
MIAB_07I	MIA_07I	MIA_07I	Symptôme - pensées passaient d'une chose à l'autre	Même	Même		
MIAB_07J	MIA_07J	MIA_07J	Symptôme - dormait beaucoup moins que d'hab sans fatigue	Même	Même		
MIAB_07K	MIA_07K	MIA_07K	Symptôme - impliqué dans projets insensés pour gagner $	Même	Même		
MIAB_07L	MIA_07L	MIA_07L	Symptôme - dépensait plus d'argent que d'habitude	Même	Même		
MIAB_07M	MIA_07M	MIA_07M	Symptôme - faisait des choses risquées pour le plaisir	Même	Même		
MIAB_07N	MIA_07N	MIA_07N	Symptôme - avait une confiance en soi grandement exagérée	Même	Même		
MIAB_07O	MIA_07O	MIA_07O	Symptôme - pensait être quelqu'un d'autre	Même	Même		
MIAB_08	MIA_08	MIA_08	Nombre d'épisodes où il était excité/irritable - vie	Même	Même		
MIAB_09	MIA_09	MIA_09	Interférence - travail/vie sociale/relation pers - vie	Même	Même		
MIAB_09A	MIA_09A	MIA_09_1	Incapable accomplir activités normales - fréquence - vie	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
MIAB_10A	MIA_10A	MIA_10A	Manie - tout épisode - causes physiques/méd/drogue/alc	Même	Même		
MIAB_10B	MIA_10B	MIA_10B	Manie - tous épisodes - causes physiques/méd/drogue/alc	Même	Même		
MIAB_1CA	MIA_1CA	MIA_10CA	Exclusion physique - épuisement	Même	Même		
MIAB_1CB	MIA_1CB	MIA_10CB	Exclusion physique - hyperventilation	Même	Même		
MIAB_1CC	MIA_1CC	MIA_10CC	Exclusion physique - hypocondrie	Même	Même		
MIAB_1CD	MIA_1CD	MIA_10CD	Exclusion physique - cycle menstruel	Même	Même		
MIAB_1CE	MIA_1CE	MIA_10CE	Exclusion physique - grossesse/post-partum	Même	Même		
MIAB_1CF	MIA_1CF	MIA_10CF	Exclusion physique - maladie de la glande thyroïde	Même	Même		
MIAB_1CG	MIA_1CG	MIA_10CG	Exclusion physique - cancer	Même	Même		
MIAB_1CH	MIA_1CH	MIA_10CH	Exclusion physique - obésité	Même	Même		
MIAB_1CI	MIA_1CI	MIA_10CI	Exclusion physique - médicaments (excl drogues illicites)	Même	Même		
MIAB_1CJ	MIA_1CJ	MIA_10CJ	Exclusion physique - drogues illicites	Même	Même		
MIAB_1CK	MIA_1CK	MIA_10CK	Exclusion physique - alcool	Même	Même		
MIAB_1CL	MIA_1CL	MIA_10CL	Exclusion physique - déséquilibre chimique / sérotonine	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
MIAB_1CM	MIA_1CM	MIA_10CM	Exclusion physique - douleur chronique	Même	Même		
MIAB_1CN	MIA_1CN	MIA_10CN	Exclusion physique - caféine	Même	Même		
MIAB_1CO	MIA_1CO	MIA_10CO	Exclusion physique - aucun diagnostic spécifique	Même	Même		
MIAB_1CP	MIA_1CP	MIA_10CP	Exclusion physique - autre	Même	Même		
MIAB_19	MIA_19	MIA_19A	Manie - épisode - 12 m	Même	Même		
MIAB_191	MIA_191	MIA_19A1	Manie - épisode - 12 m	Même	Même		
MIAB_19A	MIA_19A	MIA_19A2	Manie - plus récent épisode pendant 12 derniers mois	Même	Même		
MIAB_19B	MIA_19B	MIA_19B	Manie - nombre d'épisodes - 12 m	Même	Même		
MIAB_19C	MIA_19C	MIA_19C	Manie - épisode - durée - 12 m	Même	Même		
MIAB_19D	MIA_19D	MIA_19D	Manie - plus récent épisode - âge	Même	Même		
MIAB_20	MIA_20	MIA_20A	Manie - nbre d'épisodes 1 semaine ou plus - vie	Même	Même		
MIAB_201	MIA_201	MIA_21A	Manie - nbre épisodes >= 1 semaine survenu: stress	Même	Même		
MIAB_202	MIA_202	MIA_21B	Manie - 1 épisode >= 1sem/survenu: stress/à l'improviste	Même	Même		
MIAB_22A	MIA_22A	MIA_22A	Manie - plus long épisode - durée	Même	Même		
MIAB_22B	MIA_22B	MIA_N22A	Manie -plus long épisode - unité:	Même	Modifiée		On a consolidé les questions de suivi

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			jours/semaines/mois/ années				pour faciliter la programmation.
MIAB_24	MIA_24	MIA_24	Manie -1 épisode vie <1 sem -survenu: stressé/à l'improviste	Même	Même		
MIAB_27A	MIA_27A	MIA_27A	Manie - niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m	Même	Même		
MIAB_271	MIA_271	MIA_27B1	Manie -niveau de trouble -capacité d'aller à l'école -12 m	Même	Même		
MIAB_272	MIA_272	MIA_27B2	Manie - niveau de trouble - capacité occuper un emploi - 12 m	Même	Même		
MIAB_27C	MIA_27C	MIA_27C	Manie - niveau de trouble - capacité relations proches -12 m	Même	Même		
MIAB_27D	MIA_27D	MIA_27D	Manie - niveau de trouble - vie sociale - 12 m	Même	Même		
MIAB_29	MIA_29	MIA_29	Manie - nbre de jours/365 totalement incapable - 12 m	Même	Même		
MIAB_33	MIA_33	MIA_33	Manie - a consulté médecin/autre professionnel - vie	Même	Même		
MIAB_47	MIA_47	MIA_47	Manie - traitement professionnel - 12 m	Même	Même		
MIAB_48	MIA_48	MIA_48	Manie - hospitalisé pour une nuit ou plus - vie	Même	Même		
MIABDA1	MIADA1	MIADA1	Manie - Critère A partie 1 2002 - vie - (D)	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
MIABDA2	MIADA2	MIADA2	Manie - Critère A partie 2 2002 - vie - (D)	Même	Même		
MIABDA	MIADA	MIADA	Manie - Critère A partie 1 et 2 2002 - vie - (D)	Même	Même		
MIABDB1	MIADB1	MIADB1	Manie - Critère B - Symptôme 1 2002 - vie - (D)	Même	Même		
MIABDB2	MIADB2	MIADB2	Manie - Critère B - Symptôme 2 2002 - vie - (D)	Même	Même		
MIABDB3	MIADB3	MIADB3	Manie - Critère B - Symptôme 3 2002 - vie - (D)	Même	Même		
MIABDB4	MIADB4	MIADB4	Manie - Critère B - Symptôme 4 2002 - vie - (D)	Même	Même		
MIABDB5	MIADB5	MIADB5	Manie - Critère B - Symptôme 5 2002 - vie - (D)	Même	Même		
MIABDB6	MIADB6	MIADB6	Manie - Critère B - Symptôme 6 2002 - vie - (D)	Même	Même		
MIABDB7	MIADB7	MIADB7	Manie - Critère B - Symptôme 7 2002 - vie - (D)	Même	Même		
MIABDBI	MIADBI	MIADBI	Manie - Humeur irritable mais pas excité - vie - (D)	Modifiée	Modifiée	Les conditions de la variable dérivée ont changé, le concept est resté inchangé. Voir spécifications de la VD.	On a changé les conditions de variables dérivées afin de corriger une erreur en 2002.
MIABDB	MIADB	MIADB	Manie - Critère B (Symptômes 1 à 7) 2002 - vie - (D)	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
MIABD277	MIAD277	MIAD277	Manie - Critère D partie 1A - Interférence - 12 m - (D)	Même	Même		
MIABDD1	MIADD1	MIADD1	Manie - Critère D partie 1 2002 - vie - (D)	Même	Même		
MIABDD2	MIADD2	MIADD2	Manie - Critère D partie 2 2002 - vie - (D)	Modifiée	Même	Les conditions de la variable dérivée ont changé, le concept est resté inchangé. Voir spécifications de la VD.	
MIABDD3	MIADD3	MIADD3	Manie - Critère D partie 3 2002 - vie - (D)	Même	Même		
MIABDD	MIADD	MIADD	Manie - Critère D partie 1 & 2 & 3 2002 - vie - (D)	Même	Même		
MIABDEPS	MIADEPS	MIADEPS	Manie - Algorithme 2002 - vie - (D)	Même	Même		
MIABDREC	MIADREC	MIADREC	Manie - Plus récent épisode - âge (D)	Même	Modifiée		On a enlevé l'âge à l'apparation comme une variable d'entrée.
MIABD3BY	MIAD3BY	MIAD3BY	Manie - Pire épisode (excité/énergique) - durée - A - (D)	Même	Modifiée		Petit changement technique, on n'a pas changé le concept. Voir les spécifications de variables dérivées.
MIABD3DY	MIAD3DY	MIAD3DY	Manie - Plus récent épisode (excit/énerg) - durée - A - (D)	Même	Modifiée		Petit changement technique, on n'a pas changé le concept. Voir les spécifications de variables dérivées.

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
MIABD6BY	MIAD6BY	MIAD6BY	Manie - Pire épisode (irritable/grincheux) - durée - A (D)	Même	Modifiée		Petit changement technique, on n'a pas changé le concept. Voir les spécifications de variables dérivées.
MIABD6DY	MIAD6DY	MIAD6DY	Manie - Plus récent épisode (irrit/grnch) - durée - A (D)	Même	Modifiée		Petit changement technique, on n'a pas changé le concept. Voir les spécifications de variables dérivées.
MIABD22Y	MIAD22Y	MIAD22Y	Manie - Plus long épisode - durée - années - (D)	Même	Modifiée		Petit changement technique, on n'a pas changé le concept. Voir les spécifications de variables dérivées.
MIABDPER	MIADPER	MIADPER	Manie - Persistance - années - (D)	Même	Modifiée		On a enlevé la durée du premier épisode et de l'épisode au cours de 12 derniers mois comme des variables d'entrée.
MIABDYA	MIADYA	MIADYA	Manie - Critère A 2002 - 12 m - (D)	Même	Même		
MIABDYB	MIADYB	MIADYB	Manie - Critère B 2002 - 12 m - (D)	Même	Modifiée		On a enlevé l'âge à l'apparation comme une variable d'entrée.
MIABDYC	MIADYC	MIADYC	Manie - Critère C 2002 - 12 m - (D)	Même	Même		
MIABDEY	MIADEY	MIADEY	Manie - Algorithme 2002 - 12 m - (D)	Même	Même		
MIABDINT	MIADINT	MIADINT	Manie - Interférence - Moyenne - 12 m - (D)	Même	Même		
MIABFINT	MIAFINT	MIAFINT	Indicateur : Manie - Interférence - 12 m - (I)	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	HYPDA1	HYPDA1	Hypomanie - Critère A partie 1 - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	HYPDA2	HYPDA2	Hypomanie - Critère A partie 2 - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	HYPDA	HYPDA	Hypomanie - Critère A partie 1 et 2 - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	HYPDB	HYPDB	Hypomanie - Critère B - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	HYPD277	HYPD277	Hypomanie - Interférence - travail/social - (D)	Même	Ajoutée		
	HYPDC	HYPDC	Hypomanie - Critère C - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	HYPDE1	HYPDE1	Hypomanie - Critère E Part 1 - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	HYPDE2	HYPDE2	Hypomanie - Critère E partie 2 - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	HYPDE3	HYPDE3	Hypomanie - Critère E partie 3 - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	HYPDE	HYPDE	Hypomanie - Critère E partie 1 & 2 & 3 - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	HYPDDUR	HYPDDUR	Hypomanie - Plus longue durée (4-6 jours) - (D)	Même	Ajoutée		
	HYPDEPS	HYPDEPS	Hypomanie - Algorithme 2002 - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	HYPDL	HYPDL	Hypomanie - Algorithme - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	HYPDEY	HYPDEY	Hypomanie - Algorithme - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		
	HYPFINT	HYPFINT	Indicateur : Hypomanie -	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			Interférence - 12 m - (I)				
	HYPDINT	HYPDINT	Hypomanie - Interférence - Moyenne - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		
	BIPDA	BIPDA	Trouble bipolaire I et II - super-symptômes -somme «oui» (D)	Même	Ajoutée		
	BIPDB	BIPDB	Trouble bipolaire I et II - super-symptômes -somme «non» (D)	Même	Ajoutée		
	BIPD1	BIPD1	Trouble bipolaire I - Algorithme - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	BIPD2A	BIPD2A	Trouble bipolaire II - Critère A - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	BIPD2B	BIPD2B	Trouble bipolaire II - Critère B - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	BIPD2C	BIPD2C	Trouble bipolaire II - Critère C - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	BIPD2D1	BIPD2D1	Trouble bipolaire II - Critère D - partie 1 - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	BIPD2D2	BIPD2D2	Trouble bipolaire II - Critère D - partie 2 - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	BIPD2D3	BIPD2D3	Trouble bipolaire II - Critère D - partie 3 - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	BIPD2D	BIPD2D	Trouble bipolaire II - Critère D - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	BIPD2	BIPD2	Trouble bipolaire II - Algorithme - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	BIPD1Y	BIPD1Y	Trouble bipolaire I - Algorithme - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	BIPD2Y	BIPD2Y	Trouble bipolaire II - Algorithme - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		
	BIPDL	BIPDL	Trouble Bipolaire - Algorithme - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	BIPDY	BIPDY	Trouble Bipolaire - Algorithme - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		
	BIPDINT1	BIPDINT1	Trouble bipolaire I - Interférence - Moyenne - (D)	Même	Ajoutée		
	BIPDINT2	BIPDINT2	Trouble bipolaire II - Interférence - Moyenne - (D)	Même	Ajoutée		
	BIPDINT	BIPDINT	Trouble bipolaire - Interférence - Moyenne - (D)	Même	Ajoutée		
	BIPFINT1	BIPFINT1	Indicateur: trouble bipolaire I - Interférence - (I)	Même	Ajoutée		
	BIPFINT2	BIPFINT2	Indicateur: trouble bipolaire II - Interférence - (I)	Même	Ajoutée		
	BIPFINT	BIPFINT	Indicateur: trouble bipolaire - Interférence - (I)	Même	Ajoutée		
	GAD_01A	GAD_01A	Inquiet - Crainte ou peur de tout	Même	Ajoutée		
	GAD_01B	GAD_01B	Inquiet - Crainte ou peur de rien en particulier	Même	Ajoutée		
	GAD_01C	GAD_01C	Inquiet - Finances	Même	Ajoutée		
	GAD_01D	GAD_01D	Inquiet - Réussite scolaire ou professionnelle	Même	Ajoutée		
	GAD_01E	GAD_01E	Inquiet - Vie sociale	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	GAD_01F	GAD_01F	Inquiet - Vie amoureuse	Même	Ajoutée		
	GAD_01G	GAD_01G	Inquiet - Relations à l'école ou au travail	Même	Ajoutée		
	GAD_01H	GAD_01H	Inquiet - Relations avec la famille	Même	Ajoutée		
	GAD_01I	GAD_01I	Inquiet - Apparence physique	Même	Ajoutée		
	GAD_01J	GAD_01J	Inquiet - Propre santé physique	Même	Ajoutée		
	GAD_01K	GAD_01K	Inquiet - Propre santé mentale	Même	Ajoutée		
	GAD_01L	GAD_01L	Inquiet - Consommation d'alcool ou de drogues	Même	Ajoutée		
	GAD_01M	GAD_01M	Inquiet - Être loin de chez soi ou séparé des êtres chers	Même	Ajoutée		
	GAD_01N	GAD_01N	Inquiet - Santé ou bien-être des êtres chers	Même	Ajoutée		
	GAD_01O	GAD_01O	Inquiet - Phobies sociales	Même	Ajoutée		
	GAD_01P	GAD_01P	Inquiet - Agoraphobie	Même	Ajoutée		
	GAD_01Q	GAD_01Q	Inquiet - Phobies spécifiques	Même	Ajoutée		
	GAD_01R	GAD_01R	Inquiet - Obsessions	Même	Ajoutée		
	GAD_01S	GAD_01S	Inquiet - Compulsions	Même	Ajoutée		
	GAD_01T	GAD_01T	Inquiet - Crime / violence	Même	Ajoutée		
	GAD_01U	GAD_01U	Inquiet - Économie	Même	Ajoutée		
	GAD_01V	GAD_01V	Inquiet - Environnement	Même	Ajoutée		
	GAD_01W	GAD_01W	Inquiet - Perte des valeurs morales	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	GAD_01X	GAD_01X	Inquiet - Guerre / révolution	Même	Ajoutée		
	GAD_01Y	GAD_01Y	Inquiet - Autre	Même	Ajoutée		
	GAD_02A	GAD_02A	Eu autre source d'inquiétude - 1	Même	Ajoutée		
	GAD_02B	GAD_02B	Eu autre source d'inquiétude - 2	Même	Ajoutée		
	GAD_03	GAD_03	Sentiments d'inquiétude - excessifs/irraisonnés/ plus forts	Même	Ajoutée		
	GAD_04	GAD_04	Difficulté à contrôler sentiments d'anxiété - fréquence	Même	Ajoutée		
	GAD_04A	GAD_04_1	Si nerveux qu'il ne pouvait pas penser à autre chose - fréq	Même	Ajoutée		
	GAD_051	GAD_05	Plus longue période où inquiet presque tous les jours - vie	Même	Ajoutée		
	GAD_05A1	GAD_05_1	Était anxieux presque tous les jours -Plus longue période- mois/années	Même	Ajoutée		
	GAD_05C	GAD_05_3	A eu période d'inquiétude qui a duré 6 mois ou plus	Même	Ajoutée		
	GAD_09A	GAD_09A	Symptôme - senti agité/ énervé/ tendu	Même	Ajoutée		
	GAD_09B	GAD_09B	Symptôme - s'est fatigué facilement	Même	Ajoutée		
	GAD_09C	GAD_09C	Symptôme - était plus irritable que d'habitude	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	GAD_09D	GAD_09D	Symptôme - avait de la difficulté à se concentrer	Même	Ajoutée		
	GAD_09E	GAD_09E	Symptôme - avait muscles tendus douloureux sensibles	Même	Ajoutée		
	GAD_09F	GAD_09F	Symptôme - avait de la diff. à s'endormir ou rester endormi	Même	Ajoutée		
	GAD_10A	GAD_10A	Symptôme - avait coeur qui battait fort ou trop vite	Même	Ajoutée		
	GAD_10B	GAD_10B	Symptôme - transpirait souvent	Même	Ajoutée		
	GAD_10C	GAD_10C	Symptôme - avait des tremblements ou frémissements	Même	Ajoutée		
	GAD_10D	GAD_10D	Symptôme - avait la bouche sèche	Même	Ajoutée		
	GAD_10E	GAD_10E	Symptôme - était triste ou déprimé la plupart du temps	Même	Ajoutée		
	GAD_13A	GAD_13A	Symptôme - avait des vertiges ou étourdissements	Même	Ajoutée		
	GAD_13B	GAD_13B	Symptôme - avait le souffle court	Même	Ajoutée		
	GAD_13C	GAD_13C	Symptôme - avait l'impression d'étouffer	Même	Ajoutée		
	GAD_13D	GAD_13D	Symptôme - ressentait de la douleur/malaise à la poitrine	Même	Ajoutée		
	GAD_13E	GAD_13E	Symptôme - ressentait de la	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			douleur/malaise à l'estomac				
	GAD_13F	GAD_13F	Symptôme - avait des nausées	Même	Ajoutée		
	GAD_13G	GAD_13G	Symptôme - impression choses irréelles	Même	Ajoutée		
	GAD_13H	GAD_13H	Symptôme-avait l'impression que choses n'étaient pas réelles	Même	Ajoutée		
	GAD_13I	GAD_13I	Symptôme - avait peur de perdre le contrôle/devenir fou	Même	Ajoutée		
	GAD_13J	GAD_13J	Symptôme - avait peur de s'évanouir	Même	Ajoutée		
	GAD_13K	GAD_13K	Symptôme - avait peur de mourir	Même	Ajoutée		
	GAD_13L	GAD_13L	Symptôme - avait des bouffées de chaleur ou des frissons	Même	Ajoutée		
	GAD_13M	GAD_13M	Symptôme - était engourdi ou avait des picotements	Même	Ajoutée		
	GAD_13N	GAD_13N	Symptôme - avait impression d'avoir une boule dans la gorge	Même	Ajoutée		
	GAD_13O	GAD_13O	Symptôme - était facilement surpris	Même	Ajoutée		
	GAD_15	GAD_15	Détresse émotionnelle - intensité - vie	Même	Ajoutée		
	GAD_17	GAD_17	Interférence - travail/vie	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			sociale/relations pers - vie				
	GAD_17A	GAD_17_1	Anxiété/incapable accomplir activtés quot/fréquence - life	Même	Ajoutée		
	GAD_18A	GAD_18A	Anxiété - tout épisode/ cause physiques/med/drogue/alc	Même	Ajoutée		
	GAD_18B	GAD_18B	Anxiété - tous épisodes - causes physique/méd/drogues/alc	Même	Ajoutée		
	GAD_18CA	GAD_18CA	Exclusion physique - épuisement	Même	Ajoutée		
	GAD_18CB	GAD_18CB	Exclusion physique - hyperventilation	Même	Ajoutée		
	GAD_18CC	GAD_18CC	Exclusion physique - hypocondrie	Même	Ajoutée		
	GAD_18CD	GAD_18CD	Exclusion physique - cycle menstruel	Même	Ajoutée		
	GAD_18CE	GAD_18CE	Exclusion physique - grossesse / postpartum	Même	Ajoutée		
	GAD_18CF	GAD_18CF	Exclusion physique - maladie de la glande thyroïde	Même	Ajoutée		
	GAD_18CG	GAD_18CG	Exclusion physique - cancer	Même	Ajoutée		
	GAD_18CH	GAD_18CH	Exclusion physique - obésité	Même	Ajoutée		
	GAD_18CI	GAD_18CI	Exclusion physique - médicaments (excl les drogues illicites)	Même	Ajoutée		
	GAD_18CJ	GAD_18CJ	Exclusion physique - drogues illicites	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	GAD_18CK	GAD_18CK	Exclusion physique - alcool	Même	Ajoutée		
	GAD_18CL	GAD_18CL	Exclusion physique - déséquilibre chimique / sérotonine	Même	Ajoutée		
	GAD_18CM	GAD_18CM	Exclusion physique - douleur chronique	Même	Ajoutée		
	GAD_18CN	GAD_18CN	Exclusion physique - caféine	Même	Ajoutée		
	GAD_18CO	GAD_18CO	Exclusion physique - aucun diagnostique spécifique	Même	Ajoutée		
	GAD_18CP	GAD_18CP	Exclusion physique - autre	Même	Ajoutée		
	GAD_26D	GAD_26D	Nombre d'épisodes de 6 mois ou plus - vie	Même	Ajoutée		
	GAD_27	GAD_27	Trble anx gén - épisode - 12 derniers mois	Même	Ajoutée		
	GAD_27A	GAD_27_1	Trble anx gén - plus récent épisode pendant 12 derniers mois	Même	Ajoutée		
	GAD_27C	GAD_27_2	Trble anx gén - plus récent épisode - âge	Même	Ajoutée		
	GAD_311	GAD_31	Trble anx gén - épisodes >=6 mois - nbre résultat de stress	Même	Ajoutée		
	GAD_26C	GAD_32	Trble anx gén/ 1 épi vie >= 6 m/survenu: stress/improviste	Même	Ajoutée		
	GAD_38A	GAD_38A	Trble anx gén - niveau de trouble -	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			tâches ménagères - 12 m				
	GAD_381	GAD_38B1	Trble anx gén - niv. de trouble/capacité d'aller école -12 m	Même	Ajoutée		
	GAD_382	GAD_38B2	Trble anx gén - niv de trouble/capacité de travailler - 12 m	Même	Ajoutée		
	GAD_38C	GAD_38C	Trble anx gén - niv trouble/capacité relations proches -12 m	Même	Ajoutée		
	GAD_38D	GAD_38D	Trble anx gén - niveau de trouble - vie sociale - 12 m	Même	Ajoutée		
	GAD_40	GAD_40	Trble anx gén - nbre de jrs/365 totalement incapable - 12 m.	Même	Ajoutée		
	GAD_44	GAD_44	Trble anx gén - a consulté médecin/autre professionnel - vie	Même	Ajoutée		
	GAD_58	GAD_58	Trble anx gén - traitement professionnel - 12 m	Même	Ajoutée		
	GAD_59	GAD_59	Trble anx gén - hospitalisé pour une nuit ou plus - vie	Même	Ajoutée		
	GADDA1	GADDA1	Trble anx gén - Critère A partie 1 - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	GADDA2	GADDA2	Trble anx gén - Critère A partie 2 - vie - (D)	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	GADDA	GADDA	Trble anx gén - Critère A partie 1 et 2 - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	GADDB	GADDB	Trouble anxiété généralisée - Critère B - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	GADDC1	GADDC1	Trble anx gén - Critère C partie 1 - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	GADDC2	GADDC2	Trble anx gén - Critère C partie 2 - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	GADDC	GADDC	Trouble d'anxiété généralisée - Critère C - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	GADDD	GADDD	Trouble d'anxiété généralisée - Critère D - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	GADDE1	GADDE1	Trble anx gén - Critère E partie 1 - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	GADD384	GADD384	Trble anx gén - niveau de trouble - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		
	GADDE2	GADDE2	Trble anx gén - Critère E partie 2 - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	GADDE	GADDE	Trble anx gén - Critère E partie 1 et 2 - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	GADDGDS	GADDGDS	Trouble d'anxiété généralisée - algorithme - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	GADD05Y	GADD05Y	Trble anx gén - Plus long épisode - durée - (D)	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	GADDREC	GADDREC	Trble anx gén - Plus récent épisode - âge - (D)	Même	Ajoutée		
	GADDYA	GADDYA	Trble anx gén - Critère A - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		
	GADDYB	GADDYB	Trble anx gén - Critère B - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		
	GADDYC	GADDYC	Trble anx gén - Critère C - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		
	GADDDY	GADDDY	Trouble d'anxiété généralisée - algorithme - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		
	GADDINT	GADDINT	Trouble d'anxiété généralisée- Interférence - Moyenne-12 m (D)	Même	Ajoutée		
	GADFINT	GADFINT	Trouble d'anxiété généralisée - Interférence - 12 m - (I)	Même	Ajoutée		
SOPB_01A		SOP_01A	Senti gêné/peur - Rencontrer nouvelles personnes - vie	Ajoutée			
SOPB_01B		SOP_01B	Senti gêné/peur - Parler personnes avec autorité - vie	Ajoutée			
SOPB_01C		SOP_01C	Senti gêné/peur - Prendre parole à une réunion/classe - vie	Ajoutée			
SOPB_01D		SOP_01D	Senti gêné/peur - Se rendre à des fêtes/rencontres sociales - vie	Ajoutée			
SOPB_01E		SOP_01E	Senti gêné/peur - Faire	Ajoutée			

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			présentation/exposé devant public - vie				
SOPB_01F		SOP_01F	Senti gêné/peur - Passer examen imp/entrevue pour emploi - vie	Ajoutée			
SOPB_01G		SOP_01G	Senti gêné/peur - Travailler lorsque quelqu'un vous regarde - vie	Ajoutée			
SOPB_01H		SOP_01H	Senti gêné/peur - Entrer dans pièce où monde présent - vie	Ajoutée			
SOPB_01I		SOP_01I	Senti gêné/peur - Parler à personnes que connait pas bien - vie	Ajoutée			
SOPB_01J		SOP_01J	Senti gêné/peur - Exprimer désac à pers connait pas bien - vie	Ajoutée			
SOPB_01K		SOP_01K	Senti gêné/peur - Écrire/manger/boire et qu'on vous regarde - vie	Ajoutée			
SOPB_01L		SOP_01L	Senti gêné/peur - Utiliser toilette pub autre que maison - vie	Ajoutée			
SOPB_01M		SOP_01M	Senti gêné/peur - Lors de sorties amoureuses - vie	Ajoutée			
SOPB_01N		SOP_01N	Senti gêné/peur - Autre sit sociale/perform où attention - vie	Ajoutée			

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
SOPB_08A		SOP_08A	Situation plus sévère vous avez rougi/tremblé - vie	Ajoutée			
SOPB_08B		SOP_08B	Situation plus sévère peur perdre contrôle intestins/vessie - vie	Ajoutée			
SOPB_08C		SOP_08C	Situation plus sévère peur de vomir - vie	Ajoutée			
SOPB_09A		SOP_09A	Face à la situation - Cœur battu fort ou trop vite - vie	Ajoutée			
SOPB_09B		SOP_09B	Face à la situation - Eu des sueurs - vie	Ajoutée			
SOPB_09C		SOP_09C	Face à la situation - Eu des tremblements - vie	Ajoutée			
SOPB_09D		SOP_09D	Face à la situation - Eu mal à l'estomac - vie	Ajoutée			
SOPB_09E		SOP_09E	Face à la situation - Eu la bouche sèche - vie	Ajoutée			
SOPB_09F		SOP_09F	Face à la situation - Eu des bouffées de chaleur/frissons - vie	Ajoutée			
SOPB_09G		SOP_09G	Face à la situation - Senti engourdi/eu des picotements - vie	Ajoutée			
SOPB_09H		SOP_09H	Face à la situation - Eu du mal à respirer normalement - vie	Ajoutée			
SOPB_09I		SOP_09I	Face à la situation - Eu l'impression d'étouffer - vie	Ajoutée			
SOPB_09J		SOP_09J	Face à la situation - Eu une	Ajoutée			

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			douleur/malaise à la poitrine - vie				
SOPB_09K		SOP_09K	Face à la situation - Eu des vertiges/étourdissements - vie	Ajoutée			
SOPB_09L		SOP_09L	Face à la situation - Eu peur de mourir - vie	Ajoutée			
SOPB_09M		SOP_09M	Face à la situation - Perdre contrôle/devenir fou/évanouir - vie	Ajoutée			
SOPB_09N		SOP_09N	Face à la situation - Impression pas être vraiment là - vie	Ajoutée			
SOPB_09O		SOP_09O	Face à la situation - Impression choses autour pas réelles - vie	Ajoutée			
SOPB_10		SOP_10A	Dans situation - Peur d'avoir une attaque de panique - vie	Ajoutée			
SOPB_10A		SOP_10B	Dans situation - Eu une attaque de panique - vie	Ajoutée			
SOPB_11		SOP_11	Peur d'être piégé ou incapable de vous échapper	Ajoutée			
SOPB_12		SOP_12A	Dans situation - Peur faire chose embarrassant/humiliant - vie	Ajoutée			
SOPB_12A		SOP_12B	Peur de peut-être embarrasser d'autres personnes	Ajoutée			

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
SOPB_13		SOP_13	Peur gens puissent vous regarder/parler de vous/penser choses nég	Ajoutée			
SOPB_14		SOP_14A	Peur d'être le centre d'attention	Ajoutée			
SOPB_14A		SOP_14B	De quoi plus peur lorsque vous deviez faire face situation vie	Ajoutée			
SOPB_15		SOP_15A	Peur liée à la gêne occasionnée par un problème ou un état	Ajoutée			
SOPB_15A		SOP_15BA	Problème ou état de santé mentale ou émotionelle	Ajoutée			
SOPB_15B		SOP_15BB	Problème d'alcool ou de drogue	Ajoutée			
SOPB_15C		SOP_15BC	Problème d'élocution, de vision ou d'audition	Ajoutée			
SOPB_15D		SOP_15BD	Problème moteur ou de coordination	Ajoutée			
SOPB_15E		SOP_15BE	Défigurement facial ou corporel/problème de poids ou image corporelle	Ajoutée			
SOPB_15F		SOP_15BF	Mauvaise odeur ou transpiration	Ajoutée			
SOPB_15G		SOP_15BG	Autre problème de santé physique	Ajoutée			
SOPB_15H		SOP_15BH	Grossesse	Ajoutée			
SOPB_16		SOP_16	À quel point peur ou tendance à éviter situation a troublé - vie	Ajoutée			

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
SOPB_17		SOP_17	Senti bouleversé, inquiet ou déçu de vous-même	Ajoutée			
SOPB_18		SOP_18A	Dernière fois où vous avez eu peur ou évité la situation	Ajoutée			
SOPB_18A		SOP_18B	Âge dernière fois que vous avez eu peur ou évité la situation	Ajoutée			
SOPB_19		SOP_19	Situation aujourd'hui - Intensité de votre peur	Ajoutée			
SOPB_20		SOP_20	Fréquence évité la situation - 12 mo	Ajoutée			
SOPB_21A		SOP_21A	Peur/tendance à éviter situations troublé vos tâches ménagères - 12 mo	Ajoutée			
SOPB_211		SOP_21B1	À quel point troublé votre capacité d'aller à l'école	Ajoutée			
SOPB_212		SOP_21B2	À quel point troublé votre capacité de travailler à un emploi	Ajoutée			
SOPB_21C		SOP_21C	À quel point troublé capacité établir/maintenir rel proche avec autres	Ajoutée			
SOPB_21D		SOP_21D	À quel point troublé votre vie sociale	Ajoutée			
SOPB_23		SOP_23	Totalement incapable de travailler/accomplir activités normales	Ajoutée			
SOPB_25		SOP_25A	Consulté médecin/prof au sujet	Ajoutée			

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			peur ou tendance à éviter - vie				
SOPB_38		SOP_38	Reçu des traitements professionnels pour votre peur - 12 mo	Ajoutée			
SOPB_39A		SOP_39A	Hospitalisé pour une nuit ou plus à cause de votre peur - vie	Ajoutée			
SOPBDA1		SOPDA1	Phobie sociale vie - critère A, partie 1	Ajoutée			
SOPBDA2		SOPDA2	Phobie sociale vie - critère A, partie 2	Ajoutée			
SOPBDA		SOPDA	Phobie sociale vie - critère A (parties 1 et 2 combinées)	Ajoutée			
SOPBDB		SOPDB	Phobie sociale vie - critère B	Ajoutée			
SOPBDC		SOPDC	Phobie sociale vie - critère C	Ajoutée			
SOPBDD1		SOPDD1	Phobie sociale vie - critère D, partie 1	Ajoutée			
		SOPD09	Symptômes d'anxiété ou de panique	Ajoutée			
SOPBDD2		SOPDD2	Phobie sociale vie - critère D, partie 2	Ajoutée			
SOPBDD		SOPDD	Phobie sociale vie - critère D (parties 1 et 2 combinées)	Ajoutée			
		SOPD215	Perturbation sociale et professionnelle	Ajoutée			
SOPBDE		SOPDE	Phobie sociale vie - critère E	Ajoutée			
SOPBBDSP		SOPD02	Algorithme pour la phobie sociale vie	Ajoutée		Le critère F est exclu en 2022	
SOPBDREC		SOPDREC	Phobie sociale - âge au moment de	Ajoutée			

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			l'épisode le plus récent				
SOPBDYA		SOPDYA	Phobie sociale au cours des 12 derniers mois - critère A	Ajoutée			
SOPBDYB		SOPDYB	Phobie sociale au cours des 12 derniers mois - critère B	Ajoutée			
SOPBDYC		SOPDYC	Phobie sociale au cours des 12 derniers mois - critère C	Ajoutée			
SOPBDPY		SOPDPY	Algorithme pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois	Ajoutée			
SOPBDINT		SOPDINT	Trouble attribuable à la phobie sociale - moyenne	Ajoutée			
SOPBFINT		SOPFINT	Indicateur de la perturbation attribuable à la phobie sociale	Ajoutée			
	SMK_01A	SMK_201A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	Même	Ajoutée		
	SMK_01B	SMK_201B	A déjà fumé toute une cigarette entière	Même	Ajoutée		
	SMK_01C	SMK_201C	Âge - a fumé première cigarette entière	Même	Ajoutée		
	SMK_202	SMK_202	Genre de fumeur	Même	Ajoutée		
	SMK_203	SMK_203	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quotidien)	Même	Ajoutée		
	SMK_204	SMK_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	SMK_05B	SMK_205B	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	Même	Ajoutée		
	SMK_05C	SMK_205C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	Même	Ajoutée		
	SMK_05D	SMK_205D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	Même	Ajoutée		
	SMK_06A	SMK_206A	A cessé de fumer - quand (jamais été fumeur quotidien)	Même	Ajoutée		
	SMK_06B	SMK_206B	A cessé de fumer - mois (jamais été fumeur quotidien)	Même	Ajoutée		
	SMK_06C	SMK_206C	Nombre d'années depuis cessé de fumer	Même	Ajoutée		
	SMK_207	SMK_207	Âge - commencé à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.)	Même	Ajoutée		
	SMK_208	SMK_208	N. cigarettes habit. fumées par jour (ancien fumeur quot.)	Même	Ajoutée		
	SMK_09A	SMK_209A	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)	Même	Ajoutée		
	SMK_09B	SMK_209B	A cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur quotidien)	Même	Ajoutée		
	SMK_09C	SMK_209C	Nbre/années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.)	Même	Ajoutée		
	SMK_10	SMK_210A	A complètement cessé de fumer	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			(ancien fumeur quotidien)				
	SMK_10A	SMK_210B	A complètement cessé de fumer-quand(ancien fumeur quotidien)	Même	Ajoutée		
	SMK_10B	SMK_210C	A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quotidien)	Même	Ajoutée		
	SMK_10C	SMK_210D	A cessé de fumer complètement - nbre d'années (ancien fumeur quot)	Même	Ajoutée		
	SMKDSTY	SMKDSTY	Type de fumeur - (D)	Même	Ajoutée		
	SMKDSTP	SMKDSTP	Nombre d'années depuis arrêté de fumer complètement - (D)	Même	Ajoutée		
	SMKDYCS	SMKDYCS	Nombre d'années rép. fume (fume act. tout les jours) - (D)	Même	Ajoutée		
ALCB_1	AUD_01	AUD_01	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	Même	Même		
ALCB_2	AUD_02	AUD_02	Consommation d'alcool - fréquence - 12 m	Même	Même		
ALCB_3	AUD_03	AUD_03	Consommation de 5 verres ou plus - fréquence - 12 m	Même	Même		
ALCB_5B	AUD_04	AUD_04	A déjà pris un verre d'alcool - vie	Même	Même		
	AUD_05	AUD_05	Consommation de 12 verres ou plus - fréquence - 12 m	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	AUD_06	AUD_06	Nombre de verres par jour - 12 m	Même	Ajoutée		
	AUD_08	AUD_08	A bu plus dans années précédentes que 12 derniers mois	Même	Ajoutée		
	AUD_10	AUD_10	Consommation d'alcool - années a bu le plus - fréquence	Même	Ajoutée		
	AUD_11	AUD_11	Verres par jour - années a bu le plus	Même	Ajoutée		
	AUD_13A	AUD_13A	Abus d'alcool - en conflit/responsabilités - vie	Même	Ajoutée		
	AUD_13A1	AUD_13A1	Abus d'alcool - problèmes avec gens - vie	Même	Ajoutée		
	AUD_13B	AUD_13B	Abus d'alcool - continué de consommer/problèmes - vie	Même	Ajoutée		
	AUD_13C	AUD_13C	Abus d'alcool - aurait pu être blessé - vie	Même	Ajoutée		
	AUD_13D	AUD_13D	Abus d'alcool - contact avec la police - vie	Même	Ajoutée		
	AUD_13E	AUD_13E	Abus d'alcool - contact avec la police - nbre fois - vie	Même	Ajoutée		
	AUD_16	AUD_16	Abus d'alcool - dernière fois eu problème	Même	Ajoutée		
	AUD_17	AUD_17	Abus d'alcool - plus récent problème - âge	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	AUD_19A	AUD_19A	Dépendance à l'alcool - désir fort de boire - vie	Même	Ajoutée		
	AUD_19A1	AUD_19A1	Dépendance à l'alcool - a besoin de plus - vie	Même	Ajoutée		
	AUD_19B	AUD_19B	Dépendance à l'alcool - sevrage - vie	Même	Ajoutée		
	AUD_19C	AUD_19C	Dépendance à l'alcool - consomme pour éviter sevrage - vie	Même	Ajoutée		
	AUD_19D	AUD_19D	Dépendance à l'alcool - consomme plus que prévu - vie	Même	Ajoutée		
	AUD_19E	AUD_19E	Dépendance à l'alcool - consomme plus souvent que prévu -vie	Même	Ajoutée		
	AUD_19F	AUD_19F	Dépendance à l'alcool - soûl sans le vouloir - vie	Même	Ajoutée		
	AUD_19G	AUD_19G	Dépendance à l'alcool -incapable de réduire consommation-vie	Même	Ajoutée		
	AUD_19H	AUD_19H	Dépendance à l'alcool - jours passés à boire/récupérer - vie	Même	Ajoutée		
	AUD_19I	AUD_19I	Dépendance à l'alcool - réduit activités - vie	Même	Ajoutée		
	AUD_19J	AUD_19J	Dépendance à l'alcool -consommé	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			malgré sérieux problèmes-vie				
	AUD_23	AUD_23	Dépendance à l'alcool - 3+ symptômes dans même 12 m - vie	Même	Ajoutée		
	AUD_25	AUD_25	Dépendance à l'alcool - dernière fois eu problème	Même	Ajoutée		
	AUD_26	AUD_26	Dépendance à l'alcool - plus récent problème - âge	Même	Ajoutée		
	AUD_29	AUD_29	Dépendance à l'alcool - nbre fois tentative pour arrêter	Même	Ajoutée		
ALDB_15A	AUD_35A	AUD_35A	Alcool - niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m	Même	Modifiée		La question dans l'enquête de 2012 se fonde sur une période qui a duré un mois ou plus au cours des 12 derniers mois pendant laquelle vous buviez le plus.
ALDB_5B1	AUD_351	AUD_35B1	Alcool - niveau de trouble/capacité d'aller à l'école - 12 m	Même	Modifiée		La question dans l'enquête de 2012 se fonde sur une période qui a duré un mois ou plus au cours des 12 derniers mois pendant laquelle vous buviez le plus.
ALDB_5B2	AUD_352	AUD_35B2	Alcool - niveau de trouble/capacité de travailler - 12 m	Même	Modifiée		La question dans l'enquête de 2012 se fonde sur une période qui a duré un mois ou plus au cours des 12

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
							derniers mois pendant laquelle vous buviez le plus.
ALDB_15C	AUD_35C	AUD_35C	Alcool - niveau de trouble - relations proches - 12 m	Même	Modifiée		La question dans l'enquête de 2012 se fonde sur une période qui a duré un mois ou plus au cours des 12 derniers mois pendant laquelle vous buviez le plus.
AUDB_15D	AUD_35D	AUD_35D	Alcool - niveau de trouble - vie sociale - 12 m	Même	Modifiée		La question dans l'enquête de 2012 se fonde sur une période qui a duré un mois ou plus au cours des 12 derniers mois pendant laquelle vous buviez le plus.
	AUD_36A	AUD_36A	Alcool - nbre de jours/365 totalement incapable - 12 m	Même	Ajoutée		
	AUD_39	AUD_39	Alcool - a consulté médecin/autre professionnel - vie	Même	Ajoutée		
	AUD_41	AUD_41	Alcool - reçu traitement professionnel - 12 m	Même	Ajoutée		
	AUD_42	AUD_42	Alcool - hospitalisé pour une nuit - vie	Même	Ajoutée		
	AUDDTTM	AUDDTTM	Alcool - Genre de buveur - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		
	AUDFWDY	AUDFWDY	Indicateur: déjà consommé plus que 12 derniers mois (I)	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	AUDDWDY	AUDDWDY	Alcool - Type de buveur-année plus fréquent consommation (D)	Même	Ajoutée		
	AUDDDA	AUDDDA	Dépendance à l'alcool - Critère A - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	AUDDDB	AUDDDB	Dépendance à l'alcool - Critère B - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	AUDDLD	AUDDLD	Dépendance à l'alcool - Algorithme - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	AUDDYD	AUDDYD	Dépendance à l'alcool - Algorithme - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		
	AUDDAA	AUDDAA	Abus à l'alcool - Critère A - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	AUDDAB	AUDDAB	Abus à l'alcool - Critère B - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	AUDDLA	AUDDLA	Abus d'alcool - Algorithme - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	AUDDYA	AUDDYA	Abus à l'alcool - Algorithme - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		
	AUDDL	AUDDL	Abus ou dépendance à l'alcool - Algorithme - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	AUDDY	AUDDY	Abus ou dépendance à l'alcool - Algorithme - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		
ALDBFINT	AUDFINT	AUDFINT	Indicateur : alcool - Interférence - 12 m - (I)	Même	Modifiée		On a changé les conditions dans les spécifications de variables dérivées pour représenter des

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
							nouvelles questions et des nouveaux critères de troubles.
ALDBDINT	AUDDINT	AUDDINT	Alcool - Interférence - Moyenne - 12 m - (D)	Même	Modifiée		On a changé les conditions dans les spécifications de variables dérivées pour représenter des nouvelles questions et des nouveaux critères de troubles.
	SUD_01A	SUD_01A	Sédatif - consommé fins non médicales - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_01B	SUD_01B	Sédatif- consommé prescrit - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_01C	SUD_01C	Sédatif - prescrit - ne peut arrêter d'en prendre	Même	Ajoutée		
	SUD_01D	SUD_01D	Sédatif - consommé fins non médicales - 12 m	Même	Ajoutée		
	SUD_01E	SUD_01E	Sédatif - fréquence - 12 m	Même	Ajoutée		
	SUD_02A	SUD_02A	Stimulant - consommé fins non médicales - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_02B	SUD_02B	Stimulant - consommé prescrit - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_02C	SUD_02C	Stimulant - prescrit - ne peut arrêter d'en prendre	Même	Ajoutée		
	SUD_02D	SUD_02D	Simulant - consommé fins non médicales - 12 m	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	SUD_02E	SUD_02E	Stimulant - fréquence - 12 m	Même	Ajoutée		
	SUD_03A	SUD_03A	Analgésique - consommé fins non médicales - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_03B	SUD_03B	Analgésique - consommé prescrit - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_03C	SUD_03C	Analgésique - prescrit - ne peut arrêter d'en prendre	Même	Ajoutée		
	SUD_03D	SUD_03D	Analgésique - consommé fins non médicales - 12 m	Même	Ajoutée		
	SUD_03E	SUD_03E	Analgésique - fréquence - 12 m	Même	Ajoutée		
IDGB_01	SUD_04A	SUD_04A	Cannabis - consommé - vie	Même	Même		
IDGB_02	SUD_04B	SUD_04B	Cannabis - consommé - 12 m	Même	Même		
IDGB_03	SUD_04C	SUD_04C	Cannabis - fréquence - 12 m	Même	Même		
	SUD_04D	SUD_04D	Cannabis - consommé plus dans le passé	Même	Ajoutée		
	SUD_04E	SUD_04E	Cannabis - année consommé plus souvent - fréquence	Même	Ajoutée		
	SUD_04F	SUD_04F	Cannabis - nbre fois consommé - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_04G	SUD_04G	Cannabis - consommé plus de 50 fois - vie	Même	Ajoutée		
IDGB_04	SUD_05A	SUD_05A	Cocaïne ou crack - consommé - vie	Même	Modifiée		On a changé la forumlation de la question pour

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
							conformer à la liste de drogues de "CIDI"
IDGB_05	SUD_05B	SUD_05B	Cocaïne ou crack - consommé - 12 m	Même	Modifiée		On a changé la forumlation de la question pour conformer à la liste de drogues de "CIDI"
IDGB_06	SUD_05C	SUD_05C	Cocaïne ou crack - fréquence - 12 m	Même	Modifiée		On a changé la forumlation de la question pour conformer à la liste de drogues de "CIDI"
IDGB_10	SUD_06A	SUD_06A	Ecstasy (MDMA) - consommé - vie	Même	Modifiée		On a changé la forumlation de la question pour conformer à la liste de drogues de "CIDI"
IDGB_11	SUD_06B	SUD_06B	Ecstasy (MDMA) - consommé - 12 m	Même	Modifiée		On a changé la forumlation de la question pour conformer à la liste de drogues de "CIDI"
IDGB_12	SUD_06C	SUD_06C	Ecstasy (MDMA) - fréquence - 12 m	Même	Modifiée		On a changé la forumlation de la question pour conformer à la liste de drogues de "CIDI"
IDGB_13	SUD_07A	SUD_07A	Hallucinogènes/ PCP/ LSD - consommé - vie	Même	Modifiée		On a changé la forumlation de la question pour conformer à la liste de drogues de "CIDI"
IDGB_14	SUD_07B	SUD_07B	Hallucinogènes/ PCP/ LSD - consommé - 12 m	Même	Modifiée		On a changé la forumlation de la question pour

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
							conformer à la liste de drogues de "CIDI"
IDGB_15	SUD_07C	SUD_07C	Hallucinogènes/ PCP/ LSD - fréquence - 12 m	Même	Modifiée		On a changé la forumlation de la question pour conformer à la liste de drogues de "CIDI"
IDGB_19	SUD_08A	SUD_08A	Héroïne - consommé - vie	Même	Modifiée		On a changé la forumlation de la question pour conformer à la liste de drogues de "CIDI"
IDGB_20	SUD_08B	SUD_08B	Héroïne - consommé - 12 m	Même	Modifiée		On a changé la forumlation de la question pour conformer à la liste de drogues de "CIDI"
IDGB_21	SUD_08C	SUD_08C	Héroïne - fréquence - 12 m	Même	Modifiée		On a changé la forumlation de la question pour conformer à la liste de drogues de "CIDI"
IDGB_16	SUD_09A	SUD_09A	Inhalants ou solvants - consommé - vie	Même	Modifiée		On a changé la forumlation de la question pour conformer à la liste de drogues de "CIDI"
IDGB_17	SUD_09B	SUD_09B	Inhalants ou solvants - consommé - 12 m	Même	Modifiée		On a changé la forumlation de la question pour conformer à la liste de drogues de "CIDI"
IDGB_18	SUD_09C	SUD_09C	Inhalants ou des solvants - fréquence - 12 m	Même	Modifiée		On a changé la forumlation de la question pour

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
							conformer à la liste de drogues de "CIDI"
	SUD_10A	SUD_10A	Autres drogues illégales - consommé - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_10B	SUD_10B	Autres drogues illégales - consommé - 12 m	Même	Ajoutée		
	SUD_10C	SUD_10C	Autres drogues illégales - fréquence - 12 m	Même	Ajoutée		
	SUD_21	SUD_21	Abus de cannabis- en conflit/responsabilités - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_22	SUD_22	Abus de cannabis - problèmes avec gens - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_23	SUD_23	Abus de cannabis - continué de prendre/problèmes - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_24	SUD_24	Abus de cannabis - aurait pu être blessé - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_25	SUD_25	Abus de cannabis - contact avec la police - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_28	SUD_28	Abus de cannabis - dernière fois eu problème	Même	Ajoutée		
	SUD_29	SUD_29	Abus de cannabis- plus récent problème - âge	Même	Ajoutée		
	SUD_31	SUD_31	Dépendance au cannabis - forte envie de consommer - vie	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	SUD_32	SUD_32	Dépendance au cannabis - a besoin de plus - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_33	SUD_33	Dépendance au cannabis - sevrage - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_34	SUD_34	Dépendance au cannabis - consomme pour éviter sevrage - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_35	SUD_35	Dépendance au cannabis - consomme plus que prévu - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_36	SUD_36	Dépendance au cannabis - consomme plus souvent que prévu-vie	Même	Ajoutée		
	SUD_37	SUD_37	Dépendance au cannabis - incapable de réduire consomm. -vie	Même	Ajoutée		
	SUD_38	SUD_38	Dépendance au cannabis -passés jours à prendre/récupérer-vie	Même	Ajoutée		
	SUD_39	SUD_39	Dépendance au cannabis - réduit activités - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_40	SUD_40	Dépendance au cannabis-consommé malgré sérieux problèmes-vie	Même	Ajoutée		
	SUD_43	SUD_43	Dépendence au cannabis - 3+	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			symptômes dans même 12 m - vie				
	SUD_45	SUD_45	Dépendance au cannabis - dernière fois eu problème	Même	Ajoutée		
	SUD_46	SUD_46	Dépendance au cannabis - plus récent probleme - âge	Même	Ajoutée		
	SUD_51	SUD_51	Abus de drogues excl cann - en conflit/responsabilités - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_52	SUD_52	Abus de drogues excl cann - problème avec gens - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_53	SUD_53	Abus de drogues excl cann -continué de prendre/problèmes- vie	Même	Ajoutée		
	SUD_54	SUD_54	Abus de drogues excl cann - aurait pu être blessé - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_55	SUD_55	Abus de drogues excl cann - contact avec la police - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_58	SUD_58	Abus de drogues excl cann - dernière fois eu problème	Même	Ajoutée		
	SUD_59	SUD_59	Abus de drogues excl cann - plus récent problème - âge	Même	Ajoutée		
	SUD_61	SUD_61	Dépend aux drogues excl cann - forte envie de consommer -vie	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	SUD_62	SUD_62	Dépend aux drogues excl cann - a besoin de plus - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_63	SUD_63	Dépend aux drogues excl cann - sevrage - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_64	SUD_64	Dépend aux drogues excl cann-consomme pr éviter sevrage-vie	Même	Ajoutée		
	SUD_65	SUD_65	Dépend aux drogues excl cann - consomme plus que prévu - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_66	SUD_66	Dépend aux drogues excl cann-consomme plus souvent prévu-vie	Même	Ajoutée		
	SUD_67	SUD_67	Dépend aux drogues excl cann - incapable réduire consomm-vie	Même	Ajoutée		
	SUD_68	SUD_68	Dépend aux drogues excl cann -passés jours prendre/récup-vie	Même	Ajoutée		
	SUD_69	SUD_69	Dépend aux drogues excl cann - réduit activités - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_70	SUD_70	Dépend aux drogues excl cann -cons malgré sérieux problm-vie	Même	Ajoutée		
	SUD_73	SUD_73	Dépend aux drogues excl cann-3+ symptômes dans même 12 m-vie	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	SUD_75	SUD_75	Dépend aux drogues excl cann - dernière fois eu problème	Même	Ajoutée		
	SUD_76	SUD_76	Dépend aux drogues excl cann - plus récent problème - âge	Même	Ajoutée		
	SUD_81A	SUD_81A	Drogues - niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m	Même	Ajoutée		
	SUD_811	SUD_81B1	Drogues - niveau de trouble/capacité d'aller à l'école - 12m	Même	Ajoutée		
	SUD_812	SUD_81B2	Drogues - niveau de trouble/capacité de travailler - 12 m	Même	Ajoutée		
	SUD_81C	SUD_81C	Drogues - niveau de trouble - relations proches - 12 m	Même	Ajoutée		
	SUD_81D	SUD_81D	Drogues - niveau de trouble - vie sociale - 12 m	Même	Ajoutée		
	SUD_83	SUD_83	Drogues - nbre de jours/365 totalement incapable - 12 m	Même	Ajoutée		
	SUD_87	SUD_87	Drogues - Aide reçue - A déjà consulté un professionnel - vie	Même	Ajoutée		
	SUD_89	SUD_89	Drogues - Aide reçue - Traitement d'un professionnel - 12 mo	Même	Ajoutée		
	SUD_90	SUD_90	Drogues - Aide reçue - A déjà été hospitalisé au moins une nuit - vie	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	SUDFLTU	SUDFLTU	Sédatif - consommé fins non médicales - vie - (I)	Même	Ajoutée		
	SUDFLSU	SUDFLSU	Stimulant - consommé fins non médicales - vie - (I)	Même	Ajoutée		
	SUDFLAU	SUDFLAU	Analgésique - consommé fins non médicales - vie - (I)	Même	Ajoutée		
IDGBFLCA	SUDFLCA	SUDFLCA	Cannabis - consommé (incl une seule fois consom) - vie - (I)	Même	Même		
IDGBFLCM	SUDFLCM	SUDFLCM	Cannabis - consommé (excl une seule fois) - vie - (I)	Même	Même		
IDGBFYCM	SUDFYCM	SUDFYCM	Cannabis - consommé (excl une seule fois) - 12 m - (I)	Même	Même		
IDGBFLCO	SUDFLCO	SUDFLCO	Cocaïne/crack - consommé - vie - (I)	Même	Modifiée		On a changé le libellé des questions d'entrée.
IDGBFLEX	SUDFLEX	SUDFLEX	MDMA (ecstasy) - consommé - vie - (I)	Même	Modifiée		On a changé le libellé des questions d'entrée.
IDGBFLEX	SUDFLHA	SUDFLHA	Hallucinogènes/ PCP/ LSD - consommé - vie - (I)	Même	Modifiée		On a changé le libellé des questions d'entrée.
IDGBFLHE	SUDFLHE	SUDFLHE	Héroïne - consommé - vie - (I)	Même	Modifiée		On a changé le libellé des questions d'entrée.
IDGBFLGL	SUDFLGL	SUDFLGL	Inhalant ou solvant - used - vie - (I)	Même	Modifiée		On a changé le libellé des questions d'entrée.
	SUDFLAO	SUDFLAO	Tout autre drogue - consommé - vie - (I)	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	SUDDLAI	SUDDLAI	Tout consom de drogues (incl une seule fois cann) - vie -(D)	Même	Ajoutée		
	SUDDLAE	SUDDLAE	Tout consommation de drogues (excl seule fois cann) -vie (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDLID	SUDDLID	Tout consommation de drogues (excl consom cann) - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDYAI	SUDDYAI	Tout consom de drogues (incl une seule fois cann) - 12 m (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDYAE	SUDDYAE	Tout consom de drogues (excl une seule fois cann) - 12 m (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDYID	SUDDYID	Tout consom de drogues (excl consom cann) - 12 m (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDCDA	SUDDCDA	Dépendance au cannabis - Critère A - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDCDB	SUDDCDB	Dépendence au cannabis - Critère B - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDLCD	SUDDLCD	Dépendance au cannabis - Algorithme - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDYCD	SUDDYCD	Dépendance au cannabis - Algorithme - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	SUDDODA	SUDDODA	Dépendance aux drogues (excl cann) - Critère A - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDODB	SUDDODB	Dépendance aux drogues (excl cann) - Critère B - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDLOD	SUDDLOD	Dépendence aux drogues (excl cann) - Algorithme - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDYOD	SUDDYOD	Dépendance aux drogues (excl cann) - Algorithme - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDCAA	SUDDCAA	Abus de cannabis - Critère A - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDCAB	SUDDCAB	Abus de cannabis - Critère B - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDLCA	SUDDLCA	Abus de cannabis - Algorithme - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDYCA	SUDDYCA	Abus de cannabis - Algorithme - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDOAA	SUDDOAA	Abus de drogues (excl cann) - Critère A - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDOAB	SUDDOAB	Abus de drogues (excl cann) - Critère B - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDLOA	SUDDLOA	Abus de drogues (excl cann) - Algorithme - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDYOA	SUDDYOA	Abus de drogues (excl cann) - Algorithme - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	SUDDLC	SUDDLC	Abus ou dépendance au cannabis - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDYC	SUDDYC	Abus ou dépendance au cannabis - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDLO	SUDDLO	Abus ou dépendance au drogues (excl cann) - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDYO	SUDDYO	Abuse ou dépendance aux drogues (excl cann) - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDL	SUDDL	Abus ou dépendance aux drogues (inclusion cann) - vie - (D)	Même	Ajoutée		
	SUDDY	SUDDY	Abus ou dépendance aux drogues (inclusion cann) - 12 m - (D)	Même	Ajoutée		
IDGBDINT	SUDFINT	SUDFINT	Consommation de drogues - Interférence - 12 m - (I)	Même	Modifiée		On a changé les conditions dans les spécifications de variables dérivées pour représenter des nouvelles questions et des nouveaux critères de troubles.
IDGBFINT	SUDDINT	SUDDINT	Consommation de drogues - Interférence - Moyenne - 12 m (D)	Même	Modifiée		On a changé les conditions dans les spécifications de variables dérivées pour représenter des nouvelles questions

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
							et des nouveaux critères de troubles.
MHPBFL	MHPFL	MHPFL	Tout trouble sélectionné (mental ou avec substances)-vie (I)	Modifiée	Modifiée	Les conditions de la variable dérivée ont changé, le concept est resté inchangé. Voir spécifications de la VD.	Les troubles sélectionnés sont différents entre les cycles.
MHPBFLM	MHPFLM	MHPFLM	Tout trouble de l'humeur - vie - (I)	Même	Modifiée		Les troubles sélectionnés sont différents entre les cycles.
		MHPFLA	Tout trouble anxieux - la vie	Ajoutée			
	MHPFLSA	MHPFLSA	Tout trouble lié utilisation substances (alcool/drog)-vie(I)	Même	Ajoutée		
MHPBFY	MHPFY	MHPFY	Tout trouble sélectionné (mental/substances) - 12 m - (I)	Modifiée	Modifiée	Les conditions de la variable dérivée ont changé, le concept est resté inchangé. Voir spécifications de la VD.	Les troubles sélectionnés sont différents entre les cycles.
MHPBFYM	MHPFYM	MHPFYM	Tout trouble de l'humeur - 12 m - (I)	Même	Modifiée		Les troubles sélectionnés sont différents entre les cycles.
		MHPFYA	Tout trouble anxieux - 12 m	Ajoutée			
MHPBFYSA	MHPFYSA	MHPFYSA	Tout trouble lié utilisation substances (alcool/drog)-12m(I)	Même	Modifiée		Les troubles sélectionnés sont différents entre les cycles.
MHPBFINT	MHPFINT	MHPFINT	Tout trouble sélectionné	Modifiée	Modifiée	Les conditions de la variable dérivée ont changé, le concept	Les troubles sélectionnés sont

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			(mental/subst)-Interfère -12 m (I)			est resté inchangé. Voir spécifications de la VD.	différents entre les cycles.
	DAS_01	DAS_01	Difficulté - tenir debout pour de longues périodes - 30 j	Même	Ajoutée		
	DAS_02	DAS_02	Difficulté - responsabilités à la maison - 30 j	Même	Ajoutée		
	DAS_03	DAS_03	Difficulté - apprendre une nouvelle tâche - 30 j	Même	Ajoutée		
	DAS_04	DAS_04	Difficulté - participer à des activités communautaires -30 j	Même	Ajoutée		
	DAS_05	DAS_05	Affecté émotionnellement par votre état de santé - 30 j	Même	Ajoutée		
	DAS_06	DAS_06	Difficulté - à se concentrer - 30 j	Même	Ajoutée		
	DAS_07	DAS_07	Difficulté - marcher sur une longue distance - 30 j	Même	Ajoutée		
	DAS_08	DAS_08	Difficulté - laver tout votre corps - 30 j	Même	Ajoutée		
	DAS_09	DAS_09	Difficulté - à s'habiller - 30 j	Même	Ajoutée		
	DAS_10	DAS_10	Difficulté - interagir gens vous ne connaissez pas - 30 j	Même	Ajoutée		
	DAS_11	DAS_11	Difficulté - maintenir une amitié - 30 j	Même	Ajoutée		
	DAS_12	DAS_12	Difficulté - travailler/étudier	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			quotidiennement - 30 j				
	DAS_13	DAS_13	Trouble occasionné - difficultés - 30 jours	Même	Ajoutée		
	DASDSCR	DASDSCR	Plan d'évaluation des invalidités de l'OMS-score - (D)	Même	Ajoutée		
SERB_02	SR1_001	SR1_001	Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - 12 m	Même	Modifiée		
	SR1_002	SR1_002	Hospitalisé pour santé mentale/alc/drogues - nmbr fois -12 m	Même	Ajoutée		
	SR1_003	SR1_003	Durée totale en hôpital à cause de la santé mentale - 12 m.	Même	Ajoutée		
	SR1_004A	SR1_004A	Consulté pour santé mnt/alc/drogues - psychiatre - 12 m	Même	Ajoutée		
	SR1_004B	SR1_004B	Consulté pour santé mnt/alc/drogues - MD fam/omniprat - 12 m	Même	Ajoutée		
	SR1_004C	SR1_004C	Consulté pour santé mnt/alc/drogues - psychologue - 12 m	Même	Ajoutée		
	SR1_004D	SR1_004D	Consulté pour santé mnt/alc/drogues - infirmière - 12 m	Même	Ajoutée		
	SR1_004E	SR1_004E	Consulté travailleur social ou conseiller - 12 mois	Même	Ajoutée		
	SR1_004F	SR1_004F	Consulté pour santé mnt/alc/drogues -	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			membre de la fam - 12m				
	SR1_004G	SR1_004G	Consulté pour santé mnt/alc/drogues - ami - 12 m	Même	Ajoutée		
	SR1_004H	SR1_004H	Consulté pour santé mnt/alc/drogues - collèg trav/patrn-12 m	Même	Ajoutée		
	SR1_004I	SR1_004H	Consulté pour santé mnt/alc/drogues - collèg trav/patrn-12 m	Même	Ajoutée		
	SR1_004J	SR1_004I	Consulté pour santé mnt/alc/drogues - autre - 12 m	Même	Ajoutée		
	SR1_004K	SR1_004J	Consulté pour santé mnt/alc/drogues - aucun - 12 m	Même	Ajoutée		
		SR1_10AA	Contacté psychiatre - en personne	Ajoutée			
		SR1_10AB	Contacté psychiatre - par téléphone	Ajoutée			
		SR1_10AC	Contacté psychiatre - par vidéo	Ajoutée			
		SR1_10AD	Contacté psychiatre - par message texte	Ajoutée			
SERB_23	SR1_010	SR1_010B	Nombre de fois consulté psychiatre - 12 m.	Même	Même		
	SR1_011	SR1_011	Consultation temps moyen en minutes - psychiatre	Même	Ajoutée		
SERB_26	SR1_012	SR1_012	Perception du niveau d'aide reçu - psychiatre	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
SERB_27	SR1_013	SR1_013	Arrêté de consulter ce professionnel - psychiatre	Même	Même		
SERB_28A	SR1_014A	SR1_014A	Raison d'arrêt - psychia - se sentait mieux	Même	Même		
SERB_28B	SR1_014B	SR1_014B	Raison d'arrêt - psychia - complété le traitement recommandé	Même	Même		
SERB_28C	SR1_014C	SR1_014C	Raison d'arrêt - psychia - pensait que cela n'aidait pas	Même	Même		
SERB_28D	SR1_014D	SR1_014D	Raison d'arrêt - psychia -prob allait s'améliorer sans +aide	Même	Même		
SERB_28E	SR1_014E	SR1_014E	Raison d'arrêt - psychia - ne pouvait pas payer	Même	Même		
SERB_28F	SR1_014F	SR1_014F	Raison d'arrêt - psychia - trop embarras pour consulter prof	Même	Même		
SERB_28G	SR1_014G	SR1_014G	Raison d'arrêt - psychia - résoudre problème sans aide prof.	Même	Même		
SERB_28H	SR1_014H	SR1_014H	Raison d'arrêt - psychia - prob comme transport/ gar. enfant	Même	Même		
SERB_28I	SR1_014I	SR1_014I	Raison d'arrêt - psychia - serv/prog n'était plus disponible	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
SERB_28J	SR1_014J	SR1_014J	Raison d'arrêt - psychia - n'était pas confort approche prof	Même	Même		
	SR1_014K	SR1_014K	Raison d'arrêt - psychia - discrimination/traitement injuste	Même	Ajoutée		
SERB_28K	SR1_014L	SR1_014L	Raison d'arrêt - psychia - autre raison	Même	Même		
		SR1_20AA	Contacté méd. de famille - en personne	Ajoutée			
		SR1_20AB	Contacté méd. de famille - par téléphone	Ajoutée			
		SR1_20AC	Contacté méd. de famille - par vidéo	Ajoutée			
		SR1_20AD	Contacté méd. de famille - par message texte	Ajoutée			
SERB_33	SR1_020	SR1_020B	Nbre de fois consulté méd. de famille - 12 m.	Même	Même		
	SR1_021	SR1_021	Consultation/temps m en minutes - méd. de famille/omniprat.	Même	Ajoutée		
SERB_36	SR1_022	SR1_022	Perception du niveau d'aide reçu du prof. - méd. de famille	Même	Même		
SERB_37	SR1_023	SR1_023	Arrêté de consulter ce professionnel - médecin de famille	Même	Même		
SERB_38A	SR1_024A	SR1_024A	Raison d'arrêt - méd fam - se sentait mieux	Même	Même		
SERB_38B	SR1_024B	SR1_024B	Raison d'arrêt - méd fam - complété le	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			traitement recommandé				
SERB_38C	SR1_024C	SR1_024C	Raison d'arrêt - méd fam - pensait que cela n'aidait pas	Même	Même		
SERB_38D	SR1_024D	SR1_024D	Raison d'arrêt - méd fam - prob s'améliorer sans plus d'aide	Même	Même		
SERB_38E	SR1_024E	SR1_024E	Raison d'arrêt - méd fam - ne pouvait pas payer	Même	Même		
SERB_38F	SR1_024F	SR1_024F	Raison d'arrêt - méd fam - trop embarrassé consulter prof.	Même	Même		
SERB_38F	SR1_024G	SR1_024G	Raison d'arrêt - méd fam - résoudre problème sans aide prof.	Même	Même		
SERB_38H	SR1_024H	SR1_024H	Raison d'arrêt - méd fam - problem transport/ garde d'enfant	Même	Même		
SERB_38I	SR1_024I	SR1_024I	Raison d'arrêt - méd fam - serv/prog n'était plus disponible	Même	Même		
SERB_38J	SR1_024J	SR1_024J	Raison d'arrêt - méd fam - pas confort avec approche prof.	Même	Même		
	SR1_024K	SR1_024K	Raison d'arrêt - méd fam - discrimination/traitement injuste	Même	Ajoutée		
SERB_38K	SR1_024L	SR1_024L	Raison d'arrêt - méd fam - autre raison	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
		SR1_30AA	Contacté psychologue - en personne	Ajoutée			
		SR1_30AB	Contacté psychologue - par téléphone	Ajoutée			
		SR1_30AC	Contacté psychologue - par vidéo	Ajoutée			
		SR1_30AD	Contacté psychologue - par message texte	Ajoutée			
SERB_53	SR1_030	SR1_030B	Nombre de fois consulté psychologue - 12 m.	Même	Même		
	SR1_031	SR1_031	Consultation/temps moyen en minutes - psychologue	Même	Ajoutée		
SERB_56	SR1_032	SR1_032	Perception du niveau d'aide reçu - psychologue	Même	Même		
SERB_57	SR1_033	SR1_033	Arrêté de consulter ce professionnel - psychologue	Même	Même		
SERB_58A	SR1_034A	SR1_034A	Raison d'arrêt - psychol - se sentait mieux	Même	Même		
SERB_58B	SR1_034B	SR1_034B	Raison d'arrêt - psychol - a complété traitement recommandé	Même	Même		
SERB_58C	SR1_034C	SR1_034C	Raison d'arrêt - psychol - pensait que cela n'aidait pas	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
SERB_58D	SR1_034D	SR1_034D	Raison d'arrêt - psychol - prob. s'améliorer	Même	Même		
SERB_58E	SR1_034E	SR1_034E	Raison d'arrêt - psychol - ne pouvait pas payer	Même	Même		
SERB_58F	SR1_034F	SR1_034F	Raison d'arrêt - psychol - embarrassé pour consulter prof.	Même	Même		
SERB_58G	SR1_034G	SR1_034G	Raison d'arrêt - psychol - résoudre problème sans aide prof.	Même	Même		
SERB_58H	SR1_034H	SR1_034H	Raison d'arrêt - psychol - prob - transport/ garde d'enfant	Même	Même		
SERB_58I	SR1_034I	SR1_034I	Raison d'arrêt - psychol - serv/prog n'était plus disponible	Même	Même		
SERB_58J	SR1_034J	SR1_034J	Raison d'arrêt - psychol - pas confort. avec approche prof.	Même	Même		
	SR1_034K	SR1_034K	Raison d'arrêt - psychol - discrimination/traitement injuste	Même	Ajoutée		
SERB_58K	SR1_034L	SR1_034L	Raison d'arrêt - psychol - autre raison	Même	Même		
		SR1_40AA	Contacté infirmière - en personne	Ajoutée			
		SR1_40AB	Contacté infirmière - par téléphone	Ajoutée			
		SR1_40AC	Contacté infirmière - par vidéo	Ajoutée			

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
		SR1_40AD	Contacté infirmière - par message texte	Ajoutée			
SERB_63	SR1_040	SR1_040B	Nombre de fois consulté infirmière - 12 m.	Même	Même		
	SR1_041	SR1_041	Consultation/temps moyen en minutes - infirmière	Même	Ajoutée		
SERB_66	SR1_042	SR1_042	Perception du niveau d'aide reçu du prof. - infirmière	Même	Même		
SERB_67	SR1_043	SR1_043	Arrêté de consulter ce professionnel - infirmière	Même	Même		
SERB_68A	SR1_044A	SR1_044A	Raison d'arrêt - infirm - se sentait mieux	Même	Même		
SERB_68B	SR1_044B	SR1_044B	Raison d'arrêt - infirm - complété le traitement recommandé	Même	Même		
SERB_68C	SR1_044C	SR1_044C	Raison d'arrêt - infirm - pensait que cela n'aidait pas	Même	Même		
SERB_68D	SR1_044D	SR1_044D	Raison d'arrêt - infirm - prob s'améliorer sans plus d'aide	Même	Même		
SERB_68E	SR1_044E	SR1_044E	Raison d'arrêt - infirm - ne pouvait pas payer	Même	Même		
SERB_68F	SR1_044F	SR1_044F	Raison d'arrêt - infirm - embarrassé pour consulter prof.	Même	Même		
SERB_68G	SR1_044G	SR1_044G	Raison d'arrêt - infirm - résoudre problème sans aide prof.	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
SERB_68K	SR1_044H	SR1_044H	Raison d'arrêt - infirm - prob comme transpo/garde d'enfant	Même	Même		
SERB_68I	SR1_044I	SR1_044I	Raison d'arrêt - infirm - serv/prog n'était plus disponible	Même	Même		
SERB_68J	SR1_044J	SR1_044J	Raison d'arrêt - infirm - pas confortable av. approche prof.	Même	Même		
	SR1_044K	SR1_044K	Raison d'arrêt - infirm - discrimination/traitement injuste	Même	Ajoutée		
SERB_68K	SR1_044L	SR1_044L	Raison d'arrêt - infirm - autre raison	Même	Même		
		SR1_50AA	Contacté travailleur social - en personne	Ajoutée			
		SR1_50AB	Contacté travailleur social - par téléphone	Ajoutée			
		SR1_50AC	Contacté travailleur social - par vidéo	Ajoutée			
		SR1_50AD	Contacté travailleur social - par message texte	Ajoutée			
SERB_73	SR1_050	SR1_050B	Nombre de fois consulté travailleur social - 12 m.	Même	Même		
	SR1_051	SR1_051	Consultation/temps moyen en minutes - travailleur social	Même	Ajoutée		
SERB_76	SR1_052	SR1_052	Perception du niveau d'aide reçu du prof. - trav. social	Même	Même		
SERB_77	SR1_053	SR1_053	Arrêté de consulter ce	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			professionnel/travailleur social				
SERB_78A	SR1_054A	SR1_054A	Raison d'arrêt - tr soc - se sentait mieux	Même	Même		
SERB_78B	SR1_054B	SR1_054B	Raison d'arrêt - tr soc - complété le traitement recommandé	Même	Même		
SERB_78C	SR1_054C	SR1_054C	Raison d'arrêt - tr soc - pensait que cela n'aidait pas	Même	Même		
SERB_78D	SR1_054D	SR1_054D	Raison d'arrêt - tr soc - prob. s'améliorer sans plus d'aide	Même	Même		
SERB_78E	SR1_054E	SR1_054E	Raison d'arrêt - tr soc - ne pouvait pas payer	Même	Même		
SERB_78F	SR1_054F	SR1_054F	Raison d'arrêt - tr soc - embarrassé pour consulter prof.	Même	Même		
SERB_78G	SR1_054G	SR1_054G	Raison d'arrêt - tr soc - résoudre problème sans aide prof.	Même	Même		
SERB_78H	SR1_054H	SR1_054H	Raison d'arrêt - tr soc - prob comme transprt/garde d'enfant	Même	Même		
SERB_78I	SR1_054I	SR1_054I	Raison d'arrêt - tr soc - serv/prog n'était plus disponible	Même	Même		
SERB_78J	SR1_054J	SR1_054J	Raison d'arrêt - tr soc - pas confortable av. approche prof.	Même	Même		
	SR1_054K	SR1_054K	Raison d'arrêt - tr soc -	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			discrimination/traitement injuste				
SERB_78K	SR1_054L	SR1_054L	Raison d'arrêt - tr soc - autre raison	Même	Même		
		SR1_60AA	Contacté membre de la famille - en personne	Ajoutée			
		SR1_60AB	Contacté membre de la famille - par téléphone	Ajoutée			
		SR1_60AC	Contacté membre de la famille - par vidéo	Ajoutée			
		SR1_60AD	Contacté membre de la famille - par message texte	Ajoutée			
	SR1_060	SR1_060B	Nombre de fois consulté membre de la famille - 12 m.	Même	Ajoutée		
	SR1_062	SR1_062	Perception du niveau d'aide reçu - membre de la famille	Même	Ajoutée		
		SR1_70AA	Contacté ami - en personne	Ajoutée			
		SR1_70AB	Contacté ami - par téléphone	Ajoutée			
		SR1_70AC	Contacté ami - par vidéo	Ajoutée			
		SR1_70AD	Contacté ami - par message texte	Ajoutée			
	SR1_070	SR1_070B	Nombre de fois consulté l'ami - 12 m.	Même	Ajoutée		
	SR1_072	SR1_072	Perception du niveau d'aide reçu - ami	Même	Ajoutée		
		SR1_80AA	Contacté collègue ou superviseur - en personne	Ajoutée			

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
		SR1_80AB	Contacté collègue ou superviseur - par téléphone	Ajoutée			
		SR1_80AC	Contacté collègue ou superviseur - par vidéo	Ajoutée			
		SR1_80AD	Contacté collègue ou superviseur - par message texte	Ajoutée			
	SR1_080	SR1_080B	Nombre de fois consulté collègue ou superviseur - 12 m.	Même	Ajoutée		
	SR1_082	SR1_082	Perception niveau aide reçu - collègue travail/superviseur	Même	Ajoutée		
		SR1100AA	Contacté autre personne - en personne	Ajoutée			
		SR1100AB	Contacté autre personne - par téléphone	Ajoutée			
		SR1100AC	Contacté autre personne - par vidéo	Ajoutée			
		SR1100AD	Contacté autre personne - par message texte	Ajoutée			
	SR1_100	SR1_100B	Nombre de fois consulté autre personne - 12 m.	Même	Ajoutée		
	SR1_102	SR1_102	Perception du niveau d'aide reçu - autre personne	Même	Ajoutée		
	SR1_110	SR1_110	Reçu de l'aide ou des services de l'employeur - 12 mois	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	SR1_111	SR1_111	Utilisé Internet pour l'information/l'aide/du soutien - 12 m	Même	Ajoutée		
	SR1_112A	SR1_112A	Utilisé internet - renseigner sur les symptômes	Même	Ajoutée		
	SR1_112B	SR1_112B	Utilisé internet - pour savoir où obtenir de l'aide	Même	Ajoutée		
	SR1_112C	SR1_112C	Utilisé internet - discuter avec d'autres personnes	Même	Ajoutée		
	SR1_112D	SR1_112D	Utilisé internet - Pour obtenir de la thérapie en ligne	Même	Ajoutée		
	SR1_112E	SR1_112E	Utilisé internet - autre	Même	Ajoutée		
	SR1_113	SR1_113	Groupe d'entraide - l'aide pour des problèmes - 12 mois	Même	Ajoutée		
	SR1_114A	SR1_114A	Groupe d'entraide type - émotionnelle ou santé mentale	Même	Ajoutée		
	SR1_114B	SR1_114B	Groupe d'entraide type - consommation d'alcool ou de drogues	Même	Ajoutée		
	SR1_114C	SR1_114C	Groupe d'entraide type - autre	Même	Ajoutée		
SERB_A1D	SR1_115	SR1_115	Nbre de fois allé à réunion d'un groupe d'entraide - 12 mois	Même	Même		
	SR1_116	SR1_116	Utilisé ligne d'aide téléphonique pour santé mentale-12 mois	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
SERB_A2D	SR1_117	SR1_117	Nbre de fois utilisé ligne d'aide téléphonique - 12 m.	Même	Même		
SERB_A3	SR1_118	SR1_118	Eu besoin aide pour émotions mais ne l'a pas obtenue/12 mois	Même	Même		
SERB_A7	SR1_119	SR1_119	Montant dépensé pour services/produits santé mentale/12 mois	Même	Même		
	SR1_121	SR1_121	Préjudice / discrimination - santé mentale	Même	Ajoutée		
	SR1_120	SR1_122	Préjudice / discrimination - trait de caractère	Même	Ajoutée		
SERBFLAP	SR1FPRU	SR1FPRU	Consultation/services utilisés - professionnel - 12 m (I)	Même	Ajoutée		
	SR1FNPU	SR1FNPU	Consultation/services utilisés - non-professionnel -12 m (I)	Même	Ajoutée		
	SR1DYPRT	SR1DYPRT	Nombre de types - professionnels consultés - 12 m (D)	Même	Ajoutée		
	SR1DYNPT	SR1DYNPT	Nombre de types - non-professionnels consultés - 12 m (D)	Même	Ajoutée		
	SR1DPRO1	SR1DPRO1	Heures de consultation - psychiatre - 12 m (D)	Modifiée	Ajoutée	Petite modification technique, concept inchangé. Voir les spécifications de la VD.	

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	SR1DPRO2	SR1DPRO2	Heures de consultation - médecin de famille - 12 m (D)	Modifiée	Ajoutée	Petite modification technique, concept inchangé. Voir les spécifications de la VD.	
	SR1DPRO3	SR1DPRO3	Heures de consultation - psychologue - 12 m (D)	Modifiée	Ajoutée	Petite modification technique, concept inchangé. Voir les spécifications de la VD.	
	SR1DPRO4	SR1DPRO4	Heures de consultation - infirmière - 12 m (D)	Modifiée	Ajoutée	Petite modification technique, concept inchangé. Voir les spécifications de la VD.	
	SR1DPRO5	SR1DPRO5	Heures de consulation - travail social/conseiller - 12 m (D)	Modifiée	Ajoutée	Petite modification technique, concept inchangé. Voir les spécifications de la VD.	
	SR1DPROT	SR1DPROT	Heures de consultation - tous professionnels - 12 m (D)	Modifiée	Ajoutée	Petite modification technique, concept inchangé. Voir les spécifications de la VD.	
	MED_01	MED_01	Médicaments pour émotions/santé mentale/alcool/drogues - 12m	Même	Ajoutée		
	MED_02	MED_02	Nbre méd pris pour émot/santé mentale/alcool/drogue -2 jours	Même	Modifiée		On a changé le libellé de la question
MEDB_4	MED_05	MED_05	Assurance couvre entièrement/en partie coût médicaments	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
MEDB_5	MED_06	MED_06	Utilisé autres produits de santé pour santé mentale - 12 m	Même	Même		
	PNC_01A	PNC_01A	Reçu aide - information	Même	Ajoutée		
	PNC_01B	PNC_01B	Reçu aide - médicaments	Même	Ajoutée		
	PNC_01C	PNC_01C	Reçu aide - counseling ou thérapie	Même	Ajoutée		
	PNC_01D	PNC_01D	Reçu aide - autre	Même	Ajoutée		
	PNC_01E	PNC_01E	Reçu aide - aucun	Même	Ajoutée		
	PNC_02A	PNC_02A	Reçue - autant d'aide qu'en avait besoin	Même	Ajoutée		
	PNC_02BA	PNC_02BA	A besoin de plus d'aide - information	Même	Ajoutée		
	PNC_02BB	PNC_02BB	A besoin de plus d'aide - médicaments	Même	Ajoutée		
	PNC_02BC	PNC_02BC	A besoin de plus d'aide - counseling ou thérapie	Même	Ajoutée		
	PNC_02BD	PNC_02BD	A besoin de plus d'aide - autre	Même	Ajoutée		
	PN1_01A1	PNC_03AA	Pourquoi il n'y a plus d'information / s'est débrouillé seul	Même	Ajoutée		
	PN1_01B1	PNC_03AB	Pourquoi il n'y a plus d'info / ne sait comment ou où	Même	Ajoutée		
	PN1_01C1	PNC_03AC	Pourquoi il n'y a plus d'information / trop occupé	Même	Ajoutée		
	PN1_01D1	PNC_03AD	Pourquoi il n'y a plus d'information / le travail empêchait	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	PN1_01E1	PNC_03AE	Pourquoi il n'y a plus d'information / pas disponible	Même	Ajoutée		
	PN1_01F1	PNC_03AF	Pourquoi il n'y a plus d'info / pas confiance au système	Même	Ajoutée		
	PN1_01G1	PNC_03AG	Pourquoi il n'y a plus d'information / inabordable	Même	Ajoutée		
	PN1_01H1	PNC_03AH	Pourquoi il n'y a plus d'info / assurance ne couvre pas	Même	Ajoutée		
	PN1_01I1	PNC_03AI	Pourquoi il n'y a plus d'info / peur opinion des autres	Même	Ajoutée		
	PN1_01J1	PNC_03AJ	Pourquoi il n'y a plus d'information / problème de langue	Même	Ajoutée		
	PN1_01K1	PNC_03AK	Pourquoi il n'y a plus d'information / reçoit de l'aide	Même	Ajoutée		
	PN1_01L1	PNC_03AL	Pourquoi il n'y a plus d'information / autre précisez	Même	Ajoutée		
	PN1_02A1	PNC_3A1A	Pourquoi préfère se débrouiller / plus d'information	Même	Ajoutée		
	PN1_01A2	PNC_03BA	Pourquoi il n'y a plus de médicament / s'est débrouillé seul	Même	Ajoutée		
	PN1_01B2	PNC_03BB	Pourquoi il n'y a plus de médicament / ne sait comment ou où	Même	Ajoutée		
	PN1_01C2	PNC_03BC	Pourquoi il n'y a plus de médicaments / trop occupé	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	PN1_01D2	PNC_03BD	Pourquoi il n'y a plus de médicaments / travail empêchait	Même	Ajoutée		
	PN1_01E2	PNC_03BE	Pourquoi il n'y a plus de médicaments / pas disponible	Même	Ajoutée		
	PN1_01F2	PNC_03BF	Pourquoi il n'y a plus médicament / pas confiance au système	Même	Ajoutée		
	PN1_01G2	PNC_03BG	Pourquoi il n'y a plus de médicaments / inabordable	Même	Ajoutée		
	PN1_01H2	PNC_03BH	Pourquoi il n'y a plus médicaments / assurance ne couvre pas	Même	Ajoutée		
	PN1_01I2	PNC_03BI	Pourquoi il n'y a plus médicaments / peur opinion des autres	Même	Ajoutée		
	PN1_01J2	PNC_03BJ	Pourquoi il n'y a plus de médicaments / problème de langue	Même	Ajoutée		
	PN1_01K2	PNC_03BK	Pourquoi il n'y a plus de médicament / reçoit de l'aide	Même	Ajoutée		
	PN1_01L2	PNC_03BL	Pourquoi il n'y a plus de médicament / autre précisez	Même	Ajoutée		
	PN1_02A2	PNC_3B2B	Pourquoi il n'y a plus d'information / s'est débrouillé seul	Même	Ajoutée		
	PN1_01A3	PNC_03CA	Pourquoi il n'y a plus de consultation/s'est débrouillé seul	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	PN1_01B3	PNC_03CB	Pourquoi il n'y a plus consultation / ne sait comment ou où	Même	Ajoutée		
	PN1_01C3	PNC_03CC	Pourquoi il n'y a plus de consultation / trop occupé	Même	Ajoutée		
	PN1_01D3	PNC_03CD	Pourquoi il n'y a plus de consultation/ le travail empêchait	Même	Ajoutée		
	PN1_01E3	PNC_03CE	Pourquoi il n'y a plus de consultation / pas disponible	Même	Ajoutée		
	PN1_01F3	PNC_03CF	Pourquoi il n'y a plus consultation / pas confiance au syst.	Même	Ajoutée		
	PN1_01G3	PNC_03CG	Pourquoi il n'y a plus de consultation / inabordable	Même	Ajoutée		
	PN1_01H3	PNC_03CH	Pourquoi il n'y a plus consultation / assurance couvre pas	Même	Ajoutée		
	PN1_01I3	PNC_03CI	Pourquoi il n'y a plus consultation/peur opinion des autres	Même	Ajoutée		
	PN1_01J3	PNC_03CJ	Pourquoi il n'y a plus de consultation / problème de langue	Même	Ajoutée		
	PN1_01K3	PNC_03CK	Pourquoi il n'y a plus de consultation / reçoit de l'aide	Même	Ajoutée		
	PN1_01L3	PNC_03CL	Pourquoi il n'y a plus de consultation / autre précisez	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	PN1_02A3	PNC_3C3C	Pourquoi il n'y a plus d'information / s'est débrouillé seul	Même	Ajoutée		
	PN1_01A4	PNC_03DA	Pourquoi il n'y a plus - autre / s'est débrouillé seul	Même	Ajoutée		
	PN1_01B4	PNC_03DB	Pourquoi il n'y a plus - autre / ne sait comment ou où	Même	Ajoutée		
	PN1_01C4	PNC_03DC	Pourquoi il n'y a plus - autre / trop occupé	Même	Ajoutée		
	PN1_01D4	PNC_03DD	Pourquoi il n'y a plus - autre / le travail empêchait	Même	Ajoutée		
	PN1_01E4	PNC_03DE	Pourquoi il n'y a plus - autre / pas disponible	Même	Ajoutée		
	PN1_01F4	PNC_03DF	Pourquoi il n'y a plus - autre / pas confiance au système	Même	Ajoutée		
	PN1_01G4	PNC_03DG	Pourquoi il n'y a plus - autre / inabordable	Même	Ajoutée		
	PN1_01H4	PNC_03DH	Pourquoi il n'y a plus - autre / assurance ne couvre pas	Même	Ajoutée		
	PN1_01I4	PNC_03DI	Pourquoi il n'y a plus - autre / peur opinion des autres	Même	Ajoutée		
	PN1_01J4	PNC_03DJ	Pourquoi il n'y a plus - autre / problème de langue	Même	Ajoutée		
	PN1_01L4	PNC_03DL	Pourquoi il n'y a plus - autre / autre précisez	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	PN1_02A4	PNC_3D4D	Pourquoi il n'y a plus d'information / s'est débrouillé seul	Même	Ajoutée		
	PNC_04A	PNC_04A	Avait besoin d'aide mais n'en a pas reçu	Même	Ajoutée		
	PNC_04BA	PNC_04BA	Avait besoin d'aide & mais n'en a pas réçu - information	Même	Ajoutée		
	PNC_04BB	PNC_04BB	Avait besoin d'aide & mais n'en a pas réçu - médicaments	Même	Ajoutée		
	PNC_04BC	PNC_04BC	Avait besoin d'aide & pas réçu - counseling ou thérapie	Même	Ajoutée		
	PN1_01A5	PNC_05BA	Pourquoi il n'y a pas d'information / s'est débrouillé seul	Même	Ajoutée		
	PN1_01B5	PNC_05BB	Pourquoi il n'y a pas d'information / ne sait comment ou où	Même	Ajoutée		
	PN1_01C5	PNC_05BC	Pourquoi il n'y a pas d'information / trop occupé	Même	Ajoutée		
	PN1_01D5	PNC_05BD	Pourquoi il n'y a pas d'information / le travail empêchait	Même	Ajoutée		
	PN1_01E5	PNC_05BE	Pourquoi il n'y a pas d'info / pas disponible	Même	Ajoutée		
	PN1_01F5	PNC_05BF	Pourquoi il n'y a pas d'info / pas confiance au système	Même	Ajoutée		
	PN1_01G5	PNC_05BG	Pourquoi il n'y a pas d'information / inabordable	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	PN1_01H5	PNC_05BH	Pourquoi il n'y a pas d'info / assurance ne couvre pas	Même	Ajoutée		
	PN1_01I5	PNC_05BI	Pourquoi il n'y a pas d'info / peur opinion des autres	Même	Ajoutée		
	PN1_01J5	PNC_05BJ	Pourquoi il n'y a pas d'information / problème de langue	Même	Ajoutée		
	PN1_01L5	PNC_05BL	Pourquoi il n'y a pas d'information / autre précisez	Même	Ajoutée		
	PN1_02A5	PNC_5B2B	Pourquoi il n'y a plus d'information / s'est débrouillé seul	Même	Ajoutée		
	PN1_01A6	PNC_05CA	Pourquoi il n'y a pas de médicaments / s'est débrouillé seul	Même	Ajoutée		
	PN1_01B6	PNC_05CB	Pourquoi il n'y a pas de médicaments / ne sait comment ou où	Même	Ajoutée		
	PN1_01C6	PNC_05CC	Pourquoi il n'y a pas de médicaments / trop occupé	Même	Ajoutée		
	PN1_01D6	PNC_05CD	Pourquoi il n'y a pas de médicaments / le travail empêchait	Même	Ajoutée		
	PN1_01E6	PNC_05CE	Pourquoi il n'y a pas de médicaments / pas disponible	Même	Ajoutée		
	PN1_01F6	PNC_05CF	Pourquoi il n'y a pas de médicament/pas confiance au système	Même	Ajoutée		
	PN1_01G6	PNC_05CG	Pourquoi il n'y a pas de médicaments / inabordable	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	PN1_01H6	PNC_05CH	Pourquoi il n'y a pas de médicaments/assurance ne couvre pas	Même	Ajoutée		
	PN1_01I6	PNC_05CI	Pourquoi il n'y a pas de médicament/ peur opinion des autres	Même	Ajoutée		
	PN1_01J6	PNC_05CJ	Pourquoi il n'y a pas de médicaments / problème de langue	Même	Ajoutée		
	PN1_01L6	PNC_05CL	Pourquoi il n'y a pas de médicaments / autre préciez	Même	Ajoutée		
	PN1_02A6	PNC_5C3C	Pourquoi il n'y a plus d'information / s'est débrouillé seul	Même	Ajoutée		
	PN1_01A7	PNC_05DA	Pourquoi il n'y a pas de consultation/s'est débrouillé seul	Même	Ajoutée		
	PN1_01B7	PNC_05DB	Pourquoi il n'y a pas de consultation/ne sait comment ou où	Même	Ajoutée		
	PN1_01C7	PNC_05DC	Pourquoi il n'y a pas de consultation / trop occupé	Même	Ajoutée		
	PN1_01D7	PNC_05DD	Pourquoi il n'y a pas de consultation / le travail empêchait	Même	Ajoutée		
	PN1_01E7	PNC_05DE	Pourquoi il n'y a pas de consultation / pas disponible	Même	Ajoutée		
	PN1_01F7	PNC_05DF	Pourquoi il n'y a pas de consultation/pas confiance au syst.	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	PN1_01G7	PNC_05DG	Pourquoi il n'y a pas de consultation / inabordable	Même	Ajoutée		
	PN1_01H7	PNC_05DH	Pourquoi il n'y a pas de consultation / assurance couvre pas	Même	Ajoutée		
	PN1_01I7	PNC_05DI	Pourquoi il n'y a pas de consultation/peur opinion des autre	Même	Ajoutée		
	PN1_01J7	PNC_05DJ	Pourquoi il n'y a pas de consultation / problème de langue	Même	Ajoutée		
	PN1_01L7	PNC_05DL	Pourquoi il n'y a pas de consultation / autre précisez	Même	Ajoutée		
	PN1_02A7	PNC_5D4D	Pourquoi il n'y a plus d'information / s'est débrouillé seul	Même	Ajoutée		
	PNCFH12	PNCFH12	Indicateur: aide reçu - 12 derniers mois (I)	Même	Ajoutée		
	PNCDHCT	PNCDHCT	Nombre de types d'aide reçue - 12 derniers mois - (D)	Même	Ajoutée		
	PNCDPNI	PNCDPNI	Besoin perçu pour de l'information - 12 derniers mois (D)	Même	Ajoutée		
	PNCDPNM	PNCDPNM	Besoin perçu pour des médicaments - 12 derniers mois (D)	Même	Ajoutée		
	PNCDPNC	PNCDPNC	Besoin perçu pour de la consultation - 12 derniers mois (D)	Même	Ajoutée		
	PNCDPNO	PNCDPNO	Besoin perçu pour d'autre aide - 12 derniers mois (D)	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	PNCDNEED	PNCDNEED	Besoins globaux perçus au cours des 12 derniers mois - (D)	Même	Ajoutée		
	MHE_05A	MHE_05A	Reçu un traitement pour santé mentale - vie	Même	Ajoutée		
	MHE_05B	MHE_05B	Reçu un traitement pour santé mentale - 12 m	Même	Ajoutée		
	MHE_06	MHE_06	Perçu préjudice/discrimination lié à la santé mentale - 12m	Même	Ajoutée		
	MHE_06A	MHE_06A	Impact - préj/discrimin santé mentale - relations familiales	Même	Ajoutée		
	MHE_06B	MHE_06B	Impact - préj/discrim santé mentale - vie sentimentale	Même	Ajoutée		
	MHE_06C	MHE_06C	Impact - préj/discrim santé mentale- professionnelle/scolaire	Même	Ajoutée		
	MHE_06D	MHE_06D	Impact - préj/discrim santé mentale - situation financière	Même	Ajoutée		
	MHE_06E	MHE_06E	Impact- préj/discrim santé mentale - logement	Même	Ajoutée		
	MHE_06F	MHE_06F	Impact - préj/discrim santé mentale -soins de santé/physique	Même	Ajoutée		
	FMI_01A	FMI_01A	Membre de la famille - problèmes santé mentale/alc/drogues	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	FMI_02	FMI_02	Vie affectée par un problème du membre de la famille	Même	Ajoutée		
	SPS_01	SPS_01	A des personnes sur qui compter	Même	Ajoutée		
	SPS_02	SPS_02	A des personnes prenant plaisir aux mêmes activités sociales	Même	Ajoutée		
	SPS_03	SPS_03	A des personnes proches	Même	Ajoutée		
	SPS_04	SPS_04	A quelqu'un avec qui discuter de décisions importantes	Même	Ajoutée		
	SPS_05	SPS_05	A relations où compétence/savoir-faire sont reconnu	Même	Ajoutée		
	SPS_06	SPS_06	A une personne fiable pour donner des conseils	Même	Ajoutée		
	SPS_07	SPS_07	Impression faire partie groupe partage attitudes/croyances	Même	Ajoutée		
	SPS_08	SPS_08	A un lien affectif fort	Même	Ajoutée		
	SPS_09	SPS_09	A des gens qui admirent talents/habiletés	Même	Ajoutée		
	SPS_10	SPS_10	A des gens sur qui compter en cas d'urgence	Même	Ajoutée		
	SPSDCON	SPSDCON	Échelle de provisions sociales - score global (D)	Même	Ajoutée		
	SPSDATT	SPSDATT	Échelle de provisions sociales - attachement - (D)	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	SPSDGUI	SPSDGUI	Échelle de provisions sociales - obtention de conseils - (D)	Même	Ajoutée		
	SPSDALL	SPSDALL	Échelle de provisions sociales - aide tangible - (D)	Même	Ajoutée		
	SPSDINT	SPSDINT	Échelle de provisions sociales - intégration sociale - (D)	Même	Ajoutée		
	SPSDWOR	SPSDWOR	Échelle de provisions sociales -réassurance de sa valeur (D)	Même	Ajoutée		
	NSI_01	NSI_01	Interactions sociales négatives - nuisant au bien-être	Même	Ajoutée		
	NSI_02	NSI_02	Interactions sociales négatives - trop exigeantes	Même	Ajoutée		
	NSI_03	NSI_03	Interactions sociales négatives - critique comportements	Même	Ajoutée		
	NSI_04	NSI_04	Interactions sociales négatives-manque d'égards/considératn	Même	Ajoutée		
	NSI_05	NSI_05	Interactions sociales négatives - en colère/fâché	Même	Ajoutée		
	NSIDSC	NSIDSC	Interactions sociales négatives - échelle - (D)	Même	Ajoutée		
	CEX_01	CEX_01	Nbre de fois - vu/entendu parent frapper autre adulte maison	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
	CEX_02	CEX_02	Nbre de fois - giflé/frappé/donné une fessée	Même	Ajoutée		
	CEX_03	CEX_03	Nbre de fois - poussé/agrippé/bousculé/vous a lancé qqch.	Même	Ajoutée		
	CEX_04	CEX_04	Nbre de fois - attaqué physiquement	Même	Ajoutée		
	CEX_05	CEX_05	Nbre de fois - forcé activité sexuelle non désirée	Même	Ajoutée		
	CEX_06	CEX_06	Nbre de fois - attouchements sexuels	Même	Ajoutée		
	CEX_07	CEX_07	Vu/parlé à un organisme de protection de la jeunesse	Même	Ajoutée		
	CEXDNUM	CEXDNUM	Nombre de types de maltraitment de l'enfance éprouvé (D)	Même	Ajoutée		
SPVB_1	SPT_01	SPI_01	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie	Même	Modifiée		On a changé le libellé de la question
LBFB_01	LBS_01	LMAM_01	A occupé un emploi la semaine dernière	Même	Même		
LBFB_02	LBS_02	LMAM_02	A été absent de son emploi la semaine dernière	Même	Même		
		LMAM_03	Absent de l'emploi / entreprise - raison - semaine dernière	Ajoutée			
	LBSCSOC	LBSCSOC	Classification nationale des	Même	Ajoutée		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
			professions (CNP) 2011				
LBSBDWSS	LBSDWSS	LBSDWSS	Situation en regard de l'activité la semaine dernière - (D)	Même	Modifiée		On a changé les conditions dans les spécifications de variables dérivées.
	LBSDOCG	LBSDOCG	Groupe professionnel - (D)	Même	Ajoutée		
WSTB_401	WST_401	WST_401	Stress au trav. - acquérir de nouvelles connaissances	Même	Même		
WSTB_402	WST_402	WST_402	Stress au travail - niveau élevé de compétences	Même	Même		
WSTB_403	WST_403	WST_403	Stress au travail - liberté de décider	Même	Même		
WSTB_404	WST_404	WST_404	Stress au travail - tâches répétitives	Même	Même		
WSTB_405	WST_405	WST_405	Stress au travail - travail frénétique	Même	Même		
WSTB_406	WST_406	WST_406	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles.	Même	Même		
WSTB_407	WST_407	WST_407	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi	Même	Même		
WSTB_408	WST_408	WST_408	Stress au travail - beaucoup d'efforts physiques	Même	Même		
WSTB_409	WST_409	WST_409	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail	Même	Même		

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
WSTB_410	WST_410	WST_410	Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues	Même	Modifiée		On a ajouté la catégorie de réponse « Sans objet ».
WSTB_411	WST_411	WST_411	Stress au travail - surveillant facilitait le travail	Même	Modifiée		On a ajouté la catégorie de réponse « Sans objet ».
WSTB_412	WST_412	WST_412	Stress au travail - collègues facilitaient le travail	Même	Modifiée		On a ajouté la catégorie de réponse « Sans objet ».
WSTB_413	WST_413	WST_413	Stress au travail - satisfait de son travail	Même	Même		
WSTBDSKI	WSTDSKI	WSTDSKI	Stress au travail - latitude de décision/compétence - (D)	Modifiée	Même	On a changé les conditions dans les spécifications des variables dérivées.	
WSTBDAUT	WSTDAUT	WSTDAUT	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)	Modifiée	Même	On a changé les conditions dans les spécifications des variables dérivées.	
WSTBDPSY	WSTDPSY	WSTDPSY	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)	Même	Même		
WSTBDJIN	WSTDJIN	WSTDJIN	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)	Même	Même		
WSTBDPHY	WSTDPHY	WSTDPHY	Stress au travail - effort physique - (D)	Même	Même		
WSTBDSOC	WSTDSOC	WSTDSOC	Stress au travail - soutien social - (D)	Modifiée	Même	On a changé les conditions dans les spécifications des variables dérivées.	On a ajouté la catégorie de réponse « Sans objet » aux variables d'entrée.
	WSTDJST	WSTDJST	Stress au travail - contraintes au travail - (D)	Modifiée	Ajoutée	On a changé les conditions dans les spécifications des variables dérivées.	

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
		SDC_027	Service militaire canadien	Ajoutée			
	SDC_7AA	SDC_037	Orientation sexuelle	Modifiée	Ajoutée	La formulation des questions a été mise à jour pour répondre aux nouvelles normes de contenu harmonisé.	
		SORSI	Identité sexuelle	Ajoutée			
		SORLGBTS	Statut LGBTQ2+	Ajoutée			
		IMM_01	Lieu de naissance	Ajoutée			
		IMM_01A1	Province ou territoire de naissance	Ajoutée			
		IMM_01A2	Pays de naissance	Ajoutée			
SDCBCCB	SDCCCB10	SDCCCOB	Pays de naissance - (C)	Même	Modifiée		
SDCBGCB	SDCGCB10	SDCDVCB	Pays de naissance - groupée (G)	Même	Modifiée		On a changé les conditions de variables dérivées
	SDC_3	IMM_02	Année d'arrivée	Ajoutée			
		IMM_03	Statut d'immigrant	Ajoutée			
SDCB_3	SDC_3	IMM_04	Année d'immigration	Même	Même		
SDCBDAIM	SDCDAIM	SDCDAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	Même	Même		
SDCBFIMM	SDCFIMM	SDCFIMM	Immigrant - (I)	Même	Même		
	SDC_41	ABM_01A	Autochtone - Première Nation/ Métis/ Inuit	Même	Ajoutée		
	SDC_42A	ABM_01B	Autochtone - Première nation	Même	Ajoutée		
	SDC_42B	ABM_01C	Autochtone - Métis	Même	Ajoutée		
	SDC_42C	ABM_01D	Autochtone - Inuit	Même	Ajoutée		
	SDCDABT	SDCDABT	Identité autochtone - (D)	Modifiée	Ajoutée	Les conditions de la variable dérivée ont changé, le concept	

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
						est resté inchangé. Voir spécifications de la VD.	
SDCB_7A	SDC_43A	PG_05A	Origines culturelles/raciales - Blanc	Même	Modifiée		On a changé le libellé de la question
SDCB_7B	SDC_43C	PG_05B	Origines culturelles/raciales - Sud-Asiatique	Même	Modifiée		On a changé le libellé de la question
SDCB_7B	SDC_43B	PG_05C	Origines culturelles/raciales - Chinois	Même	Modifiée		On a changé le libellé de la question
SDCB_7D	SDC_43D	PG_05D	Origines culturelles/raciales - Noir	Même	Modifiée		On a changé le libellé de la question
SDCB_7E	SDC_43E	PG_05E	Origines culturelles/raciales - Philippin	Même	Modifiée		On a changé le libellé de la question
SDCB_7H	SDC_43H	PG_05F	Origines culturelles/raciales - Arabe	Même	Modifiée		On a changé le libellé de la question
SDCB_7F	SDC_43F	PG_05G	Origines culturelles/raciales - Latino-Américain	Même	Modifiée		On a changé le libellé de la question
SDCB_7G	SDC_43G	PG_05H	Origines culturelles/raciales - Asiatique du Sud-Est	Même	Modifiée		On a changé le libellé de la question
SDCB_7I	SDC_43I	PG_05I	Origines culturelles/raciales - Asiatique Occidental	Même	Modifiée		On a changé le libellé de la question
SDCB_7K	SDC_43K	PG_05J	Origines culturelles/raciales - Coréen	Même	Modifiée		On a changé le libellé de la question
SDCB_7J	SDC_43J	PG_05K	Origines culturelles/raciales - Japonais	Même	Modifiée		On a changé le libellé de la question

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
		VMRNIE	Appartenance à des groupes raciaux / culturels - minorité visible n.i.a.	Ajoutée			
		VMROTHER	Appartenance à des groupes raciaux / culturels - pas de minorité visible	Ajoutée			
SDCBDRAC	SDCDCGT	SDCDVVM	Minorité visible du répondant - (D)	Modifiée	Modifiée		On a changé les conditions de variables dérivées
SDCBDRES	SDCDRES	SDCDRES	Durée de temps au Canada depuis immigration - (D)		Même		
		SDCDCFL	Première langue officielle apprise encore comprise - Langue maternelle				
		SDCDVFLA	Minorité visible	Ajoutée			
EDUB_4	EDU1_4	EDU_05	Plus haut certificat/ diplôme obtenu	Même	Même		
		ADM_035	Permission de partager les données	Ajoutée	Modifiée		
		ADM_037	Permission de partager les données jumelées	Ajoutée			
SAMDSHR	SAMDSHR	SAMDSHR	Permission de partager les données - (D)	Même	Même		
SAMDLNK	SAMDLNK	SAMDLNK	Permission sur le jumelage de données - (D)	Même	Même		
		INCP2019	Revenu personnel de toutes provenances pour 2019	Ajoutée			

Variables 2002	Variables 2012	Variables 2022	Concept	État 2022	État 2012	Changement Fait 2022	Changement Fait 2012
		INCP2020	Revenu personnel de toutes provenances pour 2020	Ajoutée			
		INCH2020	Revenu des ménages, toutes provenances confondues, pour 2020	Ajoutée			
		INCDVP19	Revenu personnel de toutes les provenances pour 2019 - groupé	Ajoutée			
		INCDVP20	Revenu personnel de toutes les provenances pour 2020- groupé	Ajoutée			
		INCDVHH	Revenu des ménages, toutes provenances confondues, pour 2020 - groupé	Ajoutée			
		DABTIPPE	Décile de revenu avant impôt du quartier (en RMR/CA)	Ajoutée			
		DNBTIPPE	Décile de revenu du quartier avant impôts (national)	Ajoutée			
WTSB_M	WTS_M	WTS_M	Poids - Maître	Même	Même		

Annexe B :

WHO-CIDI Troubles mentaux et troubles liés à une substance - Variables primaires pour l'analyse et variables comparables pour 2022, 2012 et 2002

Cette liste des variables primaires des troubles pour l'analyse résume les variables associées aux algorithmes finaux. Voir les spécifications des variables dérivées (VD) pour une description plus détaillée de ces variables et de toutes les variables composantes. Étant donné que l'ensemble des troubles mesurés en 2022 diffère de ceux mesurés en 2012 et en 2002, les variables résumées en annexe ne sont pas comparables d'une enquête à l'autre. Les variables de l'ESCC 2012 - Santé mentale et de l'ESCC 2002 - Santé mentale et bien-être ne sont mentionnées que si elles sont comparables à celles de 2022.

Concept	Variables 2022	Variables 2012	Variables 2002
Tout trouble sélectionné (mental ou avec substances) - vie (I)	MHPFL		
Tout trouble sélectionné (mental/substances) - 12 m - (I)	MHPFY		
Tout trouble sélectionné (mental/subst)-Interfère -12 m (I)	MHPFINT		
Tout trouble de l'humeur - vie - (I)	MHPFLM		
Tout trouble de l'humeur - 12 m - (I)	MHPFYM		
Épisode dépressif majeur - Algorithme - vie - (D)	DEPDDPS	DEPDDPS	DEPBDDPS
Épisode dépressif majeur - Algorithme - 12 m - (D)	DEPDDY	DEPDDY	DEPBDDY
Épisode dépressif majeur - Plus récent épisode - âge - (D)	DEPDREC	DEPDREC	DEPBDREC
Épisode dépressif majeur - persistance - années - (D)	DEPDPER	DEPDPER	DEPBDPER
Indicateur : dépression - Interférence - 12 m - (I)	DEPFINT	DEPFINT	DEPBFINT
Dépression - Interférence - Moyenne - 12 m - (D)	DEPDINT	DEPDINT	DEPBDINT
Indicateur : suicide - pensée - vie - (I)	DEPFSLT	DEPFSLT	DEPBFSLT
Indicateur : suicide - projet - vie - (I)	DEPFSLP	DEPFSLP	
Indicateur : suicide - tentative - vie - (I)	DEPFSLA	DEPFSLA	DEPBFSLA
Indicateur : suicide - pensée - 12 m - (I)	DEPFSYT	DEPFSYT	DEPBFSYT, DEPBISYT (imputation flag)
Indicateur : suicide - projet - 12 m - (I)	DEPFSYP	DEPFSYP	
Indicateur : suicide - tentative - 12 m - (I)	DEPFSYA	DEPFSYA	DEPBFSYA, DEPBISYA (imputation flag)
Trouble Bipolaire - Algorithme - vie - (D)	BIPDL	BIPDL	
Trouble Bipolaire - Algorithme - 12 m - (D)	BIPDY	BIPDY	
Trouble bipolaire - Interférence - Moyenne - (D)	BIPDINT	BIPDINT	
Indicateur: trouble bipolaire - Interférence - (I)	BIPFINT	BIPFINT	
Trouble bipolaire I - Algorithme - vie - (D)	BIPD1	BIPD1	
Trouble bipolaire I - Algorithme - 12 m - (D)	BIPD1Y	BIPD1Y	
Indicateur: trouble bipolaire I - Interférence - (I)	BIPFINT1	BIPFINT1	
Trouble bipolaire I - Interférence - Moyenne - (D)	BIPDINT1	BIPDINT1	
Trouble bipolaire II - Algorithme - vie - (D)	BIPD2	BIPD2	
Trouble bipolaire II - Algorithme - 12 m - (D)	BIPD2Y	BIPD2Y	
Indicateur: trouble bipolaire II - Interférence - (I)	BIPFINT2	BIPFINT2	

Concept	Variables 2022	Variables 2012	Variables 2002
Trouble bipolaire II - Interférence - Moyenne - (D)	BIPDINT2	BIPDINT2	
Manie - Algorithme 2002 - vie - (D)	MIADEPS	MIADEPS	MIABDEPS
Manie - Algorithme 2002 - 12 m - (D)	MIADEY	MIADEY	MIABDEY
Manie - Plus récent épisode - âge (D)	MIADREC	MIADREC	MIABDREC
Manie - Persistance - années - (D)	MIADPER	MIADPER	MIABDPER
Indicateur : Manie - Interférence - 12 m - (I)	MIAFINT	MIAFINT	MIABFINT
Manie - Interférence - Moyenne - 12 m - (D)	MIADINT	MIADINT	MIABDINT
Trouble d'anxiété généralisée - algorithme - vie - (D)	GADDGDS	GADDGDS	
Trouble d'anxiété généralisée - algorithme - 12 m - (D)	GADDDY	GADDDY	
Trble anx gén - Plus récent épisode - âge - (D)	GADDREC	GADDREC	
Trble anx gén - Plus long épisode - durée - (D)	GADD05Y	GADD05Y	
Trouble d'anxiété généralisée - Interférence - 12 m - (I)	GADFINT	GADFINT	
Trouble d'anxiété généralisée-Interférence -Moyenne-12 m (D)	GADDINT	GADDINT	
Algorithme pour la phobie sociale vie	SOPD02		SOPBBDSP
Algorithme pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois	SOPDPY		SOPBDPY
Phobie sociale - âge au moment de l'épisode le plus récent	SOPDREC		SOPBDREC
Trouble attribuable à la phobie sociale - moyenne	SOPDINT		SOPBDINT
Indicateur de la perturbation attribuable à la phobie sociale	SOPFINT		SOPBFINT
Tout trouble lié utilisation substances (alcool/drog)-vie(I)	MHPFLSA		
Tout trouble lié utilisation substances (alcool/drog)-12m(I)	MHPFYSA		
Abus ou dépendance à l'alcool - Algorithme - vie - (D)	AUDDL	AUDDL	
Abus ou dépendance à l'alcool - Algorithme - 12 m - (D)	AUDDY	AUDDY	
Abus d'alcool - Algorithme - vie - (D)	AUDDLA	AUDDLA	
Abus à l'alcool - Algorithme - 12 m - (D)	AUDDYA	AUDDYA	
Dépendance à l'alcool - Algorithme - vie - (D)	AUDDLD	AUDDLD	
Dépendance à l'alcool - Algorithme - 12 m - (D)	AUDDYD	AUDDYD	
Indicateur : alcool - Interférence - 12 m - (I)	AUDFINT	AUDFINT	
Alcool - Interférence - Moyenne - 12 m - (D)	AUDDINT	AUDDINT	
Abus ou dépendance au cannabis - vie - (D)	SUDDLC	SUDDLC	
Abus ou dépendance au cannabis - 12 m - (D)	SUDDYC	SUDDYC	
Abus de cannabis - Algorithme - vie - (D)	SUDDLCA	SUDDLCA	
Abus de cannabis - Algorithme - 12 m - (D)	SUDDYCA	SUDDYCA	
Dépendance au cannabis - Algorithme - vie - (D)	SUDDLCD	SUDDLCD	
Dépendance au cannabis - Algorithme - 12 m - (D)	SUDDYCD	SUDDYCD	
Abus ou dépendance au drogues (excl cann) - vie - (D)	SUDDLO	SUDDLO	
Abuse ou dépendance aux drogues (excl cann) - 12 m - (D)	SUDDYO	SUDDYO	
Abus de drogues (excl cann) - Algorithme - vie - (D)	SUDDLOA	SUDDLOA	
Abus de drogues (excl cann) - Algorithme - 12 m - (D)	SUDDYOA	SUDDYOA	
Dépendence aux drogues (excl cann) - Algorithme - vie - (D)	SUDDLOD	SUDDLOD	
Dépendance aux drogues (excl cann) - Algorithme - 12 m - (D)	SUDDYOD	SUDDYOD	
Consommation de drogues - Interférence - 12 m - (I)	SUDFINT	SUDFINT	
Consommation de drogues - Interférence - Moyenne - 12 m (D)	SUDDINT	SUDDINT	